

\$CATEGORY: Раздел_ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ {

- =глюкозы крови
 - ~глюкозы мочи
 - ~инсулина крови
 - ~кетоновых тел крови
- }

ВЕС БЕЗВОДНОЙ ГЛЮКОЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ (Г) {

- =75
 - ~100
 - ~50
 - ~125
- }

УРОВЕНЬ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СОСТАВЛЯЕТ (%) {

- =6,5
 - ~5,5
 - ~5,0
 - ~6,0
- }

ПАЦИЕНТУ 50 ЛЕТ С ОЖИРЕНИЕМ И ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ УРОВНЕМ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК 8,0 ММОЛЬ/Л НЕОБХОДИМО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПРОВЕСТИ {

- =повторное определение глюкозы плазмы натощак
 - ~глюкозо-толерантный тест
 - ~определение глюкозы в моче
 - ~определение инсулина в крови
- }

ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ УРОВЕНЬ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА {

- =понижен
 - ~повышен
 - ~не изменяется
 - ~зависит от возраста пациента
- }

ПОЯВЛЕНИЕ У ЮНОШИ 18 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЖАЖДЫ, ПОЛИУРИИ, ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ДО 16 ММОЛЬ/Л, НАЛИЧИЯ АЦЕТОНА В МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О {

=сахарном диабете 1 типа

~сахарном диабете 2 типа

~сахарном диабете вследствие болезни экзокринной части поджелудочной железы

~MODY-диабете

}

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ НАТОЩАК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СОСТАВЛЯЕТ (ММОЛЬ/Л) {

=7,0

~6,0

~6,5

~6,1

}

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ 55 ЛЕТ С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 38,0 ГЛИКЕМИИ НАТОЩАК 11,5 ММОЛЬ/Л НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ БУДЕТ {

=«сахарный диабет 2 типа»

~«сахарный диабет 1 типа»

~«сахарный диабет вследствие болезни экзокринной части поджелудочной железы»

~«латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA)»

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИРЕОТОКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ {

=трийодтиронина и тироксина крови

~холестерина крови

~антител к тиреоидной пероксидазе

~пролактина

}

ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ ХАРАКТЕРНО {

=развитие фибрилляции предсердий

~снижение периферического сопротивления сосудов

~наличие стойкой брадикардии

~наличие стойкой гипотензии

}

АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ, БАГРОВЫЕ ПОЛОСЫ РАСТЯЖЕНИЯ (СТРИИ) НА КОЖЕ ЖИВОТА У БОЛЬНОГО 40 ЛЕТ СО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА ПЛАЗМЫ МОГУТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ {

=болезни Иценко-Кушинга

~хронической надпочечниковой недостаточности

~алиментарного ожирения

~сахарного диабета

}

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ «СТЕРОИДНОГО ДИАБЕТА» У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ {

=активация глюконеогенеза в печени

~стимуляция липолиза

~катаболизм белка в скелетной мускулатуре

~аутоиммунное разрушение бета-клеток

}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=брадикардия

~кахексия

~тахикардия

~тремор

}

ДЛЯ II СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (КГ/М²) {

=35,0-39,9

~30,0-34,9

~25,0-29,9

~20,0-24,9

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {

=уровня ТТГ

~уровня антител к тиреоидной пероксидазе

~экскреции йода с мочой

~уровня пролактина

}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=гипотензия

~гипергликемия

~ожирение

~гипертензия

}

ПРИ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ {

=коллапса

~артериальной гипертензии

~гипергликемии

~отеков

}

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА {

=аденома гипофиза, секретирующая адренокортикотропный гормон

~опухоль надпочечников, секретирующая кортизол

~недостаточная секреция адренокортикотропного гормона гипофизом

~аденома гипофиза, секретирующая соматотропный гормон

}

ДЛЯ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНО {

=увеличение размеров кистей и стоп

~значительное снижение массы тела

~увеличение линейного роста

~сухость кожных покровов

}

УРОВНЕМ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММОЛЬ/Л) {

=11,1

~11,0

~10,0

~9,0

}

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ПЕРВОГО ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ {

=инсулином

~сахароснижающими препаратами группы сульфаниламидов

~сахароснижающими препаратами группы бигуанидов

~голоданием

}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТИАМАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ {

=агранулоцитоз

~беременность

~старческий возраст

~гиповолемия

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИМЕНЯЮТ {

=Гидрокортизон

~Инсулин

~0,9% раствор Натрия хлорида

~Мезатон

}

ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ТЕРАПИЮ НАЧИНАЮТ С
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ {

=40% раствора глюкозы

~5% раствора глюкозы

~0,9% раствора натрия хлорида

~препаратов калия

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ
ПРИМЕНЯЮТ {

=Метформин

~Инсулин

~производные сульфонилмочевины

~ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа

}

ПОКАЗАТЕЛЕМ, НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНО ОТРАЖАЮЩИМ СТЕПЕНЬ
КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ
НАБЛЮДЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=гликозилированный гемоглобин

~гликемия натощак

~постпрандиальная гликемия

~глюкозурия

}

ДИАГНОЗ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ УРОВНЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (%) {

- =>6,5
 - ~>6,0
 - ~>6,8
 - ~>7,0
- }

ПРАВИЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =прием 75 грамм глюкозы, растворенных в воде
 - ~соблюдение безуглеводной диеты в течение 3 дней
 - ~отказ от обеда и ужина накануне проведения пробы
 - ~прием 100 грамм глюкозы, растворенных в воде
- }

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {

- =гликированного гемоглобина
 - ~постприандиальной гипергликемии
 - ~гликемии через 10 часов после приема пищи
 - ~отношения проинсулина к инсулину
- }

РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ПОВЫШЕН У {

- =женщин, родивших ребенка массой более 4,5 кг.
 - ~людей, часто болеющих вирусными инфекциями
 - ~людей, в возрасте до 1 года, получавших коровье молоко
 - ~женщин, родивших ребенка массой менее 2,5 кг.
- }

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ {

- =среднего уровня гликемии за 2-3 месяца
 - ~среднего уровня гликемии за 5-6 месяцев
 - ~среднего уровня гликемии за 2-3 недели
 - ~степени тяжести течения сахарного диабета
- }

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =гипогликемия
- ~снижение массы тела
- ~повышение уровня тромбоцитов

~повышение уровня лейкоцитов
}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=сахарный диабет 2 типа
~сахарный диабет 1 типа
~выраженное повышение массы тела
~выраженная инсулинорезистентность
}

ПРИ ДОКАЗАННОЙ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ НАЗНАЧАЮТ {

=ингибиторы АПФ
~петлевые диуретики
~блокаторы Р-адренорецепторов
~блокаторы α-адренорецепторов
}

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ РЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=лазерная фотокоагуляция
~назначение ангиопротекторов
~назначение рассасывающих препаратов
~склеротерапия сосудистого русла
}

ПРЕПАРАТОМ, МАСКИРУЮЩИМ ГИПОГЛИКЕМИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=Бисопролол
~Нифедипин
~Индапамид
~Фуросемид
}

МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ
ПЛАЗМЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ В
ПОЛЬЗУ ДИАГНОЗА «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ», СОСТАВЛЯЕТ (ММОЛЬ/Л)

{
=11,1
~6,1
~9,7
~15
}

ГЕСТАЦИОННОЙ НАЗЫВАЮТ АГ, КОТОРАЯ {

=развилась после 20 недели беременности и исчезает в течение 12 недель после родов
~зарегистрирована во время первого триместра беременности
~развилась после 20 недели беременности и сохраняется более 12 недель после родов
~сопровождается протеинурией
}

ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ, НА КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЕТИТЬ НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=вероятность наличия ИБС
~верификация ИБС
~наличие перенесенного в прошлом инфаркта миокарда
~наличие клапанной патологии
}

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА {

=утолщение пальцев рук, увеличение нижней челюсти, увеличение размера стопы
~тремор рук и век, потливость, снижение веса, повышение температуры тела
~гиперемия лица, истончение кожи, отложение жира в области живота, багровые стрии
~сухость кожи, выпадение волос, снижение температуры тела
}

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА {

=тремор рук и век, потливость, снижение веса, сердцебиение
~утолщение пальцев рук, увеличение нижней челюсти, увеличение размера стопы
~гиперемия лица, истончение кожи, отложение жира в области живота, багровые стрии
~сухость кожи, выпадение волос, снижение температуры тела
}

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С ГИПЕРПРОДУКЦИЕЙ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА, ЯВЛЯЕТСЯ {

=акромегалия
~гиперкортицизм
~гиперпаратиреоз
~синдром «пустого турецкого седла»
}

ПРИЧИНОЙ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ГОРМОНА {
=дефицит антидуретического (АДГ)

~дефицит соматотропного (СТГ)
~избыток антидиуретического (АДГ)
~избыток соматотропного (СТГ)
}

МЕТФОРМИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРОРАЛЬНЫМ
САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ КЛАССА {
=бигуанидов
~ингибиторов альфа-глюкозидаз
~ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа
~ингибиторов дипептидилпептидазы-4
}

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ {
=ановуляция, поликистоз по результатам сонографии, гиперандрогения
~алопеция, биохимическая гиперандрогения
~олигоменорея, поликистоз по результатам сонографии
~задержка полового развития, гиперандрогения
}

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В
ДИАГНОСТИКЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ {
=17-гидроксипрогестерон
~кортизол
~дигидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)
~индекс инсулинорезистентности НОМА
}

В ДИАГНОСТИКЕ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛИЗ {
=суточной мочи на метанефрин и норметанефрин
~суточной мочи на ванилилминдальную кислоту (ВМК)
~крови на электролиты, активность ренина плазмы
~крови на ренин и альдостерон с определением альдостерон-ренинового
соотношения
}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {
=тонкоигольная аспирационная биопсия
~сцинтиграфия с радиоизотопами йода 131
~ультразвуковое исследование
~пальпаторное исследование

}

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ТРАКЦИОННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=терминальная стадия ретинопатии

~глаукома

~автономная нейропатия

~макулярный отек и атрофия зрительного нерва

}

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ НАГРУЗКИ ГЛЮКОЗОЙ В ХОДЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ (ММОЛЬ/Л) {

=7,8

~6,1

~7,0

~6,4

}

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1 ВОЗНИКАЮТ НА СТАДИИ {

=90% деструкции бета-клеток

~полной деструкции Р-клеток

~прогрессивного снижения 1 фазы секреции инсулина

~инициации иммунных процессов

}

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ {

=инсулинорезистентности и относительного дефицита инсулина

~генетически обусловленных дефектов функции бета-клеток поджелудочной железы

~аутоиммунной деструкции бета-клеток поджелудочной железы

~опухоли или травмы поджелудочной железы

}

ГЛЮКАГОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ {

=а-клетками поджелудочной железы

~Р-клетками поджелудочной железы

~L-клетками ЖКТ

~5-клетками поджелудочной железы

}

К БИГУАНИДАМ ОТНОСИТСЯ {

=Метформин

~Глибенкламид
~Репаглинид
~Пиоглитазон
}

К ФАКТОРАМ РИСКА, ПРОВОЦИРУЮЩИМ РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО ОЖИРЕНИЯ, ОТНОСИТСЯ {

=энергетический дисбаланс между поступлением и расходом энергии
~тяжелый физический труд, употребление высококалорийной пищи
~вирусные инфекции~опухоли головного мозга
}

ИНСУЛИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ {

=Р-клетками
~а-клетками
~5-клетками
~РР-клетками
}

С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ПРИЕМА ПИЩИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА ДОЛЖНО ПРОЙТИ (ЧАС) {

=не менее 8
~не менее 6
~не менее 10
~не более 8
}

ПРОЛАКТИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ КЛЕТКАМИ {

=передней доли гипофиза
~задней доли гипофиза
~промежуточной доли гипофиза
~вентромедиальных ядер гипоталамуса
}

ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=диастема
~сухость кожи
~склонность к запорам
~алопеция
}

САНДОСТАТИН ЛАР ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ {

- =аналогов соматостатина
- ~антагонистов рецепторов соматотропного гормона (СТГ)
- ~агонистов дофамина
- ~ингибиторов соматолиберина

}

НОРМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН {

- =составляет до 18 мл
- ~составляет до 25 мл
- ~составляет до 20 мл
- ~зависит от возраста

}

УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОКАЗАНО {

- =при выявлении пальпируемого образования в проекции железы
- ~всем пациентам старше 50 лет
- ~всем беременным женщинам, проживающим в регионе умеренного йодного дефицита
- ~всем детям, проживающим в регионе умеренного йодного дефицита

}

ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

- =подострого тиреоидита
- ~цитокин-индуцированного тиреоидита
- ~послеродового тиреоидита
- ~острого гнойного тиреоидита

}

АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРУ ТТГ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ {

- =болезни Грейвса-Базедова
- ~хронического аутоиммунного тиреоидита
- ~послеродового тиреоидита
- ~цитокин-индуцированного тиреоидита

}

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 1997 ГОДА ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОЦЕНКЕ {

- =индекса массы тела
- ~массы тела
- ~окружности талии
- ~соотношения окружности талии к окружности бедер

}

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК СООТНОШЕНИЕ {
=массы тела в кг к росту в м
~массы тела в кг к росту в метрах
~роста в см к массе тела в кг
~массы тела в кг к росту в см²
}

АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ У ЖЕНЩИН БЕЛОЙ РАСЫ
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ БОЛЕЕ (СМ) {
=80
~94
~90
~92
}

АУТОИММУННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ В-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ {
=сахарного диабета 1 типа
~сахарного диабета 2 типа
~гестационного сахарного диабета
~генетических форм сахарного диабета (mody и др.)
}

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1
ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ {
=Инсулин
~Глибенкламид
~Метформин
~Глипизид
}

ДЛЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГ А ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ {
=багровых полос растяжения
~артериальной гипотонии
~дефицита массы тела
~снижения уровня сахара крови
}

К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ОСМОТРЕ
БОЛЬНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ОТНОСЯТ {
=снижение массы тела, возбудимость
~отёчность век, кистей, стоп
~наличие ломких, сухих, часто выпадающих волос
~медлительность, заторможенность, сонливость
}

ДЛЯ АДДИСОНОВОЙ БОЛЕЗНИ (ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ) ХАРАКТЕРЕН ТАКОЙ СИМПТОМ КАК {

- =гиперпигментация кожи
 - ~артериальная гипертония
 - ~повышение массы тела
 - ~повышенный аппетит
- }

ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ХАРАКТЕРНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ {

- =микроальбуминурии
 - ~массивной протеинурии
 - ~лейкоцитурии
 - ~гематурии
- }

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПРОВОДИТСЯ {

- =анализ мочи на микроальбуминурию
 - ~бактериальный посев мочи
 - ~анализ мочи по Нечипоренко
 - ~проба по Зимницкому
- }

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ КОНЦЕНТРАЦИИ {

- =тиреоидных гормонов и тиреотропного гормона
 - ~антител к тканевой пероксидазе и тиреоглобулину
 - ~холестерина
 - ~глюкозы
- }

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МАЛИГНИЗАЦИЮ УЗЛА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ {

- =пункционную биопсию
 - ~радиоизотопное сканирование
 - ~ультразвуковое исследование
 - ~компьютерную томографию
- }

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЛЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение эхогенности и неоднородная эхоструктура

~наличие единичного узлового образования

~наличие множественных узловых образований

~увеличение объёма

}

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ {

=вес, деленный на рост в метрах в квадрате

~вес, деленный на рост в метрах

~рост, деленный на вес в килограммах в квадрате

~рост, деленный на вес в килограммах

}

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЖИРЕНИЯ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (КГ/М2) {

=30-34,9

~35-40

~20-24,9

~25-29,9

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ПРОВОДИТСЯ {

=анализ мочи по Зимницкому

~анализ мочи по Нечипоренко

~двухстаканная проба

~тест с нагрузкой глюкозой

}

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ИНФОРМАТИВНО ИССЛЕДОВАНИЕ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ {

=свободных метанефрина и норметанефрина

~альдостерона

~кортизола

~калия и натрия

}

В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ {

=препараты инсулина

~бигуаниды

~инкретины

~препараты сульфонилмочевины

}

АНТИТИРЕОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЛЕЧЕНИИ {
=диффузного токсического зоба
~острого тиреоидита
~подострого тиреоидита
~гипотиреоза
}

К ТИРЕОСТАТИКАМ ОТНОСИТСЯ {
=Пропилтиоурацил
~Левотироксин
~Пропранолол
~Бисопролол
}

ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ {
=Сибутрамин
~Активированный уголь
~Гипотиазид
~препараты сенны
}

ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ {
=Орлистат
~Спиронолактон
~Левотироксин
~Калия йодид
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ {
=препараты десмопрессина
~препараты инсулина пролонгированного действия
~глюкокортикоиды
~аналоги соматостатина
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДНИЗОЛОН И {
=Флудрокортизон, Гидрокортизон
~Флудрокортизон, Левотироксин
~Калия хлорид, Адреналин
~Дексаметазон, Кордиамин
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ {

=ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора
~диуретики
~препараты калия и магния
~препараты витамина D
}

ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНО {
=снижение уровня тироксина, повышение уровня тиреотропного гормона
~повышение уровня тироксина, повышение уровня тиреотропного гормона
~снижение уровня тироксина, снижение уровня тиреотропного гормона
~повышение уровня тироксина, снижение уровня тиреотропного гормона
}

К ТАБЛЕТИРОВАННЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ
ОТНОСИТСЯ {
=Метформин
~Эксенатид
~Лираглутид
~Гларгин
}

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ {
=инсулином
~препаратами сульфонилмочевины
~агонистами глюкагоноподобного пептида 1
~бигуанидами
}

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ {
=гипогликемических состояниях
~вторичной резистентности к пероральным препаратам
~гестационном диабете
~сахарном диабете 1 типа
}

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА РЕКОМЕНДУЕТСЯ {
=употреблять йодированную поваренную соль
~диета с ограничением легкоусвояемых углеводов
~употребление импортных продуктов
~всегда применять спиртовую настойку йода
}

К ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ТКАНЯМ В ОРГАНИЗМЕ ОТНОСЯТ {
=мышечную, жировую

- ~хрусталик глаза
- ~соединительную ткань
- ~клетки крови

}

РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 1 СВЯЗАНО С {

- =аутоиммунной деструкцией В-клеток
- ~резистентностью инсулинозависимых тканей
- ~снижением массы тела
- ~панкреатэктомией

}

К ОСНОВНОМУ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМУ МЕХАНИЗМУ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ {

- =инсулинорезистентность и гиперинсулинемия
- ~деструкция В-клеток
- ~ожирение
- ~инсулинопения

}

К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСЯТ {

- =неадекватную инсулинотерапию
- ~оперативное вмешательство
- ~сопутствующие заболевания (пневмонию, инфаркт миокарда, пиелонефрит)
- ~беременность

}

ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ {

- =дегидратации организма
- ~дефицита инсулина
- ~низкого уровня глюкозы крови
- ~инфекционного заболевания

}

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУСЛОВЛЕНО {

- =повышенным уровнем инсулина в крови
- ~пониженным уровнем инсулина в крови
- ~гиперлипидемией
- ~сопутствующим инфекционным заболеванием

}

В ОСНОВЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ЛЕЖИТ {

- =инсулинотерапия

~прием пероральных сахароснижающих препаратов
~диетотерапия
~лечебная физкультура
}

ПОНЯТИЕ «ХЛЕБНАЯ ЕДИНИЦА» ВКЛЮЧАЕТ УГЛЕВОДЫ В КОЛИЧЕСТВЕ (Г) {
=10-12
~20-23
~4-6
~17-19
}

ДОЗУ ИНСУЛИНА ПО КОЛИЧЕСТВУ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ В РАЦИОНЕ РАСЧИТЫВАЮТ ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА {
=тип 1
~тип 2
~тип MODY
~любого типа
}

ПРЕПАРАТЫ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ВЛИЯЮТ НА {
=бета-клетки
~инсулинорезистентность
~гормоны желудочно-кишечного тракта
~аппетит
}

САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТФОРМИНА ОБУСЛОВЛЕНО ВЛИЯНИЕМ НА {
=чувствительность тканей к инсулину
~функцию бета-клеток
~аппетит
~массу тела
}

К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНЫ ОТНОСЯТ {
=нарушение кровотока
~микротравмы
~отморожение
~гипогликемию
}

К ФАКТОРАМ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОТНОСЯТ {

=инсулинорезистентность
~нарушения липидного обмена
~гипергликемию
~неправильный образ жизни
}

ПРИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОМ СИНДРОМЕ ПРИСУТСТВУЕТ ТИП ОЖИРЕНИЯ {

=центральный
~бедренно-ягодичный
~равномерный
~умеренный
}

К ПРОЯВЛЕНИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ОТНОСЯТ {

=слабость, жажду, полиурию
~прибавку массы тела
~боли в мышцах
~зуд кожи
}

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК В ПЛАЗМЕ КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ ДО (ММОЛЬ/Л) {

=6,0
~7,8
~5,5
~10,0
}

ГЛИКЕМИЯ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ В НОРМЕ КОНСТАТИРУЕТСЯ ПРИ УРОВНЕ ГЛЮКОЗЫ ДО { (ММОЛЬ/Л)

=7,8
~10,1
~8,5
~9,2
}

НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=дислипидемией
~гиперкетонемией и кетонурией
~гиперхолестеринемией
~снижением уровня бета-липопротеидов
}

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=микроальбуминурия

~гематурия

~полиурия

~лейкоцитурия

}

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=спонтанными переломами

~появлением трофических язв

~усилением болевого синдрома

~гипокальцемией

}

АВТОНОМНАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

{

=нарушением сердечного ритма

~болевым синдромом

~тремором конечностей

~радикулопатией

}

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ РАЗВИВАЕТСЯ {

=сустав Шарко

~варикозная язва

~перелом

~нарушение трофики кожных покровов

}

ДЕЙСТВИЕ ИНСУЛИНА СВЯЗАНО С {

=анаболическим эффектом

~катаболическим эффектом

~усилением липолиза

~усилением глюконеогенеза

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРЕПАРАТАМИ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ {

=гипогликемического состояния

~кетонацидоза

~гиперосмолярного состояния

~гиперурикемии
}

ЙОД ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОРМОНОВ {
=щитовидной железы
~гипофиза
~надпочечников
~половых
}

ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОНТРОЛИРУЮТ {
=рост, развитие, энергообеспечение клеток
~расщепление энергосубстратов, катаболизм клеток
~кальциевый обмен в клетках
~углеводный обмен в клетках
}

ОБЪЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ {
=18 мл - у женщин, 25 мл - у мужчин
~более 25 мл независимо от пола
~менее 18 мл независимо от пола
~24 мл - у женщин, 30 мл - у мужчин
}

ПРОДУКТОМ ПРЕВРАЩЕНИЯ РЕВЕРСИВНОГО Т3 ЯВЛЯЕТСЯ {
=свободный Т4
~общий Т3
~тиреоглобулин
~тиреотропный гормон
}

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА НА ФУНКЦИЮ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ {
=по принципу обратной связи с уровнем йодтиронинов в крови
~посредством прямой стимулирующей связи на щитовидную железу
~через тиреолиберин
~через центральную нервную систему
}

ТИРЕОЛИБЕРИН СИНТЕЗИРУЕТСЯ В {
=гипоталамусе
~гипофизе
~щитовидной железе
~коре головного мозга
}

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЙОДА В РЕГИОНЕ ИССЛЕДУЮТ {
=экскрецию йода с мочой в группе риска
~уровень тиреотропного гормона в крови у населения
~уровень свободного Т4 в крови
~объем щитовидной железы
}

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ {
=ультразвуковое исследование
~классификацию О. В. Николаева
~классификацию ВОЗ (1994 г.)
~классификацию ВОЗ (2001 г.)
}

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТИРЕОТОКСИКОЗА РАЗВИВАЮТСЯ {
=при болезни Грэйвса
~после операции на щитовидной железе
~при аутоиммунном тиреоидите
~при остром тиреоидите
}

К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДИФFUЗНОГО
ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ОТНОСЯТ {
=миопатию и тахикардию
~гиперхолестеринемию
~сухость кожи
~гипотонию
}

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ {
=фибрилляцией предсердий
~брадикардией
~стенокардией
~инфарктом миокарда
}

ЭНДОКРИННАЯ ОФТАЛЬМОПАТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ {
=аутоиммунного процесса в ретробульбарной клетчатке
~повышения тонуса глазодвигательных мышц
~воспалительного процесса тканей глаза
~токсического влияния гормонов щитовидной железы
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ {

- =тонкоигольную пункционную биопсию
 - ~сканирование щитовидной железы
 - ~исследование уровня антител к тиреоглобулину
 - ~компьютерную томографию щитовидной железы
- }

ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

- =диффузно неоднородной структурой
 - ~кистозными образованиями
 - ~увеличением объема щитовидной железы
 - ~множественными узловыми образованиями
- }

ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ {

- =брадикардии, отеков
 - ~снижения массы тела
 - ~тахикардии, потливости
 - ~увеличения щитовидной железы, тремора
- }

ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ {

- =стероидов
 - ~аминокислот
 - ~белков
 - ~углеводов
- }

ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ АДДИСОНА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ {

- =гидрокортизон
 - ~преднизолон
 - ~дексаметазон
 - ~диету с повышенным содержанием соли и углеводов
- }

В МОЗГОВОМ СЛОЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ СИНТЕЗИРУЮТСЯ {

- =катехоламины
 - ~стероидные гормоны
 - ~половые гормоны
 - ~гормоны белковой природы
- }

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО- КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ {

=повышенного образования глюкокортикостероидов

~повышенного образования катехоламинов

~активности симпатической нервной системы

~активности ренин-ангиотензиновой системы

}

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ СИНДРОМЕ ИЦЕНКО-КУШИНГ А ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ {

=катаболических процессов в костной ткани

~недостатка витамина Д

~повышения уровня паратгормона в крови

~снижения уровня кальцитонина

}

ГОРМОНОМ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=соматотропный гормон

~соматолиберин

~антидиуретический гормон

~прогестерон

}

К ГОРМОНАМ ГИПОТАЛАМУСА ОТНОСЯТСЯ {

=тиреолиберин, соматостатин

~тироксин, тиреотропный гормон

~пролактин, лютеотропный, фолликулостимулирующий гормон

~гонадотропины

}

ВЛИЯНИЕ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА НА ТКАНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ {

{

=через инсулиноподобные факторы роста-1

~через периферические гормоны

~через эндогенные факторы роста

~непосредственно

}

ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО {

=снижение распада жиров

~повышение рН крови

~появление ацетона в моче

~наличие гипергликемии

}

СРЕДИ ВСЕХ ВИДОВ ТРАВМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕОБЛАДАЮТ {

=ушибы и растяжения

~переломы и вывихи

~ожоги и отморожения

~инородные тела

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОТОМИКОЗ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ {

=в наружном слуховом проходе

~в послеоперационной полости

~на ушной раковине

~в среднем ухе

}

АДАПТАЦИЯ ГЛАЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=приспособлением глаз к различным уровням яркости света

~способностью глаза различать свет видением предметов при слабом освещении

~ухудшением цветового зрения

}

ПРОЯВЛЕНИЕМ БОЛЕЗНИ СЪЕГРЕНА (ШЕГРЕНА) СО СТОРОНЫ
ОРГАНА ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=сухой кератоконъюнктивит

~склерит

~отслойка сетчатки

~ячмень

}

ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ИСТОЧНИКОМ СТРЕПТОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ ПРИ УВЕИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=тонзиллит

~язвенный колит

~пневмония

~кариес

}

У БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=ячмень

~халязион

~блефарит

~эписклерит

}

ГЛАУКОМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ {

=повышением внутриглазного давления выше толерантного уровня

~аномалиями рефракции

~помутнением хрусталика

~воспалением зрительного нерва

}

РОГОВИЧНЫЙ СИНДРОМ ВКЛЮЧАЕТ {

=слезотечение, светобоязнь, блефароспазм

~эктропион, экзофтальм, эпифору

~птоз, миоз

~симблефарон, лагофтальм

}

К ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЯМ КОНЪЮНКТИВЫ ОТНОСЯТ {

=меланому

~гемангиому

~невусы

~липомы

}

АНГИОПРОТЕКТОРЫ НАЗНАЧАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ {

=укрепить сосудистую стенку

~улучшить проходимость слезных путей

~ликвидировать процессы воспаления

~ускорить заживление раневого канала в роговице

}

ФЕНОМЕНОМ «УТРЕННЕЙ ЗАРИ» СЧИТАЮТ {

=утреннюю гипергликемию, обусловленную повышением секреции контринсулярных гормонов

~снижение уровня глюкозы крови в ответ на введение инсулина

~исчезновение симптомов вторичного сахарного диабета при болезни Кушинга после двусторонней адреналэктомии

~утреннюю гипергликемию после ночной гипогликемии

}

ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ СЧИТАЮТ {

=гипергликемию, впервые выявленную во время беременности, но не соответствующую критериям «манифестного» сахарного диабета

~любое значение гликемии, превышающее нормальный уровень глюкозы во время беременности

~гипергликемию, впервые выявленную во время беременности или в течение года после родов

~гипергликемию, обусловленную сниженной продукцией кортизола у беременной женщины
}

МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ {

=иммобилизации пораженной конечности

~вазоактивных препаратов

~препаратов альфа-липоевой кислоты

~нестероидных противовоспалительных препаратов

}

ДИАГНОЗ «СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» СТАВЯТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ {

=язвенного дефекта подошвы стопы и сенсорно-моторной нейропатии

~сухости кожных покровов стоп

~выраженной деформации пальцев

~снижения чувствительности в области стоп

}

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И СНИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ГЛЮКОЗЫ ПЕЧЕНЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ {

=Метформин

~Натеглинид

~Глибенкламид

~Акарбозу

}

ТРЕТЬЕЙ А СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 3А) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2) {

=45-59

~30-44

~15-29

~10-14

}

ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 4) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2) {

=15-29

~45-59

~30-44

~60-89

}

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ТИРЕОИДНЫХ И ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО МАНИФЕСТНОГО ГИПОТИРЕОЗА {

- =Т4 - снижен; ТТГ - повышен
 - ~Т4 - снижен; ТТГ - в норме
 - ~Т4 - снижен; ТТГ - снижен
 - ~Т4 - в норме; ТТГ - повышен
- }

ТЕСТОМ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ {

- =тиреотропного гормона
 - ~общего тироксина
 - ~свободного тироксина
 - ~трийодтиронина
- }

ЗАБОЛЕВАНИЕМ НАДПОЧЕЧНИКОВ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ {

- =кортикостерома
 - ~феохромоцитома
 - ~вторичный гиперальдостеронизм
 - ~соматотропинома
- }

ИССЛЕДОВАНИЕ СУТОЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ МЕТАНЕФРИНОВ (МЕТЕНЕФРИНА И НОРМЕТАНЕФРИНА) В МОЧЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ ДИАГНОЗ {

- =Феохромоцитома
 - ~болезнь Кушинга
 - ~первичный гиперальдостеронизм
 - ~первичный гипокортицизм
- }

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ОПУХОЛЬ {

- =передней доли гипофиза
 - ~клубочковой зоны коры надпочечников
 - ~пучковой зоны коры надпочечников
 - ~сетчатой зоны коры надпочечников
- }

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ {

- =синтеза антидиуретического гормона в ядрах гипоталамуса
- ~синтеза антидиуретического гормона в задней доле гипофиза

~секреции инсулина
~секреции глюкагона
}

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМА КУШИНГА ПРОВОДЯТ ПРОБУ С {

=Дексаметазоном
~Преднизолоном
~Кортизолом
~АКТГ
}

К ГОРМОНАМ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА ОТНОСИТСЯ {

=Пролактин
~окситоцин
~кортиколиберин
~соматостатин
}

\$CATEGORY: Раздел_ТЕРАПИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ВАГУСНЫХ ПРОБ МОЖЕТ ПРЕРВАТЬ ПРИСТУП {

=предсердной пароксизмальной тахикардии
~фибрилляции желудочков
~фибрилляции предсердий
~желудочковой пароксизмальной тахикардии
}

ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИ МАЛЕЙШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ДАВЯЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, КУПИРУЮЩЕЙСЯ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА, СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О СТЕНОКАРДИИ {

=напряжения функциональный класс IV
~напряжения функциональный класс III
~прогрессирующей
~вариантной
}

ДЫХАНИЕ СО СТРИДОРОМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ {

=бронхиальной астме
~опухоли крупных бронхов
~опухоли гортани
~аспирации инородного тела
}

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КАШЛЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ {

=3 месяца в течение 2 лет подряд

~2 месяца в течение 2 лет подряд

~3 месяца в течение 1 года

~1 месяц в течение 1 года

}

МОКРОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАТАРАЛЬНОМ БРОНХИТЕ БЫВАЕТ

{

=слизистой

~«ржавой»

~розовой пенистой

~стекловидной

}

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ {

=сухих хрипов

~звонких влажных мелкопузырчатых хрипов

~крепитации

~шума трения плевры

}

«МИТРАЛИЗАЦИЕЙ» АОРТАЛЬНОГО ПОРОКА НАЗЫВАЮТ {

=компенсаторную гиперфункцию левого предсердия при снижении сократительной функции левого желудочка

~сочетание аортального и митрального стенозов

~присоединение митрального стеноза к уже существующему аортальному пороку вследствие повторной ревматической лихорадки

~сочетание стеноза устья аорты и пролапса митрального клапана

}

БОЛЬНОМУ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ, ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИСТУПОВ АРИТМИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ {

=Амиодарон

~Хинидин

~Дигоксин

~Лаппаконитина гидробромид (Аллапинин)

}

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=кашель

~кровохарканье
~одышка
~свистящее дыхание
}

ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=увеличение PQ более 200 мс
~постепенное удлинение PQ с последующим выпадением QRS
~независимые сокращения предсердий и желудочков
~выпадение QRS без постепенного удлинения PQ
}

К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА ОТНОСИТСЯ {
=Амиодарон
~Хинидин
~Лидокаин
~Пропафенон
}

СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ
ЯВЛЯЮТСЯ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ФЕНОМЕНОМ {
=нарушения бронхиальной проходимости
~наличия жидкости в плевральной полости
~повышения воздушности лёгочной ткани
~уплотнения лёгочной ткани
}

ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СРЕДНЕТЕЖЁЛОГО
ТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {
=ОФВ1 от 60% до 80% от должных величин
~вариабельностью ПСВ < 20%
~ночными приступами удушья реже 1 раза в неделю
~ежедневными ночными приступами удушья
}

ПО СПИРОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВЫДЕЛЯЮТ СТАДИИ ХОБЛ {
=4
~3
~2
~5
}

К ОСНОВНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ХОБЛ
ОТНОСЯТ {

=сухие свистящие хрипы
~крепитацию
~влажные мелкопузырчатые хрипы
~влажные крупнопузырчатые хрипы
}

ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ
ПРОХОДИМОСТИ ПРИ ХОБЛ, ВЫСТУПАЕТ {
=ОФВ1
~ФЖЕЛ
~ЖЕЛ
~ОФВ1/ФЖЕЛ
}

ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {
=пиковой скорости выдоха
~дыхательного объёма
~жизненной ёмкости лёгких
~остаточного объёма
}

ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ
ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=бронхогенный
~гематогенный
~лимфогенный
~травматический
}

ПРИЗНАКУ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ {
=гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту
~картину ателектаза
~тяжистый лёгочный рисунок
~очаговые тени
}

АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ
СЕРДЦА ВКЛЮЧАЕТ {
=усиление первого тона и диастолический шум
~ослабление первого тона и систолический шум
~неизмененные тоны и «мягкий, дующий» систолический шум
~ослабление второго тона и диастолический шум
}

ШУМ ПРИ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ {

=проводится в левую подмышечную область

~проводится на сонные артерии

~никуда не проводится

~проводится в яремную ямку

}

В ОТНОШЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА {

=антибактериальная терапия должна проводиться парентерально

~кортикостероиды должны обязательно назначаться с первых дней лечения

~длительность антибактериальной терапии составляет 2 недели

~развитие миокардита является показанием к оперативному лечению

}

ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ВСТРЕЧАЕТСЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ В АРТЕРИЮ {

=легочную

~селезеночную

~мезентериальную

~почечную

}

У ЖЕНЩИНЫ 50 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ И **СУХОЙ КАШЕЛЬ**, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТЕРАПИИ ОТХАРКИВАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И АНТИБИОТИКАМИ, (НЕ КУРИТ, АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ НЕ ОТЯГОЩЕН, НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО). НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ КАШЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ {

=ингибиторов АПФ

~блокаторов ангиотензиновых рецепторов

~диуретиков

~блокаторов кальциевых каналов

}

К ПРЕПАРАТАМ, УЛУЧШАЮЩИМ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА, ОТНОСЯТ {

=Добутамин

~Атропин

~Атенолол

~Триметазидин

}

К ТИПИЧНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСЯТ {

=тромбоз коронарной артерии вследствие надрыва атеросклеротической бляшки

~увеличение потребности миокарда в кислороде

~нарушение коронарной гемодинамики вследствие падения артериального давления

~врожденные особенности строения коронарных артерий

}

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ {

=наркотические анальгетики

~ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа

~анальгетики-антипиретики

~селективные ингибиторы циклооксигеназы 2 типа

}

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА НА ЭКГ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ {

=сегмента ST

~зубца Р

~комплекса QRS

~интервала PQ

}

К ТИПИЧНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ {

=давящие боли за грудиной, возникающие при физической нагрузке

~колющие боли в области левой лопатки

~тупые ноющие боли в правой половине грудной клетки

~иррадиацию боли в правую руку

}

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ {

=гиперхолестеринемия

~нарушение ритма и проводимости сердца

~врожденный порок сердца

~артериальная гипотония

}

ДЕЙСТВИЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕНО {

=прямым миолитическим действием на гладкую мускулатуру коронарных артерий

~рефлекторным увеличением частоты сердечных сокращений
~снижением сократимости левого желудочка
~рефлекторным урежением частоты сердечных сокращений
}

К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДИЕТЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ {

=ограничение потребления жидкости
~ограничение потребления сахара
~ограничение потребления белков
~увеличение в рационе поваренной соли
}

ЗАСТОЙ ПО МАЛОМУ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИВОДИТ К {

=отеку легких
~почечной недостаточности
~асциты
~отекам голеней
}

К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ SERДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ {

=одышку
~головную боль
~боли в суставах
~ноющие боли в области сердца
}

ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ» СТАВИТСЯ ПРИ КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ
(МЕС.) {

=6
~1
~3
~9
}

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕПАТИТЫ БЫВАЮТ {

=инфекционные
~травматические
~алиментарные
~системные
}

К ПРОЯВЛЕНИЯМ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ОТНОСЯТ {

=артралгию

~кольцевидную эритему

~реактивный гастрит

~асцит

}

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЮТ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ {

=гамма-ГТ и щелочной фосфатазы

~АЛТ

~АСТ

~АЛТ и АСТ

}

К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩИМ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С, ОТНОСЯТ {

=гепатоцеллюлярную карциному

~рак желудка

~рак легких

~лимфому

}

ГИПЕРСПЛЕНИЗМОМ НАЗЫВАЮТ {

=интенсификацию элиминации форменных элементов крови

~увеличение размеров селезенки

~расширение диаметра селезеночной вены

~интенсификацию кровоснабжения селезенки

}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ {

=расширения вен нижней трети пищевода

~расширения подкожных вен нижних конечностей

~гепатомегалии

~спленомегалии

}

О РАЗВИТИИ РАКА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА МОЖНО ПОДОЗРЕВАТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ В КРОВИ {

=альфа-фетопротейна

~АСТ

~иммуноглобулина А

~холинэстеразы
}

ДИАГНОЗ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ» ПОДТВЕРЖДЕН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В
БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ {

=нарушенного долькового строения
~ступенчатых некрозов гепатоцитов
~стеатоза гепатоцитов
~расширенных портальных трактов
}

ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ СЛЕДУЕТ ПРИ {

=«печеночном» запахе
~нарастании интенсивности желтухи
~лихорадке
~геморрагическом диатезе
}

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=выявление бактериурии
~выявление антител к базальной мембране клубочков
~наличие гематурии
~наличие протеинурии
}

СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ УМЕНЬШЕНИЕМ
СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ
В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ {

=анемией
~агранулоцитозом
~микроцитозом
~макроцитозом
}

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА (Г/Л) {

=70-89
~90-120
~менее 70
~90-130
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВАЖНЕЙШИМ
КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ {

=суточной протеинурии более 3,5 г
~отёков
~уровня сывороточного альбумина ниже 30 г/л
~гиперхолестеринемии
}

НАИМЕНЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ {

=поликистоз почек
~гломерулонефрит
~миеломная болезнь
~диабетическая нефропатия
}

В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ {

=креатинина
~мочевины
~остаточного азота
~мочевой кислоты
}

ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=изъязвление и гиперемия слизистой оболочки кишки
~сужение просвета кишки
~тотальная атрофия слизистой оболочки
~геморроидальный узел
}

ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЗАТРАГИВАЕТ {

=слизистую оболочку
~все слои кишки
~подслизистую оболочку
~мышечную оболочку
}

В СТАДИИ РЕМИССИИ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ {

=неизменная слизистая оболочка
~слизистая в виде «булыжной мостовой»
~слизистая с эрозиями
~контактная кровоточивость слизистой оболочки
}

ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ПОРАЖАЮТСЯ {

=все слои кишечника

~слизистый и подслизистый слои

~подслизистый и мышечный слои

~мышечный слой и серозная оболочка

}

ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=вздутие живота и понос при употреблении злаков

~рвота с примесью желчи

~неустойчивый стул при употреблении молочных продуктов

~запор

}

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ {

=коленные

~лучезапястные

~челюстно-лицевые

~пястно-фаланговые

}

В ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ {

=антитела к цитрулинированному пептиду

~повышенного уровня мочевой кислоты

~диспротеинемии

~анемии

}

УЗЕЛКИ БУШАРА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ОСТЕОАРТРОЗА {

=проксимальных межфаланговых суставов кисти

~дистальных межфаланговых суставов кисти

~первого плюснефалангового сустава

~локтевого сустава

}

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=гемолитической анемии

~апластической анемии

~хронической свинцовой интоксикации

~дефицита эритропоэтина

}

К ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ {

~незапланированный дополнительный прием пищи

=передозировка инсулина

~неожиданная чрезмерная физическая нагрузка

~прием алкоголя

}

К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ТИРЕОТОКСИКОЗА НЕ ОТНОСЯТ {

=запоры

~возбудимость, раздражительность

~потерю веса

~повышение аппетита

}

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПОТИРЕОЗА НЕ ОТНОСЯТ {

=тахикардию

~сонливость

~запоры

~сухость кожных покровов

}

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА НАЛИЧИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПЕРТИРЕОЗА, ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение тиреотропного гормона

~повышение тиреотропного гормона повышение тироксина

~снижение тироксина

}

НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=определение уровня ферритина

~расчет цветового показателя

~определение количества эритроцитов

~определение уровня гемоглобина

}

СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ {

=извращением вкуса (pica chlorotica)

~кожным зудом

~прогрессированием онихомикоза

~изменением дистальных фаланг пальцев по типу барабанных палочек

}

НА СТАДИИ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ
ВЫЯВЛЯТЬСЯ {

=снижение сывороточного железа

~снижение уровня гемоглобина

~снижение гематокрита

~ретикулоцитоз

}

ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение общей железосвязывающей способности

~наличие мишеневидных эритроцитов

~микросфероцитоз

~снижение ОЖСС

}

ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТ {

=антикоагулянты

~Ацетилсалициловую кислоту

~Клопидогрел

~Тикагрелор

}

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ {

=аспирина

~антагонистов кальция

~сердечных гликозидов

~лидокаина

}

МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ
ОСЛОЖНЯЕТСЯ {

=расслаивающей аневризмой аорты

~ишемическим инсультом

~острым коронарным синдромом

~нарушением ритма сердца

}

ПРИ ОРВИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ {

=Парацетамола

~Ампициллина

~Бисептола

~Аспирин
}

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА
ВКЛЮЧАЮТ {

=тошноту, рвоту, боли в эпигастрии, понос, запоры

~экстрасистолию, головную боль

~боли в области сердца

~потерю сознания, тахикардию

}

МОНОТЕРАПИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У
БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ
НАЗНАЧЕНА {

=пациенту с АГ I степени с низким или средним риском сердечно-
сосудистых осложнений

~пациенту с АГ I степени с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений

~пациенту с АГ II степени с высоким риском сердечно-сосудистых
осложнений

~всем пациентам с АГ I степени независимо от степени риска сердечно-
сосудистых осложнений

}

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ {

=неселективные Р-адреноблокаторы

~антибиотики

~метилксантины

~симпатомиметики

}

КУПИРОВАНИЕ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА НАЧИНАЕТСЯ С
НАЗНАЧЕНИЯ {

=нитроглицерина сублингвально

~нитратов внутривенно капельно

~спазмолитиков

~наркотических анальгетиков

}

ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ {

=ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента

~антагонистов кальция (фенилалкиламинов)

~ингибиторов фосфодиэстеразы

~ингибиторов карбоангидразы

}

ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ СТЕНОКАРДИИ ТАКТИКА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ВКЛЮЧАЕТ {

=снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, аспирин, госпитализацию

~снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, амбулаторное лечение

~выдачу направления на плановую госпитализацию

~амбулаторное обследование

}

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ {

=международное нормализованное отношение (МНО)

~время кровотечения

~тромбиновое время

~уровень ретикулоцитов

}

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ ЧЕРЕЗ {

=2-3 дня

~12 часов

~1 сутки

~5 дней

}

ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ {

=бета-адреноблокаторы

~диуретики

~блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда

~ингибиторы АПФ

}

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ С ПРОТЕИНУРИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ {

=комбинированная терапия, включающая ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (ингибитор АПФ или сартан)

~диуретики

~бета-адреноблокаторы

~блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда

}

ТАКТИКА ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГРИППА, ВЫЗВАННОГО ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ А (H1N1), ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

В НАЗНАЧЕНИИ МГ ОСЕЛЬТАМИВИРА 2 РАЗА В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЕЙ {

- =75, 5
 - ~150, 5
 - ~150, 10
 - ~75, 10
- }

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ОТНОСЯТ {

- =полипы кишечника
 - ~геморрой
 - ~дивертикулярную болезнь кишечника
 - ~язвы кишечника
- }

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ИБС ЯВЛЯЕТСЯ {

- =артериальная гипертензия
 - ~употребление алкоголя
 - ~этническая принадлежность
 - ~характер трудовой деятельности
- }

ПРИЧИНАМИ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =недостаточное употребление мясной пищи
 - ~высокая физическая активность
 - ~недостаточное употребление свежих овощей и фруктов
 - ~недостаточное употребление фруктов и овощей, содержащих железо
- }

ПРИ НОРМОВЕНТИЛЯЦИИ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ {

- ~12-16
 - ~8-10
 - =16-20
 - ~20-22
- }

ПРЕДНАГРУЗКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ {

- =объёмом циркулирующей крови и тонусом вен
- ~количеством эритроцитов

~тонусом артериол
~уровнем АД
}

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ СОСТОИТ В {
=осуществлении гемостаза
~переносе антител
~переносе белков
~выработке тромбopoэтина
}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=клиническая смерть
~отсутствие сознания
~анафилаксия
~биологическая смерть
}

СООТНОШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ К ВДОХАМ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ СОСТАВЛЯЕТ {
=30:2
~5:1
~15:2
~15:1
}

ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=хирургический
~лучевая терапия
~электрокоагуляция
~химиотерапия
}

ПУЛЬСОКСИМЕТР ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О НАСЫЩЕНИИ {
=гемоглобина кислородом
~венозной крови кислородом
~артериальной крови углекислым газом
~гемоглобина углекислым газом
}

ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ {
=симптом очков
~анизокория

~красный дермографизм
~подвижность костей черепа
}

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ
АНАЛЬГЕТИКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Налоксон
~Атропин
~Флумазенил
~Аминостигмин
}

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Флумазенил
~Налоксон
~Атропин
~Панангин
}

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ {

=Унитиол
~Рибоксин
~Панангин
~Допамин
}

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ ОТ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ И
ЗАМЕЩЕНИЕ ЕЕ ДОНОРСКОЙ ПЛАЗМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ {

=плазмаферезом
~гемофильтрацией
~гемодиализом
~ультрафильтрацией
}

ГЕМОДИАЛИЗ ПОКАЗАН ПРИ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ {

=почечной
~сердечной
~печеночной
~дыхательной
}

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ
АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Натрия гидрокарбонат

~Атропин
~Адреналин
~Дигоксин
}

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ПРОТЕКАЮЩИЙ С АБСОЛЮТНОЙ
ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К {
=1 типу
~2 типу
~гестационному
~стероидному
}

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ {
=антигенов HLA DR-3, DR-4
~антител к инсулину
~инсулинорезистентности
~С-пептида
}

ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНО {
=повышение ТТГ и снижение Т4
~снижение ТТГ и повышение Т4
~нормальный ТТГ и снижение Т4
~снижение ТТГ и Т4
}

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ГИПОТИРЕОЗА
ЯВЛЯЮТСЯ {
=отеки, зябкость, заторможенность, сухость кожи
~ожирение, гипертония, одышка
~потливость, сонливость, нарушение координации
~снижение памяти, головная боль, анорексия
}

ПАТОГНОМОНИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ
АДДИСОНОВОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=гиперпигментация кожи
~похудание
~диспептический синдром
~артралгия
}

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ {

=аутоиммунного тиреоидита
~поражения гипофиза
~разрушения гипоталамуса
~нарушения чувствительности тканей к тиреоидным гормонам
}

ВТОРИЧНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ {
=поражения гипофиза
~разрушения гипоталамуса
~нарушения чувствительности тканей к тиреоидным гормонам
~аутоиммунного тиреоидита
}

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ ПЕРВИЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО
ГИПОКОРТИЦИЗМА ОТНОСЯТ {
=аутоиммунную атрофию коры надпочечников
~туберкулёз надпочечников
~двустороннюю адреналэктомию
~метастазы опухолей
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ МЕТОДОМ
ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ {
=лазерная фотокоагуляция
~применение Децинона
~применение Трентала
~применение Диабетона
}

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ САХАРОСНИЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ {
=стимуляция секреции инсулина
~подавление продукции глюкозы печенью
~снижение инсулинорезистентности
~торможение всасывания глюкозы в кишечнике
}

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИШЕМИИ
МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=преходящее горизонтальное смещение сегмента ST на 1 мм и более
~формирование отрицательного зубца Т
~появление блокады правой ножки пучка Гиса
~появление предсердной экстрасистолии
}

РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=уменьшение индекса Тиффно

~уменьшение пиковой скорости выдоха

~увеличение объема форсированного выдоха за первую секунду

~уменьшение жизненной ёмкости лёгких

}

РАННИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение уровня АЦЦП

~узурация суставных поверхностей

~появление ульнарной девиации суставов кисти

~повышение уровня мочевой кислоты

}

О СОСТОЯНИИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ {

=относительная плотность мочи

~гематурия

~лейкоцитурия

~протеинурия

}

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНЕВРИЗМЫ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ {

=длительный подъем ST выше изолинии («застывшая» ЭКГ)

~коронарный зубец T в соответствующих отведениях

~снижение амплитуды зубца R в соответствующих отведениях

~появление зубца Q в соответствующих отведениях

}

ЭКГ-ДИАГНОСТИКУ ИНФАРКТА МИОКАРДА УСЛОЖНЯЕТ {

=блокада левой ножки пучка Гиса

~фибрилляция предсердий

~желудочковая экстрасистолия

~атриовентрикулярная блокада 1 степени

}

ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С {

=Амоксициллина (или защищенного аминопенициллина) или макролидов

~тетрациклинов

~цефалоспоринов

~Гентамицина
}

НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение массы тела

~снижение конечного диастолического давления в правом желудочке

~снижение частоты сердечных сокращений

~уменьшение размеров печени

}

К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПО ИТОГАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОТНОСЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ {

=здоровые, в том числе имеющие факторы риска при низком и среднем
сердечнососудистом риске

~нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи

~не предъявляющие жалоб

~с впервые выявленными хроническими заболеваниями в стадии ремиссии

}

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО
{

=отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных
видов медицинских вмешательств

~самостоятельно расширить объем диспансеризации либо отказаться от
отдельных видов медицинских вмешательств

~отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных
видов медицинских вмешательств по решению суда

~отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных
видов медицинских вмешательств, если он не работает

}

ПРИ КАРАНТИНЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ {

=врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом

~только врачом-терапевтом участковым

~заведующим отделением

~врачом-эпидемиологом

}

В РОССИИ ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=болезни системы кровообращения, внешние причины, новообразования

~болезни системы кровообращения, инфекционные заболевания, болезни
органов дыхания

~болезни органов дыхания, внешние причины, заболевания ЖКТ

~новообразования, заболевания ЖКТ, патология опорно-двигательного аппарата
}

К МОДИФИЦИРУЕМЫМ (УПРАВЛЯЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ОТНОСЯТ {

=вредные для здоровья факторы поведенческого характера (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание)

~пол

~возраст

~наследственность

}

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ В ГОРОДЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ {

=1700

~1500

~1200

~1300

}

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ ПАЦИЕНТА ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРВИЧНО {

=в регистратуре

~на приеме врача

~при проведении диспансеризации

~на дому

}

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ {

=органам, организациям, суду, имеющим право на получение сведений о факте состояния его здоровья и диагнозе

~родителям

~мужу или жене

~работодателю

}

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ {

=относится к диагностическому отделению поликлиники

~относится к отделению профилактики поликлиники

~относится к лечебному отделению поликлиники

~является самостоятельным подразделением

}

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ
ВЗРОСЛЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ
ПРОДЛИТЬ НА СРОК ДО (ДЕНЬ) {

=7

~15

~30

~45

}

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ {

=одному из членов семьи (опекуну), непосредственно осуществляющему
уход

~любому члену семьи по желанию больного

~только одному из родителей

~только матери

}

РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РОГОВИЦЫ ХАРАКТЕРНО
ДЛЯ КЕРАТИТА {

=герпесвирусного

~туберкулёзно-метастатического

~туберкулёзно-аллергического

~паренхиматозного

}

КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ В СЕТЧАТКЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ {

=новообразование

~извитость

~сужение

~расширение

}

К ЧИСЛУ ВОЗМОЖНЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
АБСЦЕССА ВЕК ОТНОСИТСЯ {

=тромбоз кавернозного синуса

~ползучая язва роговицы

~флегмона слезного мешка

~гнойный иридоциклит

}

С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГОНОБЛЕННОРЕИ В ОБА ГЛАЗА
НОВОРОЖДЕННЫМ ИНСТИЛЛИРУЮТ РАСТВОР {

=Сульфацил натрия
~Бактериофага стафилококкового
~Левомецитина
~Пенициллина
}

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ИЗБЫТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АККОМОДАЦИИ НЕОБХОДИМО {

=соблюдение режима зрительной нагрузки
~закапывание слезозаменителей
~прием витаминов внутрь
~проведение фототерапии
}

РАННИМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=полиаденопатия
~потеря массы тела более 10%
~боли в правой подвздошной области
~потемнение мочи
}

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ {

=двоение в глазах
~паралич диафрагмы
~задержка стула
~нормотермия
}

ТИПИЧНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=колит
~гастрит
~энтерит
~гастроэнтерит
}

ЯРКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ В СОЧЕТАНИИ С ЛИХОРАДКОЙ СВОЙСТВЕННА {

=роже
~абсцессу
~флегмоне
~плоскому лишая
}

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ СЫПЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С НЕКРОЗАМИ
В ЦЕНТРЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

=менингококковой инфекции

~энтеровирусной инфекции

~стрептодермии

~герпес зостер инфекции

}

ЗУД В ОБЛАСТИ АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ {

=энтеробиозе

~тениозе

~клонорхозе

~диффилоботриозе

}

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «САЛЬМОНЕЛЛЕЗ» ПРОВОДЯТ {

=бактериологическое исследование кала

~общий анализ крови

~общий анализ мочи

~вирусологическое исследование кала

}

ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ГРИППА НАЗНАЧАЮТ {

=Осельтамивир (Тамифлю)

~Антигриппин

~Парацетамол

~Санорин

}

К НАСЛЕДСТВЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ДИАТЕЗАМ
ОТНОСИТСЯ {

=болезнь Виллебранда

~ДВС синдром

~Болезнь Вальденстрема

~болезнь Маркиафавы Микели

}

СУБСТРАТОМ ОПУХОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО {

=гранулоциты

~миелобласты

~плазмоциты

~эритрокариоциты

}

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ГЕМОФИЛИИ А ОБУСЛОВЛЕН ДЕФИЦИТОМ {

=VIII фактора

~антитромбина III

~протеина C

~образования тромбоцитов

}

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В БИОПТАТЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА {

=клеток Березовского - Штернберга

~плазматических клеток

~моноцитов

~лимфоцитов

}

ДЕСТРУКЦИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ {

=множественной миеломе

~талассемии

~апластической анемии

~эритремии

}

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АРТРИТА ПРИ ОБОСТРЕНИИ В ПЕРВОМ ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

=подагры

~ревматоидного артрита

~псориаза

~болезни Рейтера

}

СИНДРОМ УТРЕННЕЙ СКОВАННОСТИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ {

=ревматоидного артрита

~деформирующего остеоартроза

~подагры

~болезни Рейтера

}

АУТОИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ {

=ревматоидного артрита

~подагры

~остеоартроза

~болезни Рейтера

}

СИНДРОМ ДРЕССЛЕРА РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ {
=острого инфаркта миокарда
~внебольничной пневмонии
~острого миокардита
~острого гастрита
}

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ КРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ИНФАРКТЕ
МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ КРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ {
=тромбоз
~ишемия
~некроз
~амилоидоз
}

ОСОБЕННОСТЬЮ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ
КАРДИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=снижение ударного объема и сердечного выброса
~повышение фракции выброса левого желудочка
~запаздывание открытия митрального клапана
~уменьшение диастолического объема левого желудочка
}

ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ РАЗВИВАЕТСЯ {
=относительная коронарная недостаточность
~неспецифический коронариит
~спазм коронарных артерий
~острый тромбоз коронарных артерий
}

АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫПОТА В ПЛЕВРАЛЬНУЮ
ПОЛОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ {
=резкое ослабление дыхания
~амфорическое дыхание
~крепитация шум трения плевры
}

ТРЕУГОЛЬНАЯ ИНФИЛЬТРАТИВНАЯ ТЕНЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ
ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {
=ТЭЛА
~аспирационной пневмонии
~параканкротической пневмонии
~шокового легкого

}

ЗАТЯЖНОЙ НАЗЫВАЮТ ПНЕВМОНИЮ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ БОЛЕЕ {

=четыре недели

~двух недель

~двух месяцев

~шести месяцев

}

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ {

=коробочный перкуторный звук

~удлинённый вдох

~влажные хрипы

~бронхиальное дыхание

}

ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ (СИНДРОМЕ КОННА) ОТМЕЧАЮТ {

=гипокалиемию, полидипсию, полиурию, судороги

~гиперкалиемию, гипергликемию, полиурию

~повышение относительной плотности мочи

~резкое снижение относительной плотности мочи

}

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ С ВЫРАЖЕННОЙ ПОТЛИВОСТЬЮ, ТАХИКАРДИЕЙ И ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ {

=феохромоцитомой

~синдромом Конна

~гипертонической болезнью

~острым гломерулонефритом

}

ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ПОВЫШАЕТСЯ ВЫРАБОТКА {

=адреналина

~пролактина

~тестостерона

~альдостерона

}

ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, УВЕЛИЧЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ АНЕМИИ {

=гемолитической

~В12-дефицитной

~железодефицитной

~апластической
}

ДЛЯ БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ {

=отсутствие пульса на одной из рук

~геморрагической пурпуры

~сетчатого ливедо

~кровохарканья

}

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=*Helicobacter pylori*

~нарушение диеты

~курение

~нарушение моторики желудка

}

ДЛЯ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=диарея

~рвота

~запор

~абдоминальная боль

}

УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ КАК ВНЕКИШЕЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ {

=болезни Крона

~дивертикулярной болезни кишечника

~псевдомембранозного колита

~синдрома раздраженного кишечника

}

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ГЛИАДИНУ И ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ {

=глютеновой энтеропатии

~язвенном колите

~болезни Крона

~синдроме раздраженного кишечника

}

БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ {

=ингаляционные глюкокортикостероиды
~бета-2-агонисты
~метилксантины
~муколитики
}

РЕФЛЕКТОРНОЕ КУПИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ВОЗМОЖНО ПРИ {

=суправентрикулярной тахикардии
~полной АВ-блокаде
~желудочковой тахикардии
~частой экстрасистолии
}

К ПРЕПАРАТАМ ЗАМЕДЛЕННОГО МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА ОТНОСЯТ {

=хондропротекторы
~глюкокортикостероиды
~нестероидные противовоспалительные препараты
~цитостатики
}

В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ {

=ингибиторов АПФ
~Метилдопы
~блокаторов кальциевых каналов
~бета-адреноблокаторов
}

ПРИ СИНДРОМЕ КОННА ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ {

=Спиронолактон
~Индапамид
~Метопролол
~Лизиноприл
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ИСПОЛЬЗУЮТ {

=Сульфасалазин
~Амоксициллин
~Тетрациклин
~Панкреатин
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ИСПОЛЬЗУЮТ {

=Рабепразол
~Дротаверина гидрохлорид
~Лактулозу
~Рифаксимин
}

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПЕРВИЧНОГО ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ
{
=менингококк
~стрептококк
~стафилококк
~энтерококк
}

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОЧАГОВЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ В
ТЕЧЕНИЕ СУТОК ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {
=преходящего нарушения мозгового кровообращения
~тромбоза наружной сонной артерии
~спонтанного субарахноидального кровоизлияния
~ишемического инсульта
}

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ {
=прогноза потомства
~обследования группы риска по данному заболеванию
~лечения
~изучения эпидемиологии данного заболевания
}

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ {
=блокада цитохрома А3
~ингибирование ферментов цикла Кребса
~образование метгемоглобина
~образование роданидов
}

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПЕРВИЧНОЙ ГИПОКСИЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=гемическая
~тканевая
~циркуляторная
~гипоксическая
}

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ОТ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАЩИЩАЮТ МАТЕРИАЛЫ, В КОТОРЫХ ПРЕОБЛАДАЮТ {

=тяжелые металлы

~легкие металлы

~водород

~сера

}

ТКАНЬЮ, НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К ДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=костный мозг

~эндотелий

~нервная

~паренхима внутренних органов

}

НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЛУЧЕННОЙ КЛЕТКИ ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ {

=нуклеиновых кислот

~белков

~липополисахаридов

~полисахаридов

}

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ С ИХ НАРАСТАНИЕМ В КОРОТКИЙ СРОК В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВВОДИТСЯ {

=карантин

~изоляция

~индикация

~обсервация

}

ПРЕХОДЯЩИЕ СИМПТОМЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИШЕМИЕЙ ТКАНЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, НО НЕ ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ ИНФАРКТА ИШЕМИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=транзиторной ишемической атаки

~внутри мозгового кровоизлияния

~субарахноидального кровоизлияния

~ишемического инсульта

}

ОСТРОЕ НАЧАЛО ИНСУЛЬТА С ВНЕЗАПНЫМ ПОЯВЛЕНИЕМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У БОДРСТВУЮЩЕГО ПАЦИЕНТА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В АНАМНЕЗЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=кардиоэмболического подтипа ишемического инсульта

~лакунарного подтипа ишемического инсульта

~атеротромботического подтипа ишемического инсульта

~нетравматического субарахноидального кровоизлияния

}

ДВУСТОРОННИЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, СЖИМАЮЩИЕ ГОЛОВУ В ВИДЕ «ОБРУЧА», УМЕНЬШАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ОТДЫХА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

{

=головных болей напряжения

~мигренозного приступа с аурой

~гипертензионных головных болей

~медикаментозных головных болей

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА - КОНОВАЛОВА ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {

=церулоплазмина сыворотки

~креатинфосфокиназы в крови

~уровня белка Бенс-Джонса в моче

~уровня цианкоболамина в крови

}

ОСТРЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ С НАРУШЕНИЕМ СОЗНАНИЯ, ПСИХОМОТОРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ, ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИПАДКАМИ, ГРУБЫМ МЕНИНГЕАЛЬНЫМ СИНДРОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=субарахноидального кровоизлияния

~кардиоэмболического подтипа ишемического инсульта

~острого рассеянного энцефаломиелита

~острого течения клещевого энцефалита

}

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОКНО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА СОСТАВЛЯЕТ (ЧАС) {

=4-6

~24

~8

~12

}

К СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ОТНОСИТСЯ ТЕРАПИЯ {

=тромболитическая

~антикоагулянтная

~нейропротективная

~иммуносупрессивная

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ {

=геморрагических осложнений

~острой почечной недостаточности

~острой печеночной недостаточности

~вторичного вазоспазма и синдрома обкрадывания

}

ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ПОДТИПА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧЕНИЕ {

=Ацетилсалициловой кислоты

~Клопидогрела

~Варфарина

~Ривороксабана

}

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА НАПРАВЛЕНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ {

=развития инсульта и коррекцию факторов риска инсульта

~повторного инсульта и коррекцию факторов риска, с учетом патогенеза перенесенного инсульта

~геморрагических осложнений перенесенного ишемического инсульта

~вторичного вазоспазма и синдрома обкрадывания при геморрагическом инсульте

}

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, ПОРАЖАЮЩИМ ВНУТРЕННЕЕ УХО, ОТНОСЯТ {

=Спиронолактон, Фуросемид

~Кларитромицин, Рокситромицин

~сульфаниламиды

~Ампициллин

}

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ОТОМИКОЗОМ ПОКАЗАНА ТОЛЬКО ТЕРАПИЯ {

=противогрибковая, десенсибилизирующая
~гормональная
~антибактериальная
~антигистаминная
}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ {
=геморрагический инсульт менее чем 6 месяцев назад
~инфаркт миокарда
~глаукома
~бронхиальная астма
}

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ ПОРОКОВ У РЕБЁНКА НАЗНАЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВИТАМИНА {
=А
~В1
~В2
~С
}

КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ВЛИЯЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА - РЕЦЕПТОРЫ {
=В1
~А1
~А2
~В2
}

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭФФЕКТА НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИЕМЕ СУБЛИНГВАЛЬНО СОСТАВЛЯЕТ (МИН) {
=0,5-2
~5-6
~30
~8-10
}

В ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НПВС ЛЕЖИТ {
=ингибирование активности циклооксигеназы
~ингибирование активности липооксигеназы
~блокада рецепторов простагландинов
~стимуляция циклооксигеназы
}

ПРИ НАЛИЧИИ БРАДИКАРДИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Амлодипин
~Верапамил
~Пропранолол
~Атенолол
}

НИЖНИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ОТВЕДЕНИЯХ {
=II, III, AVF

~I, AVL, V6
~V3-V4
~V1-V6, AVL, I
}

ДЛЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ХАРАКТЕРНО {

=выраженные общемозговые, очаговые и менингеальные симптомы
~расстройства чувствительности по проводниковому типу
~постепенное начало заболевания
~предшествующие преходящие симптомы
}

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ {

=панцитопению
~гипохромию эритроцитов
~анизо-пойкилоцитоз
~лейкоцитоз и гипохромию эритроцитов
}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ {

=иАПФ и сартанов
~Метилдопы
~бета-адреноблокаторов
~антагонистов кальция
}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ {

=бета-адреноблокаторов
~ингибиторов АПФ
~антагонистов кальция
~сартанов
}

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ КЕРАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=перфорация роговицы

~вовлечение в процесс сосудистого тракта глаза

~осложненная катаракта

~помутнение стекловидного тела

}

КРОВОИЗЛИЯНИЕ НА ГЛАЗНОМ ДНЕ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ С ПОМОЩЬЮ {

=офтальмоскопии

~диафаноскопии

~бифокального освещения

~исследования в проходящем свете

~нарушении сумеречного зрения

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ {

=тонометрии

~ультразвуковой эхографии

~рефрактометрии

~биометрии глазного яблока

}

ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ В АНАЛИЗАХ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ {

=анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ

~анемия, лейкопения, тромбоцитопения

~эритроцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитопения

~лейкопения, лимфоцитоз, ускорение СОЭ

}

ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 66 ЛЕТ НА ПОХОЛОДАНИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, БОЛИ ПРИ ХОДЬБЕ, СТИХАЮЩИЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ, СООТВЕТСТВУЮТ СИМПТОМАМ {

=атеросклероза бедренных артерий

~тромбофлебита вен нижних конечностей

~плоскостопия

~синдрома Рейно

}

ДЛЯ ОСТЕОАРТРОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ {

=скованности в движениях утром в течение 120 минут

~деформации суставов

~механического типа болей

~ограничения подвижности суставов

}

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ {

=Холецистокинина

~гастрина

~панкреатического сока

~секретина

}

КОНЬЮГИРОВАННЫЙ (СВЯЗАННЫЙ) БИЛИРУБИН ОБРАЗУЕТСЯ В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТА {

=глюкуронилтрансферазы

~лейцинаминопептидазы

~нуклеотидазы

~кислой фосфатазы

}

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ {

=проксимальные межфаланговые

~первый и второй пястно-фаланговый

~плечевые

~дистальные межфаланговые

}

ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ {

=пиковую скорость выдоха

~остаточный объем

~дыхательный объем

~жизненную емкость легких

}

ДИАГНОЗ «ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ» МОЖЕТ БЫТЬ ТОЧНО УСТАНОВЛЕН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ {

=более 20% бластных клеток в костном мозге

~более 20% бластных клеток в периферической крови

~при сочетании температуры, анемии и кровоточивости

~при наличии анемии в сочетании с тромбоцитопенией, болями в костях и температурой

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=стрептококк

~микоплазма

~гемофильная палочка
~клебсиелла пневмонии
}

УРОВЕНЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ 3
СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, СООТВЕТСТВУЕТ
(МЛ/МИН) {
=35
~60
~20
~15
}

ДОСТОВЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ
ПЕРФОРАЦИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ {
=свободный газ в брюшной полости
~высокое стояние диафрагмы
~пневматизация кишечника
~«чаши» Клойбера
}

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ АГРАНУЛОЦИТОЗА ОТНОСЯТ {
=некротическую ангину
~развитие сердечной недостаточности
~геморрагический синдром
~тяжелую анемию
}

ПЕРЕХОД ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО ГЕПАТИТА В
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ {
=варикозное расширение вен пищевода
~желтуха
~гипоальбуминемия
~энцефалопатия
}

СИНТЕЗ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЖЕЛЕЗАХ ЖЕЛУДКА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ {
=париетальные клетки
~главные клетки
~нейроэндокринные клетки
~мукоциты
}

ВСЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =гипохромными
- ~гиперхромными
- ~нормохромными
- ~макроцитарными

}

ТРЕХРОСТКОВАЯ ЦИТОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

- =дефицита витамина В12
- ~железодефицитной анемии
- ~гемолитической анемии
- ~анемии хронического воспаления

}

В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ДВС-СИНДРОМА ЛЕЖИТ {

- =генерализованное повреждение эндотелия микрососудов
- ~повреждение адгезивных свойств тромбоцитов
- ~истощение и дефицит простациклина
- ~выработка антител к тромбоцитам

}

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВИТАМИНА В12 В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ {

- =4-5 лет
- ~5-8 месяцев
- ~9-12 месяцев
- ~1 -2 года

}

ОРГАНАМИ-МИШЕНЯМИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮЩИМИСЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА - КОНОВАЛОВА, ЯВЛЯЮТСЯ {

- =печень и мозг
- ~почки и лёгкие
- ~печень и лёгкие
- ~сердце и почки

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =эхокардиография
- ~электрокардиография
- ~фонокардиография
- ~рентгенография

}

БОЛЬШОЕ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ДВОЙНОЙ ТОН ТРАУБЕ, ШУМ ДЮРОЗЬЕ НА СОСУДАХ, БЫСТРЫЙ И ВЫСОКИЙ ПУЛЬС, ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ {

=недостаточности аортального клапана

~врожденных пороков сердца

~митрального стеноза

~трикуспидальной недостаточности

}

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО СУБАОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ {

=эхокардиографии

~ЭКГ с физической нагрузкой

~радионуклидного сканирования сердца

~рентгенографии органов грудной клетки

}

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА ВЛЕВО И ВНИЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ДИЛАТАЦИИ {

=левого желудочка

~правого предсердия

~правого желудочка

~левого предсердия

}

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ СТЕНОКАРДИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С {

=стенозом основного ствола левой коронарной артерии

~проксимальным поражением задней коронарной артерии

~дистальным поражением огибающей артерии

~проксимальным поражением огибающей артерии

}

ФЕНОМЕН «ПЛЯСКА КАРОТИД» ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ {

=недостаточности аортального клапана

~стенозе митрального клапана

~тетраде Фалло

~болезни Аддисона

}

ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=депрессия ST более чем на 2 мм

- ~подъем сегмента ST более чем на 2 мм
- ~уменьшение вольтажа всех зубцов
- ~появление отрицательных зубцов T
- ~гиперстенурии

}

АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ГЕМОДИАЛИЗУ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =уровень К крови более 6,5 ммоль/л
- ~уровень Na крови более 135 ммоль/л
- ~клубочковая фильтрация менее 25 мл/мин
- ~суточный диурез менее 50 мл

}

ОПИСАНИЮ «FACIES NEPHRITICA» СООТВЕТСТВУЕТ {

- =одутловатое, бледное лицо с отеками под глазами, припухшими веками, узкими глазными щелями
- ~одутловатое, цианотичное лицо, с набуханием вен шеи, выраженным цианозом и отеком шеи
- ~выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей
- ~мертвенно-бледное лицо с сероватым оттенком, запавшими глазами, заостренным носом, с каплями холодного профузного пота на лбу

}

СИСТЕМНЫЙ КАПИЛЛЯРИТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АЛЬВЕОЛ ЛЕГКИХ И БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН ГЛОМЕРУЛЯРНОГО АППАРАТА ПОЧЕК ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ {

- =синдроме Гудпасчера
- ~системной красной волчанке
- ~болезни Рейно
- ~синдроме Шегрена

}

ПРИ СПИРОГРАФИИ ПАЦИЕНТА 58 ЛЕТ ВЫЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ЖЕЛ 50% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ОФВ1 40% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ИНДЕКС ТИФФНО 50%) СООТВЕТСТВУЮТ {

- =смешанному нарушению вентиляции
- ~рестриктивному типу нарушения
- ~бронхиальной обструкции
- ~варианту нормы

}

ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ {

- =ревматоидного фактора
- ~НБА-V27
- ~антинейтрофильных цитоплазматических антител

~антител к двуспиральной ДНК
}

К ТИПИЧНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТНОСИТСЯ {

=лейкопения
~железодефицитная анемия
~лейкоцитоз
~тромбоцитоз
~сыпи
}

К РАННИМ ПРИЗНАКАМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ОТНОСИТСЯ {

=артрит
~диастолический шум над аортой
~узловатая эритема
~систолический шум на митральном клапане
}

ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=амилоидоз
~общий атеросклероз сосудов
~нарушение углеводного обмена
~порфирия
}

МАРКЕРОМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=антинуклеарный фактор
~ревматоидный фактор
~С-реактивный белок
~HLA-B27 антиген
}

КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ CREST-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ {

=телеангиэктазия
~проксимальная миопатия
~поражение кишечника
~поражение почек
}

ПРИЗНАКОМ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=супраорбитальный отек и гиперемия кожи около глаз
~«бабочка» на лице

~остеолиз ногтевых фаланг
~деформация суставов
}

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ИМЕЕТ {
=высокая активность креатинфосфокиназы
~повышение уровня острофазовых белков
~умеренный лейкоцитоз
~наличие гемолитической анемии
}

НОСИТЕЛЬСТВО В27-АНТИГЕНОВ HLA СВОЙСТВЕННО {
=болезни Бехтерева
~ревматоидному артриту
~синдрому Шегрена
~дерматомиозиту
}

СОСУДЫ КРУПНОГО КАЛИБРА ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ {
=артериите Такаясу
~болезни Бюргера
~узелковом периартериите
~геморрагическом васкулите
}

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У МУЖЧИНЫ 68 ЛЕТ С
ВЫЯВЛЕННОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ,
СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ И ЛЕЙКОЦИТАМИ $84 \times 10^9/\text{л}$ (П/Я 2, С/Я 18, Л 72, М
8) ЯВЛЯЕТСЯ {
=«хронический лимфолейкоз»
~«идиопатический миелофиброз»
~«хронический миелолейкоз»
~«болезнь Ходжкина»
}

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОЙ 28 ЛЕТ С ЖАЛОБАМИ
НА МЫШЕЧНУЮ СЛАБОСТЬ, ЖАЖДУ, СТОЙКУЮ АРТЕРИАЛЬНУЮ
ГИПЕРТонию, ГИПОКАЛИЕМИЮ, (РЕНИН ПЛАЗМЫ - 0) ЯВЛЯЕТСЯ {
=«первичный альдостеронизм»
~«реноваскулярная гипертензия»
~«хронический пиелонефрит»
~«феохромоцитома»
}

ПРИ ПЕНЕТРАЦИИ ЯЗВЫ В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ {

=амилазы

~липазы

~глюкозы

~щелочной фосфатазы

}

ФИБРИЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=отсутствием зубцов Р

~частотой желудочковых комплексов более 120 в минуту

~наличием преждевременных комплексов QRS

~укорочением интервалов PQ

}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСУМКОВАННЫЙ ПЛЕВРИТ ПЕРЕД ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИЕЙ НУЖНО ПРОВЕСТИ {

=УЗИ

~бронхоскопию

~рентгеноскопию

~микроскопию мокроты

}

БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ {

=ингаляционные глюкокортикостероиды

~антихолинэргические препараты

~муколитические препараты

~бета-2-агонисты

}

ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, ПРИМЕНЯЮТ {

=Азитромицин

~Цефтриаксон

~Гентамицин

~Амоксициллин

}

МЕТОТРЕКСАТ ВЫЗЫВАЕТ ДЕФИЦИТ {

=фолиевой кислоты

~железа

~аскорбиновой кислоты

~йода

}

ПРИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЮТ {

=Фуросемиду

~Маннитулу

~Спиринолактону

~Гидрохлортиазиду

}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ
ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=наличие нефротического синдрома без выраженной гематурии и гипертонии

~отёки

~артериальная гипертония

~макрогематурия

}

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА СРОКЕ 36 НЕДЕЛЬ
БЕРЕМЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И НАРАСТАНИЕМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ВКЛЮЧАЕТ {

=назначение кортикостероидов или иммуноглобулина

~плазмаферез с замещением свежзамороженной плазмой

~назначение винкристина

~терапию криопреципитатом

}

В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИИ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ {

=спазмолитические средства

~H₂-блокаторы гистамина

~сукралфат и его аналоги

~ингибиторы протонной помпы

}

В ЛЕЧЕНИИ ГИПОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИИ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ {

=холекинетики

~антациды

~спазмолитики

~ингибиторы протонной помпы

}

ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА У БОЛЬНЫХ С
ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ
СВЯЗАН С {

=расширением периферической венозной системы
~расширением периферических артерий
~увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных сокращений
~замедлением ЧСС и снижением потребности миокарда в кислороде
}

ЭЛИМИНАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ {
=константа скорости элиминации
~степень протеидизации
~биодоступность
~объем распределения
}

АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДЕСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ БЛОКИРУЕТ ПЕТЛЕВОЙ ДИУРЕТИК {
=Торасемид
~Фуросемид
~Этакриновая кислота
~Маннитол
}

СПИРОНОЛАКТОН ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (МГ) {
=100-300
~50-100
~25-50
~12,5-25
}

ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ К НАЗНАЧЕНИЮ ПРИ {
=двустороннем стенозе почечных артерий
~снижении уровня креатинина
~симптомной гипертензии
~декомпенсации хронической сердечной недостаточности
}

ОСНОВНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НИТРАТОВ ОБУСЛОВЛЕН {
=уменьшением венозного возврата к сердцу
~увеличением венозного возврата к сердцу
~увеличением сократительной способности миокарда
уменьшением сократительной активности миокарда

}

ВРЕМЯ «ИНТЕРВАЛЬНОЙ» ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ СОСТАВЛЯЕТ (ЧАС) {

=8-12

~14-16

~18-20

~40-46

}

ПРИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ {

=Этамзилат натрия

~Варфарин

~Тиклопидин

~Стрептолизин

}

К ОСНОВНОМУ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ СТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ {

~пермессивный

=жаропонижающий

~антибактериальный

~противовирусный

}

ПРЕПАРАТОМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К Ig E ЯВЛЯЕТСЯ {

=Омализумаб

~Фенспирид

~Зафирлукаст

~Монтелукаст

}

БЛОКАТОРОМ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Монтелукаст

~Фенспирид

~Эбастин

~Хлоропирамин

}

ФАМОТИДИН БЛОКИРУЕТ {

=H₂-рецепторы

~M₂-ионные каналы

~H₁-рецепторы

~D₁-рецепторы

}

ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ МЕТАСТАЗАХ В {

=кости

~легкие

~печень

~головной мозг

}

ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНЬЮ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА (СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ) ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕНЕНИЕ {

=сильных опиоидов

~слабых опиоидов

~неопиоидных анальгетиков

~нейролептаналгезии

}

ПОД КОМБИНИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ УДАЛЕНИЕ
ОПУХОЛИ {

=с резекцией (удалением) другого органа, вовлеченного в опухолевый
процесс

~в пределах здоровых тканей вместе с регионарным лимфатическим
барьером и всеми доступными лимфоузлами и клетчаткой в зоне операции

~вместе с регионарным лимфатическим барьером и одновременным
выполнением операции по поводу какого-либо другого неонкологического
заболевания

~в пределах здоровых тканей вместе с регионарным лимфатическим
барьером

}

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ФОЛЛИКУЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕНЕНИЕ {

=радиоизотопа йода-131

~Блеомицина

~Метотрексата

~Митомицина С

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=морфологический

~лучевой

~лабораторный

~лабораторно-инструментальный

}

ПОНЯТИЕ «РАННИЙ РАК» ПОДРАЗУМЕВАЕТ {

=рак I-II стадий

~тяжелую дисплазию

~рак II-III стадий

~все стадии рака, кроме IV

}

ПЕРВИЧНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАРУЖНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

{

=смотровые кабинеты

~кабинеты профилактики

~подростковые кабинеты

~онкологические диспансеры

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА ЯВЛЯЕТСЯ {

=гепатомегалия

~иктеричность кожных покровов

~лихорадка

~синдром астении-кахексии

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА ПРИМЕНЯЮТ {

=фиброгастроскопию с биопсией

~компьютерную томографию

~позитронно-эмиссионную томографию

~ультразвуковое исследование

}

ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ
ЯВЛЯЕТСЯ {

=поражение эндотелия сосудов

~развитие отёка и набухания головного мозга

~поражение миокарда и перикарда

~поражение эпителия верхних дыхательных путей

}

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ
ЯВЛЯЕТСЯ {

=геморрагическая звездчатая сыпь

~менингеальный синдром

~гепатолиенальный синдром
~пятнисто-папулезная звездчатая сыпь
}

ОСЛОЖНЕНИЕМ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ {
=отёк головного мозга
~инфекционно-токсический шок
~тромбогеморрагический синдром
~гиперпродукция ликвора
}

МАЛЯРИЙНЫЙ ПАРОКСИЗМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ
ФАЗАМИ {
=озноб - жар - пот
~судороги - бред - кома
~сомноленция - сопор - кома
~жар - пот - сон
}

МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЯ МАЛЯРИИ В МАТЕРИАЛЕ ОТ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ {
=микроскопия мазка крови
~серологический
~паразитоовоскопический
~биологический
}

К НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЦИТОЛИЗА ГЕПАТОЦИТОВ ОТНОСЯТ {
=повышение активности АЛТ и АСТ
~повышение уровня билирубина и желчных пигментов
~снижение сулемового титра и тимоловой пробы
~гиперальбуминемия, гипопротромбинемия
}

В РАЗВИТИИ СЕКРЕТОРНОЙ ДИАРЕИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ ОСНОВНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ {
=активация аденилатциклазы
~незавершенный фагоцитоз
~гипосмолярность
~внутриклеточная персистенция
}

ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ ХОЛЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ {
=гиповолемический шок

~инфекционно-токсический шок
~кардиогенный шок
~коллапс
}

ПРИ ХОЛЕРЕ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДЯТ ЗАБОР {
=испражнений, рвотных масс
~крови, рвотных масс
~испражнений, крови
~рвотных масс, мокроты
}

СЫПЬ У БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ДЕНЬ
БОЛЕЗНИ {
=8-10
~5-7
~12-14
~3-4
}

ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ {
=гастроэнтерит
~гастродуоденит
~панкреатит
~энтероколит
}

ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ КАЛ ИМЕЕТ ВИД {
=«болотной тины»
~«малинового желе»
~«рисового отвара»
~«горохового пюре»
}

ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЯ ПРИ ЧУМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ {
=блохами
~вшами
~комарами
~клещами
}

ЭТИОТРОПНЫМ СРЕДСТВОМ ЛЕЧЕНИЯ РОЖИ ЯВЛЯЮТСЯ {
=антибиотики

~противовоспалительные средства
~глюкокортикостероиды
~мазевые повязки
}

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ ПРЕПАРАТАМИ {
=противовирусными
~антибактериальными
~иммуносупрессорными
~противовоспалительными
}

АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ {
=ботулизма
~балантидиаза
~сыпного тифа
~боррелиоза
}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ЯВЛЯЕТСЯ {
=антибиотикотерапия
~дегидратация
~десенсибилизация
~регидратация
}

ВНЕЗАПНОЕ СОБЫТИЕ, ВЛЕКУЩЕЕ ЗА СОБОЙ РАЗРУШЕНИЕ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, НАЗЫВАЮТ {
=катастрофой
~аварией
~чрезвычайной ситуацией
~происшествием
}

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОВРЕМЕННОГО
ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ
НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ, НАЗЫВАЮТ
ПОРАЖЕНИЯМИ {
=комбинированными
~изолированными
~множественными
~сочетанными
}

БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=нештатными формированиями службы медицины катастроф
~штатными формированиями Всероссийской службы медицины катастроф
~учреждениями Всероссийской службы медицины катастроф Российской Федерации
~формированиями министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
}

ТОТАЛЬНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ ВСЕХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
НАЗЫВАЮТ {

=пансинусит
~обострение хронического синусита
~сфеноидит
~острый синусит
}

ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ НОСА НА
ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА НЕОБХОДИМО {

=произвести переднюю тампонаду носа и назначить гипотензивную терапию
~произвести переднюю тампонаду носа произвести заднюю тампонаду носа
~положить больного в горизонтальное положение
}

АДЕНОИДЫ ПРИВОДЯТ К {

=нарушению носового дыхания и деформации лицевого скелета
~нарушению равновесия и умственного развития
~деформации лицевого скелета и перегородки носа
~нарушению питания и деформации лицевого скелета
}

ЛИХОРАДКА, ФАРИНГИТ, КОНЪЮНКТИВИТ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
АНГИНЫ{

=аденовирусной
~герпетической
~скарлатинозной
~коревой
}

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ МАЛИГНИЗАЦИИ ПОЛИПЫ ЖЕЛУДКА {

=аденоматозные
~гиперпластические
~Гиперплазиогенные
~ювенильные
}

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ НАЛИЧИИ {

=ворсинчатого полипа

~запоров

~геморроя

~болезни Крона

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАК {

=узловой

~маститоподобный

~рожистоподобный

~Педжета

}

РАК КОЖИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ У {

=белого населения

~монголоидов

~чернокожего населения

~альбиносов

}

ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАКА КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=инсоляция

~гипертермия

~ионизирующая радиация

~вирусная инфекция

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАК КОЖИ ВОЗНИКАЕТ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) {

=старше 65

~40-60

~30-40

~0-14

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ СДАВЛЕНИИ СПИННОГО МОЗГА ВСТРЕЧАЕТСЯ {

=боль

~потеря аппетита

~рвота

~нарушение сна

}

ПРИ СТАФИЛОДЕРМИИ ПОРАЖАЮТСЯ {

=сально-волосные фолликулы

~волосы

~роговой и блестящий слой эпидермиса

~ногти

}

ВЫСЫПАНИЯ ВТОРИЧНОГО ПЕРИОДА СИФИЛИСА {

=исчезают бесследно

~оставляют рубцы

~оставляют пигментацию

~оставляют атрофию

}

ДЛЯ ВТОРИЧНОГО СИФИЛИСА ХАРАКТЕРНЫ {

=розеолы

~уртикарии

~бугорки

~гуммы

}

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПОЗДНЕГО ВРОЖДЕННОГО
СИФИЛИСА ЯВЛЯЕТСЯ {

=триада Гетчинсона

~седловидный нос

~саблевидные голени

~«олимпийский лоб»

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФУРУНКУЛА В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ НАЗНАЧАЮТ {

=мази с антибиотиками

~2 % салициловый спирт

~компрессы с борной кислотой

~примочки с ихтиолом

}

ГЕМОМРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В
НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=гиперемией и одутловатостью лица

~бледностью кожных покровов

~розеолёзной сыпью

~зудом кожи

}

САМЫМ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=мононуклеозоподобный синдром
~длительная диарея
~саркома Капоши
~кахексия
}

К СЕРОЛОГИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ, ОТНОСЯТ {
=anti-HAV IgM
~HBsAg
~anti-Hbcor IgM
~anti-HCV IgM
}

ДЛЯ ОСТРОЙ ФОРМЫ АМЕБИАЗА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ {
=болей в правой подвздошной области и стула по типу «малинового желе»
~болей в правой подвздошной области и жидкого стула
~рвоты и отсутствия болей в животе
~высокой температуры тела и жидкого стула с прожилками крови
}

ДЛЯ БОТУЛИЗМА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ {
=нарушения зрения и глотания
~высокой температуры тела и частого жидкого стула
~высокой температуры тела и нарушения сознания
~судорог мышц и жидкого стула
}

ПРИ АЛГИДНОЙ ФОРМЕ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНА ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА НА (%) {
=10 и более
~1-3
~3-6
~6-9
}

ДЛЯ БУБОННОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ХАРАКТЕРНЫ {
=гиперемия кожи, периаденит и болезненность бубона при пальпации
~четкая конфигурация лимфоузла и отсутствие изменений кожи
~обычная окраска кожи над бубоном и отсутствие болезненности при пальпации
~гиперемия кожи над бубоном и отсутствие болезненности при пальпации
}

ПРИ БОТУЛИЗМЕ ПОРАЖАЮТСЯ {

=двигательные ядра продолговатого мозга

~периферические нервы

~ганглии

~участки коры головного мозга

}

СТУЛ ПРИ ХОЛЕРЕ {

=обильный, водянистый, без калового запаха и окраски

~обильный, водянистый, зловонный

~обильный, водянистый, зеленоватой окраски

~водянистый с примесью крови

}

К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ОТНОСЯТСЯ

{

=тошнота, рвота, жидкий водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура тела

~рвота без тошноты, без болей в животе, нормальная температура тела

~схваткообразные боли в животе, скудный стул, высокая температура тела

~обильный водянистый стул типа «рисового отвара», без болей в животе, нормальная температура тела

}

ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ПЕРВИЧНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ СЫПИ
НАБЛЮДАЕТСЯ НА ДЕНЬ БОЛЕЗНИ {

=8-10

~1 -3

~4-7

~12-14

}

ДЛЯ СИБИРЕЯЗВЕННОГО КАРБУНКУЛА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ {

=черного, безболезненного струпа

~яркой гиперемии кожи

~резкой болезненности

~гнойного отделяемого

}

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «МАЛЯРИЯ»
ИССЛЕДУЕТСЯ {

=кровь

~кал

~моча
~желчь
}

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ БРЮШНОГО ТИФА ВОЗБУДИТЕЛЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В СУБСТРАТЕ {

=крови
~кала
~мочи
~желчи
}

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ {

=аланинаминотрансферазы
~альбумина
~щелочной фосфатазы
~холестерина
}

КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=тахикардией, падением артериального давления
~болями в животе
~положительным симптомом Щеткина
~нарушением сознания
}

ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ {

=высокой температуры тела, головной боли, миалгии, трахеита, непродуктивного насморка
~субфебрильной температуры тела, ларингита, ринита
~высокой температуры тела, увеличения миндалин, лимфатических узлов, фарингита
~высокой температуры тела, конъюнктивита, фарингита
}

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСЯТ {

=лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз, наличие атипичных мононуклеаров
~нейтрофильный лейкоцитоз
~лейкопению с относительным лимфоцитозом
~лейкопению, лимфоцитоз, моноцитоз
}

СИНДРОМ ТРАХЕИТА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ {
=гриппа
~парагриппа
~риновирусной инфекции
~аденовирусной инфекции
}

ОСЛОЖНЕНИЕ «ЛОЖНЫЙ КРУП» ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {
=парагриппа
~риновирусной инфекции
~аденовирусной инфекции
~гриппа
}

ХРОНИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИСХОДОМ В
ЦИРРОЗ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ {
=С
~А
~В
~Е
}

ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ
ЛИХОРАДКИ И {
=ангины, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии
~лимфаденопатии, болей в животе
~ангины, лимфаденопатии, диареи
~тошноты, рвоты
}

ДЛЯ НАЧАЛА МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРНЫ {
=быстрое повышение температуры, головная боль, рвота без болей в животе
~постепенное начало, головная боль, рвота, жидкий стул
~высокая температура, рвота, боли в животе
~высокая температура, головная боль, нарушение зрения
}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ
НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ {
=протеинурия с суточной потерей более 3,5 г
~бактериурия
~лейкоцитурия
~гипоизостенурия
}

НА РАННИХ СТАДИЯХ АМИЛОИДОЗА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ БИОПСИЯ {

=слизистой прямой кишки

~печени

~почек

~кожи

}

ПОД ПРОБОЙ НЕЧИПОРЕНКО ПОНИМАЮТ {

=подсчет количества форменных элементов в единице объема мочи

~определение концентрационной функции почек

~определение количества форменных элементов в минутном объеме мочи

~определение неорганических веществ в моче

}

ОСНОВНЫМ ЦИТОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ОСТРОГО
МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
РЕАКЦИЯ НА {

=миелопероксидазу

~В-глюкуронидазу

~АТФазу

~кислую фосфатазу

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА В
СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ПРИЗНАКАМИ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН
ПРОЦЕНТ ЛИМФОЦИТОВ В МИЕЛОГРАММЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ
БОЛЕЕ {

=30

~20

~10

~40

}

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ
ПРЕДСТАВЛЕН {

=плазмócитами

~лимфоцитами

~макрофагами

~эозинофилами

}

К ИЗМЕНЕНИЯМ В КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ
АНЕМИИ ОТНОСЯТ {

- =снижение клеточности костного мозга, преобладание жировой ткани
- ~преобладание кроветворного костного мозга над жировым
- ~очаговую пролиферацию лимфоцитов
- ~сужение красного ростка

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД {

- =коронарографии
- ~электрокардиографии
- ~велоэргометрии
- ~чрезпищеводной стимуляции левого предсердия

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦИПАЛА МЕТОД {

- =холтеровского мониторирования ЭКГ
- ~велоэргометрии
- ~чрезпищеводной стимуляции левого предсердия
- ~электрокардиографии

}

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

- =повышение миокардиальных ферментов
- ~лейкоцитоз крови
- ~ускорение скорости оседания эритроцитов
- ~повышение иммуноглобулинов

}

ЭКГ-ПРИЗНАКОМ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ПРИ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ {

- =зубец QS
- ~подъем интервала ST выше изолинии
- ~смещение интервала ST ниже изолинии
- ~отсутствие патологического зубца Q

}

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРОБА С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ {

- =появлении боли или стеснения в груди в сочетании с депрессией сегмента ST более 1 мм
- ~появлении одышки при достижении субмаксимальной ЧСС
- ~повышении САД до 180 мм рт.ст и ДАД до 110 мм рт.ст.

~регистрации косовосходящей депрессии сегмента ST до 1 мм
}

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С СИНДРОМОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ{

=снижение содержания тромбоцитов до $50 \cdot 10^9/\text{л}$

~повышение аланинаминотрансферазы

~наличие эозинофилии

~повышение скорости оседания эритроцитов

}

РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ГАММАГЛУТАМИНТРАНСПЕПТИДАЗЫ ПРИ {

=хроническом гепатите с явлениями холестаза и билиарном циррозе печени

~гематоматозе

~болезни Вильсона - Коновалова

~описторхозе

}

ФЕРМЕНТОМ, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИМ АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=алкогольдегидрогеназа

~глюкозо-6-фосфатаза

~алкогольоксидаза

~алкогольсинтетаза

}

К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКОВ ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТСЯ {

=белковые препараты, мочегонные

~антиагреганты, антикоагулянты, антибиотики

~глюкокортикоиды, цитостатики, антиагреганты, антикоагулянты

~глюкокортикоиды, антикоагулянты, антибиотики

}

ПОКАЗАНИЯМИ К СРОЧНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ{

=повышение уровня калия сыворотки $6,5 \text{ ммоль/л}$ и более

~высокая гипертензия

~олигурия

~повышение уровня мочевины более 10 ммоль/л

}

ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ{

=спленомегалия, лейкоцитоз, тромбоцитоз
~лейкопения, тромбоцитопения
~плеторический синдром
~эритромелалгия
}

К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИАНТНОЙ
СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ {
=антагонисты кальция
~Никорандил
~бета-адреноблокаторы
~ингибиторы АПФ
}

АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТСЯ {
=Преднизолоном
~Панкреатином
~Рибавирином
~Интерфероном
}

В ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА С СЕКРЕТОРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВКЛЮЧАЮТСЯ {
=ферменты (панкреатин)
~кортикостероиды
~сосудистые препараты
~ингибиторы АПФ
}

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ У
ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ {
=тяжелая дисплазия слизистой оболочки толстой кишки
~прием глюкокортикоидов
~развитие склерозирующего холангита
~развитие псевдополипоза
}

НЕПРЯМЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ {
=кардиоэмболических осложнений
~развития сердечной недостаточности
~возникновения пароксизмов фибрилляции предсердий
~прогрессирования стенокардии напряжения
}

ГЕМИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ {

=отравлении угарным газом

~пневмонии

~сахарном диабете

~отравлении цианидами

}

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ И
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ (ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ) ЯВЛЯЕТСЯ {

=этиловый спирт

~гидрокарбонат натрия

~перманганат калия

~атропин

}

ВЕРОЯТНОСТЬ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ
КОМБИНАЦИИ ГЕНТАМИЦИНА С {

=Фуросемидом

~Пенициллином

~метилксантинами

~макролидами

}

НАИБОЛЬШИМ УЛЬЦЕРОГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ {

=Кеторолак

~Парацетамол

~Трамадол

~Ибупрофен

}

НАИБОЛЬШЕЙ НЕФРОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ {

=аминогликозиды

~макролиды

~Нитрофураны

~Р-лактамы

}

КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЛАКТАЦИИ {

=Тетрациклина

~Пенициллина

~Цефтриаксона

~Азитромицина

}

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ С СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ {

=Р-адреноблокаторам

~дигидропиридиновым блокаторам кальциевых каналов

~петлевым диуретикам

~а-адреноблокаторам

}

А1-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С{

=аденомой предстательной железы

~стенокардией напряжения

~инфарктом миокарда в анамнезе

~нарушениями ритма сердца

}

НАИБОЛЬШЕЙ ОТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ {

=аминогликозиды

~макролиды

~нитрофураны

~Р-лактамы

}

НАИБОЛЬШЕЙ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ{

=Парацетамол

~Ацетилсалициловая кислота

~Ибупрофен

~Кеторолак

}

К ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМ ОТНОСИТСЯ{

=аскаридоз

~тениоз

~энтеробиоз

~трихинеллез

}

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ {

=жаропонижающий и противовоспалительный

~анальгетический и противоаллергический

~противовоспалительный и противорвотный

~противошоковый и жаропонижающий

}

ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ {

=Метилдопа

~Клонидин

~Резерпин

~Празозин

}

ГЕПАРИН {

=инактивирует тромбин (фактор II свертывания крови)

~является антикоагулянтом непрямого действия

~повышает агрегацию тромбоцитов

~эффективен при приеме внутрь

}

ПОД БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ПОНИМАЮТ ЧАСТЬ ВВЕДЕННОЙ В ОРГАНИЗМ ДОЗЫ{

=достигшей системного кровотока в неизменном виде или в виде активных метаболитов

~подвергшейся биотрансформации

~попавшей в больной орган

~оказывающей биологические эффекты

}

К КОМБИНИРОВАННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ {

=одновременное повреждение несколькими повреждающими факторами

~ранение нескольких областей тела

~ранение несколькими снарядами

~повреждение нескольких органов

}

ШОКОВЫМ ИНДЕКСОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ {

=частоты пульса к систолическому артериальному давлению

~частоты пульса к центральному венозному давлению

~систолического артериального давления к частоте пульса

~систолического артериального давления к диастолическому артериальному давлению

}

ЯДОВИТЫЕ ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ И ДРУГИЕ ГАЗООБРАЗНЫЕ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОНИКАЮТ В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ {

=дыхательные пути

~пищеварительный тракт

~кожу и слизистые оболочки

~раневые поверхности

}

К МЕТОДАМ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ {

=наложение кровоостанавливающего зажима

~сосудистая пластика

~перевязка сосуда на протяжении

~перевязка сосуда в ране

}

ПРИ БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТОШНОТЕ, ИЗЖОГЕ, ОТРЫЖКЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ {

=эзофагогастродуоденоскопию

~клинический анализ крови

~ультразвуковое исследование органов брюшной полости

~компьютерную томографию органов брюшной полости

}

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕР СТУЛА {

=обильный, кашицеобразный, блестящий

~скудный, фрагментированный

~водянистый с хлопьями

~жидкий, с примесью алой крови

}

ВЫЯВЛЕНИЕ НА ЭКГ УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА P-Q, РАВНОГО 0,26 СЕК., СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО БЛОКАДЫ {

=атриовентрикулярного проведения 1 степени

~атриовентрикулярного проведения 2 степени

~атриовентрикулярного проведения 3 степени

~синоатриального проведения

}

«ШТАМПОВАННЫЕ» ДЕФЕКТЫ В ЭПИФИЗАХ КОСТЕЙ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ СУСТАВА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=подагры

~остеоартроза

~ревматоидного артрита

~анкилозирующего спондилита

}

ДЛЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНЫ УМЕРЕННЫЕ {

=лейкопения и тромбоцитопения

~лейкопения и тромбоцитоз

~лейкоцитоз и тромбоцитопения
~лейкоцитоз и тромбоцитоз
}

ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ
ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА {

=интенсивная гомогенная доленая инфильтрация
~инфильтрация в форме треугольника с верхушкой, направленной к корню
~инфильтрация с ранним формированием полостей распада
~прикорневая инфильтрация с полициклическим контуром
}

СОЧЕТАНИЕ ПРОТЕИНУРИИ, ЭРИТРОЦИТУРИИ,
ГИПОПРОТЕИНЕМИИ, ОТЕКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=острого гломерулонефрита
~мочекаменной болезни
~пиелонефрита
~амилоидоза почек
}

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=колоноскопия с исследованием гистологического материала
~виртуальная колоноскопия
~ректороманоскопия
~ирригоскопия
}

ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ СОЧЕТАНИИ
СПЛЕНОМЕГАЛИИ И {

=лейкопении, анемии, тромбоцитопении
~лейкоцитоза, эритроцитоза, тромбоцитоза лейкоцитоза, анемии,
тромбоцитопении
~лейкопении, анемии, тромбоцитоза
}

ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение уровня сывороточного железа
~снижение общей железосвязывающей способности сыворотки
~повышение содержания ферритина в сыворотке
~анизоцитоз и анизохромия
}

БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=антисекреторные препараты

~спазмолитики

~прокинетики

~ферменты

}

ЛЕЧЕБНЫЙ ПАРАЦЕНТЕЗ БОЛЬНОМУ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С АСЦИТОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ {

=напряженном или рефрактерном к терапии асците

~болях в животе

~нарастании желтухи

~отсутствии артериальной гипотонии

}

АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ {

=выделении гнойной мокроты

~появлении кровохарканья

~нарастании слабости

~упорном кашле

}

КОЛХИЦИН ПРИ ПОДАГРЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ {

=купирования острого артрита

снижения гиперурикемии

профилактики и лечения нефропатии

~рассасывания подкожных тофусов

}

ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ У БОЛЬНОГО ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАСАЮТСЯ {

=белков

~жиров

~углеводов

~поваренной соли

}

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=Преднизолон

~Интерферон альфа

~Рибавирин

~Урсодезоксихолевая кислота

}

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ САМЫМ ЧАСТЫМ
ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТРАЯ {

=язва желудка

~сердечно-сосудистая недостаточность

~дыхательная недостаточность

~печеночная недостаточность

}

ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ
ПОСЛЕ ПРИЕМА {

=нестероидных противовоспалительных препаратов

~сердечных гликозидов

~антагонистов кальция

~бензодиазепинов

}

ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
И ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ {

=типичной стенокардией

~атипичной стенокардией

~кардиалгией

~ангинозным статусом

}

ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ БЫСТРОЙ ХОДЬБЕ ИЛИ
ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ПРОЛЕТ,
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _____ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА
СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ {

=II

~I

~III

~IV

}

ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ СПОКОЙНОЙ ХОДЬБЕ
НА РАССТОЯНИЕ 100-200 МЕТРОВ ИЛИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ
НА ОДИН ПРОЛЕТ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА
СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ {

=III

~I

~II

~IV
}

СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТМЕЧАЮТСЯ В ПОКОЕ И РЕЗКО ВОЗРАСТАЮТ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ {

=IV

~I

~II

~III

}

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ ТОЛЬКО В МАЛОМ КРУГЕ КРОВОООБРАЩЕНИЯ МОГУТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ {

=IIA

~I

~IIB

~III

}

ПРИЧИНОЙ СПОНТАННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА МОЖЕТ СТАТЬ {

=коронарный тромбоз, спровоцированный разрывом бляшки

~тяжелая гиперхолестеринемия

~резкое снижение артериального давления

~эмболия коронарных артерий

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ {

=рентгенологически подтвержденного легочного инфильтрата

~температуры тела пациента выше 38 °C

~гнойной мокроты

~лейкоцитоза

}

ДЛЯ ПЕРВОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА ТИПИЧНО ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ {

=плюснефаланговых

~пястнофаланговых

~голеностопных

~коленных

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =эндоскопическое
 - ~рентгенологическое
 - ~гистологическое
 - ~рН-метрическое
- }

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНУЮ РЕФЛЮКСНУЮ БОЛЕЗНЬ В ФОРМЕ {

- =гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом
 - ~кандидозного эзофагита
 - ~синдрома Мэллори-Вейса
 - ~диффузного эзофагоспазма
- }

КЛИНИЧЕСКИ ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ {

- =нарастание желтухи, геморрагический синдром
 - ~желтуха, слабость
 - ~геморрагический синдром, похудание
 - ~нарастание слабости, желтуха
- }

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА ВАЖНО ИССЛЕДОВАНИЕ {

- =уровня сывороточного гастрина
 - ~антител *H. pylori*
 - ~калия и натрия крови
 - ~уровня инсулина и С-пептида
- }

К РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ {

- =полифекалию
 - ~сахарный диабет
 - ~кахексию
 - ~«панкреатическую холеру»
- }

ДЛЯ АСПИРИНОВОЙ ТРИАДЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АСПИРИНА И {

- =бронхиальной астмы, полипов носа
- ~тугоухости, полипов носа
- ~конъюнктивита, вазомоторного ринита

~саркоидоза легких, хронического отита
}

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ЛЕЙКОФОРМУЛЕ МОКРОТЫ
ХАРАКТЕРНО ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ {

=Эозинофилов

~макрофагов

~лимфоцитов

~нейтрофильных лейкоцитов

}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-
АДРЕНОБЛОКТОРОВ СЛУЖИТ {

=бронхиальная астма

~хроническая обструктивная болезнь легких

~атеросклероз сосудов нижних конечностей

~атриовентрикулярная блокада I степени

}

СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СЛУЖАТ {

=бензотиазепиновые антагонисты кальция

~нитраты

~ингибиторы If-каналов синусового узла (Ивабрадин)

~дигидропиридиновые антагонисты кальция

}

У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕВЫШАТЬ (ММОЛЬ/Л) {

=5,0

~4,5

~4,0

~3,5

}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
РЕЦИДИВОВ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЦЕЛЕВОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ РАВНО {

=2,0-3,0

~1,5—2,5

~2,5-3,5

~3,0-4,0

}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА У БОЛЬНЫХ С НЕКЛАПАННОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ЦЕЛЕВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ РАВНО {

=2,0-3,0

~1,5-2,0

~2,5-3,5

~3,0-4,0

}

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У
БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ {

=Амиодарон

~бета-адреноблокаторы

~Верапамил

~Прокаинамид

}

ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У
ЛИЦ МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ {

=макролиды

~тетрациклины

~цефалоспорины III поколения

~респираторные фторхинолоны

}

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ
ПНЕВМОНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ
(СУТКИ) {

=2-3

~4-5

~6-7

~8-10

}

САМЫМ ПОЗДНИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ СТАРТОВОЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ СЛУЖИТ {

=исчезновение легочного инфильтрата

~нормализация или выраженное снижение температуры тела

~уменьшение степени гнойности мокроты

~нормализация лейкоцитарной формулы

}

КРИТЕРИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ АНТИБИОТИКАМИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ (СУТКИ) {

=3-5

~1-2

~6-7

~8-10

}

СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СИМТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ{

=р2-агонисты короткого действия

~антихолинэргические препараты

~ингаляционные глюкокортикостероиды

~системные глюкокортикостероиды

}

ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ В КОМБИНАЦИИ С{

=пролонгированными бронхолитиками

~р2-агонистами короткого действия

~антихолинэргическими препаратами

~системными глюкокортикостероидами

}

ПОДАГРА СЛУЖИТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ{

=тиазидных диуретиков

~ингибиторов АПФ

~Р-адреноблокаторов

~антагонистов кальция

}

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИДАЕТСЯ {

=ингибиторам протонной помпы

~антибиотикам

~спазмолитикам

~антацидам

}

К ПРИЧИНАМ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ ОТНОСЯТ {

=гиперпаратиреоз

~гиперфосфатемию

~жировую эмболию

~рабдомиолиз
}

ПРИЧИНОЙ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=гипопаратиреоз
~длительная иммобилизация
~болезнь Педжета
~передозировка витамина D
}

ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ {
=рождения плода
~рождения головки плода
~пересечения пуповины плода
~полного открытия маточного зева
}

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ
НА АТИПИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ С КРАТНОСТЬЮ {
=1 раз в год
~2 раза в год
~1 раз в 2 года
~3 раза в год
}

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {
=комплексом мероприятий, направленных на предупреждение рождения или
зачатия детей с наследственными заболеваниями
~комплексом мероприятий, направленных на предотвращение развития
унаследованного заболевания
~фенотипической коррекцией дефекта
~комплексом мероприятий, направленных на предупреждение
прогрессирования наследственного заболевания
}

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА {
=заболеваний, обусловленных изменением числа и структуры хромосом
~мультифакториальных заболеваний
~наследственных заболеваний обмена веществ
~наследственных заболеваний соединительной ткани
}

ЯРКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ,
НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ В СОЧЕТАНИИ С ЛИХОРАДКОЙ
СВОЙСТВЕННА {

=роже

~абсцессу

~флегмоне

~плоскому лишаю

}

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА 35 ЛЕТ НЕСПОРТИВНОГО
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ РАВНЫЙ 34,0 КГ/М2 СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ
ОЖИРЕНИЯ {

=I

~II

~III

~IV

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ И ЗНАЧИМЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=биопсия почек

~анализ мочи по Нечипоренко

~УЗИ почек

~позитронно-эмиссионная томография почек

}

НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ {

=уровень сывороточного ферритина

~уровень трансферрина

~общая железосвязывающая способность сыворотки

~уровень сывороточного железа

}

ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ {

=аденовирусной инфекции

~гриппа

~менингита

~парагриппа

}

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
ЯВЛЯЕТСЯ {

=введение гриппозных вакцин

~закаливание организма

~приём больших доз аскорбиновой кислоты
~приём поливитаминных препаратов
}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕФРОГЕННОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ {

=ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и диуретики
~блокаторы бета-адренорецепторов и блокаторы медленных кальциевых
каналов
~блокаторы альфа-адренорецепторов и препараты раувольфия
~препараты центрального действия и агонисты имидазолиновых рецепторов
}

В ПРОЦЕССЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО
ДИАБЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ {

=гликированного гемоглобина
~постпрандиальной гликемии
~гликемии натощак
~глюкозурии
}

К МЕТОДАМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
ОТНОСИТСЯ {

=вакцинация
~закаливание организма
~применение Амантадина
~применение лейкоцитарного интерферона
}

ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ УРОВЕНЬ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО
ГОРМОНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ {

=повышается
~снижается на 50%
~снижается на 70%
~находится в пределах референсных значений
}

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА ХАРАКТЕРИЗУЮТ
БОЛЕЗНЬ АДДИСОНА {

=гиперкалиемия
~гипернатриемия
~гипокалиемия
~гиперхлоремия

}

ПРИ НЕСАХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ{

=1001-1005 (при количестве мочи 5 - 20-40 литров)

~1003-1009 (при количестве мочи 5 - 20-30 литров)

~1022-1043 (при количестве мочи 2-3 литра)

~1013-1028 (при количестве мочи 5-20 литров)

}

НОРМА КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ В ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИЁМА 75 Г ГЛЮКОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ ДО (ММОЛЬ/Л) {

=7,8

~10,1

~9,2

~8,6

}

К ОСНОВНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СИМПТОМУ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ{

=частый жидкий стул с примесью крови

~боли в эпигастрии

~запоры

~рвоту, приносящую облегчение

}

ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=длительное применение антибиотиков

~пищевая токсикоинфекция

~злоупотребление алкоголем

~*Helicobacter pylori*

}

ПРИЧИНОЙ ПИЩЕВОДНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение давления в портальной вене

~снижение гемоглобина крови

~высокая вирусная нагрузка

~желтуха

}

ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ВСТРЕЧАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ{

=циррозом печени
~желчнокаменной болезнью
~острым лейкозом
~амилоидозом
}

СНИЖЕНИЕ АЛЬБУМИНОВ КРОВИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ {

=нарушения синтетической функции гепатоцитов
~нарушения всасывания белков из кишечника
~портальной гипертензии
~диспротеинемии
}

ХОБЛ ТЯЖЁЛОГО И КРАЙНЕ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ (ПОСТБРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ОФВ1<50% ОТ ДОЛЖНОЙ) С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ И ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ СООТВЕТСТВУЕТ ГРУППЕ {

=D
~A
~B
~C
}

К АЛЬВЕОЛИТАМ ОТНОСИТСЯ {

=токсический альвеолит
~саркоидоз легких
~гемосидероз легких
~диссеминированный туберкулез легких
}

ОБРАТИМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

=бронхиальной астмы
~тромбоэмболии легочной артерии
~обструктивной эмфиземы легких
~хронической обструктивной болезни легких
}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

{
=ингибиторы АПФ
~В-адреноблокаторы
~диуретики
~сердечные гликозиды

}

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СОСТОИТ В {

- =усилении высвобождения инсулина из поджелудочной железы
 - ~восстановлении физиологической чувствительности бета-клеток к гликемии
 - ~снижении количества неэстерифицированных жирных кислот и глицерина
 - ~усилении утилизации глюкозы в печени и мышцах
- }

ПРИСТУП УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ КУПИРУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ {

- =Сальбутамола
 - ~Теофиллина
 - ~Сальметерола
 - ~Беклометазона
- }

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ АТИПИЧНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ {

- =макролиды
 - ~карбапенемы
 - ~защищенные пенициллины
 - ~аминогликозиды
- }

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА 2 СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ 1 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

- =постепенным удлинением PQ с периодическим выпадением QRS
 - ~редким правильным ритмом
 - ~периодическим выпадением P и QRS
 - ~постоянным интервалом PQ с периодическим выпадением QRS
- }

О НАЛИЧИИ СИНДРОМА ХОЛЕСТАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ {

- =повышение уровня щелочной фосфатазы
 - ~повышение уровней аминотрансфераз
 - ~повышение уровня гамма-глобулинов
 - ~снижение уровня липопротеидов
- }

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =панцитопения

~гипохромия эритроцитов
~анизо-пойкилоцитоз
~макроцитоз эритроцитов
}

ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО АНЕМИИ И ТРОМБОЦИТОПЕНИИ,
БЛАСТОЗА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О {
=остром лейкозе
~апластической анемии
~В12-дефицитной анемии
~системной красной волчанке
}

В III СТАДИИ ДВС-СИНДРОМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ {
=тромбоцитопения
~тромбоцитоз
~нормокоагуляция
~гиперкоагуляция
}

БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНА С
ПОМОЩЬЮ {
=спирографии
~бронхоскопии
~исследования газов крови
~рентгенологического исследования
}

ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ {
=через 48 и более часов после поступления в стационар
~в момент поступления в стационар и позднее
~через 12 и более часов после поступления в стационар
~через 24 и более часов после поступления в стационар
}

СИМПТОМОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ {
=гипопротеинемия
~гиперпротеинемия
~гематурия
~артериальная гипертензия
}

ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО ПРОТЕИНУРИИ 7 Г/СУТКИ, АНЕМИИ,
ГИПОАЛЬБУМИНЕМИИ, БОЛИ В КОСТЯХ И ПОВЫШЕНИИ СОЭ ДО 68
ММ/ЧАС НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ {

- =миеломную болезнь
- ~амилоидоз почек
- ~хронический гломерулонефрит
- ~опухоль почки
- }

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ {

- =снижение продукции эритропоэтина
- ~дефицит витамина В12
- ~дефицит железа
- ~кровопотеря
- }

БОЛИ В СУСТАВАХ ПРИ НАГРУЗКЕ, ПРОХОДЯЩИЕ В ПОКОЕ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ{

- =остеоартроза
- ~подагрического артрита
- ~ревматоидного артрита
- ~реактивного артрита
- }

ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ, ЯВЛЯЕТСЯ {

- =депрессия сегмента ST
- ~патологический зубец Q
- ~полная блокада ножек пучка Гиса
- ~удлинение интервала PQ
- }

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ВЫСТУПАЕТ {

- =нагрузочный тест
- ~электрокардиография
- ~эхокардиография
- ~рентгенография сердца
- }

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛЯ МИТРАЛЬНОЙ ЕЮНФИГУРАЦИИ СЕРДЦА, ВЫЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ПЕРКУССИИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ {

- =смещение вверх верхней границы и сглаживание «тали» сердца
- ~смещение вправо правой границы
- ~треугольная форма сердца

~смещение левой границы влево
}

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА ПРИ {
=остром коронарном синдроме с подъемом ST
~остром коронарном синдроме без подъема ST
~любом острым коронарном синдроме
~нестабильной стенокардии
}

К ТРОМБОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ {
=Тенектеплазу
~Бивалирудин
~Фондапаринукс
~Эноксапарин
}

ПРИ ДВУСТОРОННЕМ СТЕНОЗЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ {
=ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
~диуретики
~блокаторы кальциевых каналов
~агонисты имидазолиновых рецепторов
}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ
КОНТРОЛЬ {
=международного нормализованного отношения
~активированного частичного тромбопластинового времени
~агрегации тромбоцитов
~уровня фибриногена
}

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНОГО ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ {
=непрерывно
~в период обострения заболевания
~в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов
~весной и осенью
}

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ПРИМЕНЯЕТСЯ {
=Сальбутамол
~Ипратропия бромид

~Флутиказон
~Натрия кромогликат
}

ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ {
=Флутиказон
~Гидрокортизон
~Преднизолон
~Дексаметазон
}

К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ ВНУТРИКЛУБЧКОВУЮ
ГИПЕРТЕНЗИЮ, ОТНОСЯТ {
=ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
~бета-адреноблокаторы
~диуретики
~статины
}

ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНОГО С
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ГЕМОДИАЛИЗ ЯВЛЯЕТСЯ {
=высокая гиперкалиемия
~выраженная олигурия
~анасарка
~тяжелая гипертония
}

ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ {
=Аторвастатин
~Эналаприл
~Торасемид
~Ацетилсалициловая кислота
}

К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСИТСЯ {
=Клопидогрел
~Изосорбида динитрат
~Бисопролол
~Эналаприл
}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ
КОНТРОЛЬ {
=активированного частичного тромбопластинового времени
~международного нормализованного отношения

~агрегации тромбоцитов
~уровня фибриногена
}

ПОБОЧНУЮ РЕАКЦИЮ В ВИДЕ ОТЁКА ЛОДЫЖЕК И СТОП МОЖЕТ
ВЫЗЫВАТЬ {

=Амлодипин
~Метопролол
~Эналаприл
~Дигоксин
}

ТЯЖЕСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ {

=исследования функции внешнего дыхания
~аускультации легких
~перкуссии легких
~бронхографии
}

МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ {

=спирография
~рентгеноскопия
~ларингоскопия
~электрокардиография
}

МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ {

=имеет слизистый характер и белесоватый цвет
~имеет гнойный характер и при стоянии расслаивается
~очень скудная и трудно поддается оценке
~белая, пенистая, обильная
}

БОЧКООБРАЗНАЯ ФОРМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ
НОГТЕЙ ПАЛЬЦЕВ РУК («ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА») ПРИ
НЕАТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О
РАЗВИТИИ У БОЛЬНОГО {

=эмфиземы лёгких
~пневмоторакса
~острого респираторного заболевания
~пневмонии
}

ПОКАЗАНИЕМ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ОБЪЕМЕ 4 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =тяжелая персистирующая бронхиальная астма
 - ~тяжелая интермиттирующая бронхиальная астма
 - ~бронхиальная астма физического усилия
 - ~легкая интермиттирующая бронхиальная астма
- }

ПРОЯВЛЕНИЕМ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА III СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- {
- =гипоксическая кома
 - ~свистящее дыхание
 - ~амфорическое дыхание
 - ~немое легкое
- }

К ПРИЗНАКАМ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ {

- =приступы бронхоспазма на определенные аллергены
 - ~возникновение бронхиальной астмы в пожилом возрасте
 - ~приступы удушья при обострении хронического бронхита
 - ~частые ночные приступы бронхоспазма
- }

К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ {

- =свистящие хрипы на выдохе
 - ~бронхиальное дыхание
 - ~амфорическое дыхание
 - ~влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы
- }

ЗВУК РАЗЛИПАНИЯ АЛЬВЕОЛ, ВЫСЛУШИВАЕМЫЙ НА ВЫСОТЕ ВДОХА ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ, НАЗЫВАЕТСЯ {

- =крепитацией
 - ~флотацией
 - ~бронхофонией
 - ~шумом трения плевры
- }

ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ {

- =пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами
 - ~пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации
 - ~вирусную бронхопневмонию
 - ~эозинофильный инфильтрат
- }

НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПНЕВМОНИЮ,
ВОЗНИКШУЮ {

=позднее 48 часов после госпитализации человека

~у ранее не леченного человека

~у больного, лечившегося в домашних условиях от другого заболевания

~у беременной женщины после 20 недель беременности

}

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ АБСЦЕССА ЛЁГКИХ
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ С {

=кавернозным туберкулёзом лёгких

~хроническим бронхитом

~синдромом Хаммена - Рича

~бронхиальной астмой

}

МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХОЭКТАЗАМИ{

=имеет гнойный характер и при стоянии расслаивается

~всегда содержит свежую алую кровь

~имеет слизистый характер и белесоватый цвет

~белая, пенистая, обильная

}

ДЛИТЕЛЬНОЕ КРОВОХАРКАНИЕ ПРИ СУХОМ КАШЛЕ ЗАСТАВЛЯЕТ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОДОЗРЕВАТЬ {

=рак бронхов

~кавернозную форму туберкулеза легких

~бронхоэктатическую болезнь

~пневмокониоз

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=одышка

~повышение температуры тела

~похудание

~общая слабость

}

ВАРИАНТ ИНФАРКТА МИОКАРДА С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ
СИМПТОМАТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ {

=цереброваскулярным

~ангинозным

~аритмическим

~астматическим

}

ЭКГ-ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ II СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ I ЯВЛЯЕТСЯ{

=постепенное удлинение интервала P-Q при каждом сердечном цикле с последующим выпадением комплекса QRS

~выпадение комплекса QRS при нормальной продолжительности интервала P-Q

~отсутствие зубца P перед выпадением комплекса QRS

~выпадение каждого второго комплекса QRS

}

ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ДИСФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА ЯВЛЯЕТСЯ {

=выраженная синусовая брадикардия

~фибрилляция предсердий

~предсердная экстрасистолия

~атриовентрикулярная блокада 1 степени

}

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ{

=легочная артериальная гипертензия

~венозный застой в малом круге кровообращения

~повышение внутригрудного давления

~снижение сердечного выброса

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ВАЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ {

=метанефрины в крови или в моче

~содержание кортизола в плазме

~активность ренина плазмы

~суточную экскрецию альдостерона с мочой

}

РАЗВИТИЕ АСИСТОЛИИ ВОЗМОЖНО ПРИ КОМБИНАЦИИ ПРОПРАНОЛОЛА С {

=Верапамил

~Каптоприлом

~Фенобарбиталом

~Фуросемидом

}

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА F (ИЛИ A2) НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ{

=талассемии

- ~серповидно-клеточной анемии
- ~пароксизмальной ночной гемоглобинурии
- ~наследственном сфероцитозе

}

ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ {

- =гиперемией кожных покровов, головными болями
- ~увеличением объема циркулирующей крови
- ~полным и напряженным пульсом
- ~лейкоцитозом со сдвигом влево

}

БЕЛОК БЕНС-ДЖОНСА В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ {

- =миеломной болезни
- ~хроническом гломерулонефрите
- ~нефротическом синдроме
- ~макроглобулинемии Вальденстрема

}

КЛЕТКИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ {

- =хроническом лимфолейкозе
- ~хроническом миелолейкозе
- ~миеломной болезни
- ~остром миелобластном лейкозе

}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =макролиды
- ~цефалоспорины
- ~аминогликозиды
- ~защищенные аминопенициллины

}

У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСОКИХ ЗАОСТРЕННЫХ ЗУБЦОВ Т, БРАДИКАРДИИ ВЕРОЯТНА {

- =гиперкалиемия
- ~гипергликемия
- ~гипокалиемия
- ~гиперкальциемия

}

СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

- =менингеальным синдромом

- ~утратой сознания
- ~зрачковыми расстройствами
- ~двусторонними пирамидными знаками

}

НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ПРИ СПИННОЙ СУХОТКЕ
ОБУСЛОВЛЕНО {
=сенситивной атаксией
~вялыми параличами нижних конечностей
~мозжечковой атаксией
~табетической артропатией

}

ДЛЯ ПОЛИОМИЕЛИТА ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ {
=передних рогов спинного мозга
~передних корешков спинного мозга
~задних корешков спинного мозга подкорковых узлов

}

ДЛЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ {
=выраженные общемозговые, очаговые и менингеальные симптомы
~расстройства чувствительности по корешковому типу
~постепенное начало и отсутствие расстройств сознания
~предшествующие преходящие нарушения мозгового кровообращения

}

БАЗОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГИТА
ЯВЛЯЕТСЯ {
=исследование ликвора
~электроэнцефалография
~электронейромиография
~ангиография

}

НОЧНЫЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ С ТОШНОТОЙ,
ИНОГДА РВОТОЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ ПРИ {
=синдроме внутричерепной гипертензии
~инсульте
~невралгии тройничного нерва
~синдроме вегетативной дистонии

}

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=электроэнцефалография

- ~краниография
- ~компьютерная томография
- ~ангиография

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ{

- =атеросклероз
- ~фиброзно-мышечная дисплазия
- ~эмболия мозга
- ~гипертензионная гиперплазия интимы

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ{

- =назначение противосудорожных препаратов
- ~лечение курсами 1 -2 месяца
- ~физиотерапевтическое лечение
- ~назначение Прозерина

}

К ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЕ ОТНОСИТСЯ {

- =оперативное лечение
- ~терапия коагулянтными и дегидратирующими препаратами
- ~терапия антикоагулянтными и дегидратирующими препаратами
- ~консервативная терапия антихолинэстеразными препаратами

}

К ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ {

- =Бензонал
- ~Пенициллин
- ~Преднизолон
- ~Амоксициллин

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЮТ{

- =терапию коагулянтными и дегидратирующими препаратами
- ~оперативное лечение
- ~терапию антикоагулянтными и дегидратирующими препаратами
- ~консервативную терапию антихолинэстеразными препаратами

}

ДЛЯ СНЯТИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ ПРИМЕНЯЮТ {

- =Реланиум

~Аспирин
~Анальгин
~антибиотики
}

ПРИЗНАКОМ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=гиповолемия
~гипокалиемия
~гиперволемия
~гипертермия
}

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА 80 Г/Л И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
РЕТИКУЛОЦИТОВ МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО ПРИ {
=постгеморрагической анемии
~апластической анемии
~анемии при хронической почечной недостаточности
~острой лейкемии
}

ОТКРЫТЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЛОМ КОСТИ С {
=раной мягких тканей, сообщающейся с областью перелома
~образованием обширных фликтен над областью перелома
~раной мягких тканей, не сообщающейся с областью перелома
~обширной гематомой поврежденного сегмента конечности
}

ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ {
=любой медицинский работник на месте происшествия
~только врач
~только фельдшер бригады скорой помощи
~только врач-хирург
}

«МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)» (ФОРМА N 086/У)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ {
=несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу
~лиц, регистрирующихся на бирже труда
~работающих пенсионеров
~инвалидов III группы
}

РАННИМ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПЕЧЕНОЧНОГО
ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение АЛТ
~повышение активности альдолазы
~повышение протромбинового индекса
~гипоальбуминемия
}

ПРИЧИНАМИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ БЫВАЮТ {

=травмы носа, повышение артериального давления, заболевания крови
~заболевания сердца, длительный прием антибиотиков, переохлаждение тела
~кортикостероиды при ингаляциях, длительная иммобилизация тела, длительная искусственная вентиляция легких
~слабительные и мочегонные препараты, заболевания соединительной ткани, ожирение
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА ПРИМЕНЯЮТ {

=скарификационные кожные тесты, исследование IgE в крови и цитологии носового секрета
~рентгенографию околоносовых пазух, общий анализ мочи и кала на яйца глистов
~специфическую иммунотерапию, рентгенографию органов грудной клетки и функцию внешнего дыхания
~провокационные тесты, пробное лечение гормональными препаратами и бактериологическое исследование полости носа
}

ПРИЧИНАМИ СНИЖЕНИЯ ОБОНЯНИЯ МОГУТ БЫТЬ {

=затруднение носового дыхания, травма или опухоль мозга
~учащение носового дыхания или парез лицевого нерва
~особенности питания и эндокринная патология
~избыточно влажный или загрязненный воздух, болезни крови
}

ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СИНУСИТА ЯВЛЯЮТСЯ {

=затруднение носового дыхания, насморк, лицевые боли и снижение обоняния
~припухлость щеки, боли и увеличение лимфатических узлов шеи
~затрудненное болезненное дыхание через рот, кашель и чихание
~отсутствие носового дыхания, выделения из носа гнойно-кровянистые с запахом
}

УДАЛИТЬ СЕРНУЮ ПРОБКУ У ПАЦИЕНТА МОЖНО С ПОМОЩЬЮ {

=промывания теплой водой из шприца
~специального ушного крючка

~штыкового ушного пинцета
~ушных парафиновых свечей
}

ПАЦИЕНТА С БОЛЬЮ В УХЕ, СУБФЕБРИЛИТЕТОМ И ПРИПУХЛОСТЬЮ ЗА УШНОЙ РАКОВИНОЙ НЕОБХОДИМО СРОЧНО НАПРАВИТЬ К {
=врачу-оториноларингологу
~врачу-дерматологу
~врачу-хирургу
~врачу-педиатру
}

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С АЛЛЕРГИЕЙ НА ПЫЛЬЦУ БЕРЕЗЫ В ВИДЕ РИНИТА ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ {
=антигистаминные средства, топические кортикостероиды и антигенспецифическую иммунотерапию
~диету, частое проветривание помещений и деконгестанты
~иглорефлексотерапию, массаж и закаливание
~гипербарическую оксигенацию и дезинтоксикационную терапию
}

ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА, ПРОЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НЕОДНОКРАТНЫМИ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫМИ АБСЦЕССАМИ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ {
=тонзиллэктомию
~тонзиллотомию
~лакунотомию
~септопластику
}

РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНИТЕ {
=атрофическом
~вазомоторном
~гипертрофическом
~катаральном
}

ВОСПАЛЕНИЕ ВСЕХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ НАЗЫВАЕТСЯ {
=пансинуситом
~полисинуситом
~гемисинуситом
~риносинуситом
}

ДЛЯ ГЕМИСИНУСИТА ХАРАКТЕРНО {

=лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне

~воспаление всех околоносовых пазух

~поражение нескольких околоносовых пазух

~поражение одной околоносовой пазухи

}

ДИАГНОЗ «МОНОЦИТАРНАЯ АНГИНА» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ{

=крови

~мочи

~бактериологического

~цитологического

}

НЕКРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МИНДАЛИНАХ ВОЗНИКАЮТ ПРИ

{

=агранулоцитозе

~фарингите

~гриппе

~кори

}

БОЛЬНОГО С АНГИНОЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ{

=инфекционное

~оториноларингологическое

~терапевтическое

~хирургическое

}

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ НАЗЫВАЕТСЯ{

=фарингитом

~ларингитом

~тонзиллитом

~ринитом

}

НАЛЁТ НА МИНДАЛИНАХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛЫ ПРИ {

=дифтерии глотки

~лакунарной ангине

~язвенно-некротической ангине

~катаральной ангине

}

СИМПТОМ КЕРНИГА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ {

=менингите

~лабиринтите

~арахноидите

~сифилисе

}

ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВОМ, АКТИВНЫМ В ОТНОШЕНИИ
ШТАММОВ ГРИППА А, В, ЯВЛЯЕТСЯ{

=Озельтамивир

~Ремантадин

~Ламивудин

~Интерферон

}

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ
ПЕРЕСАДКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРИМЕНЯТЬ{

=Ганцикловир

~Валганцикловир

~Ацикловир

~Рибавирин

}

ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ ВАРФАРИНОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
КРОМЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ {

=Витамин К

~Кальция хлорид

~Аминокапроновую кислоту

~Этамзилат

}

ПРЕПАРАТОМ-АНТАГОНИСТОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ ПРИ
ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ВАРФАРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ{

=Витамин К

~Сулодексид

~Протамин

~Кальция хлорид

}

ПРИ ТЯЖЕЛОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОТРЕКСАТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЕННОИНЖЕНЕРНЫЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ{

=Инфликсимаб
~Циклофосфамид
~Бозентан
~Абциксимаб
}

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
НПВС-ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ {

=Омепразол
~Алгедрат
~Метилурацил
~Сукралфат
}

ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ОТРАВЛЕНИЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ НАСТУПАЕТ ОТ {

=остановки дыхания и сердечной деятельности
~удушья
~серой гипоксии
~присоединения вторичной инфекции
}

ДЕЙСТВИЕМ КАКИХ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА ОБУСЛОВЛЕНО
ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТАНОЛА {

=формальдегида
~триэтилсвинца
~щавелевой кислоты
~хлорэтанола
}

АНТИДОТАМИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЮТСЯ

{
=кислород, Ацизол
~Спирт этиловый, Антициан
~Атропина сульфат, Преднизолон
~противодымная смесь, карбоген
}

ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНИТЬ {

=обезболивание, наложение жгута, дать щелочное питье
~тугое бинтование, согревание конечности, дать щелочное питье
~обезболивание, наложение жгута, согревание конечности
~обезболивание, тугое бинтование, согревание конечности
}

ЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

{

=метанолом

~фосгеном

~тетраэтилсвинцом

~гидразином

}

В КАЧЕСТВЕ АНТИДОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИАНИДАМИ ПРИМЕНЯЮТ {

=метгемоглобинообразователи

~холинолитики

~анальгетики

~реактиваторы ацетилхолинэстеразы

}

ТАКТИКОЙ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ПО ДАННЫМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО ХОРОШЕМ САМОЧУВСТВИИ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ {

=направление на консультацию гематолога

~госпитализация в терапевтическое отделение

~обследование в поликлинике по месту жительства

~госпитализация в онкологическое отделение

}

ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КРУПНЫХ БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ {

=кашель с мокротой

~кашель без выделения мокроты

~одышка инспираторного характера

~повышение температуры тела

}

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МЕЛКИХ БРОНХОВ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=одышка

~кашель с мокротой

~повышение температуры тела

~кашель без выделения мокроты

}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОСПАЗМА С ПОМОЩЬЮ СПИРОГРАФИИ, ПНЕВМОТАХОГРАФИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБУ С ИНГАЛЯЦИЕЙ {

- =β₂-адреностимулятора
 - ~глюкокортикостероида
 - ~смеси кислорода и оксида азота
 - ~α₂-адреностимулятора
- }

ОДНОСТОРОННЯЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

- =острого пиелонефрита
 - ~острого цистита
 - ~амилоидоза почек
 - ~острого гломерулонефрита
- }

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ{

- =кистей
 - ~коленные
 - ~крестцово-подвздошные
 - ~позвоночные
- }

К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕМУСЯ ЛАБОРАТОРНОМУ ПРИЗНАКУ ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА ОТНОСЯТ{

- =HLA-B27
 - ~ревматоидный фактор
 - ~антинейтрофильные антитела
 - ~антимитохондриальные антитела
- }

ПРИСТУПЫ БРОНХОСПАЗМА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ{

- =Пропранолол
 - ~Симвастатин
 - ~Каптоприл
 - ~Ацетилсалициловая кислота
- }

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИТА ПРОВОДИТСЯ{

- =вне стационара
 - ~в стационаре
 - ~сначала вне стационара, затем в стационаре
 - ~сначала в стационаре, затем вне стационара
- }

41-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ПОВЫШЕНИЕМ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ, НЕОБХОДИМО
РЕКОМЕНДОВАТЬ {

=снизить вес

~ограничить физическую активность

~пить 3 литра воды ежедневно

~ограничить белки в диете

}

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ)
ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ {

=молодых мужчин

~женщин после климакса

~пожилых мужчин

~молодых девушек

}

ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У МУЖЧИНЫ 55 ЛЕТ,
ПЕРЕНЕСШЕГО 7 ЛЕТ НАЗАД РЕЗЕКЦИЮ ЖЕЛУДКА (В МАЗКЕ КРОВИ
МАКРОЦИТОЗ) ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ {

=цианкобаламина

~железа

~эритропоэтина

~пиридоксина

}

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ С ПИЩЕЙ ВИТАМИНА В12
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В12
РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ {

=4-5 лет

~3-4 месяца

~5-8 месяцев

~9-12 месяцев

}

ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА ПОРАЖАЮТСЯ {

=печень и мозг

~сердце и почки

~почки и легкие

~печень и почки

}

НА НАЛИЧИЕ ХОЛЕСТАЗА УКАЗЫВАЮТ {

=повышение щелочной фосфатазы, билирубина, холестерина
~повышение аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, глюкозы
~снижение протромбина, гемоглобина, фибриногена
~повышение амилазы, общего белка, креатинина
}

ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ {
=кожный зуд
~спленомегалия
~асцит
~гепатомегалия
}

УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ I СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ
РТ.СТ.) {
=150/95
~160/105
~170/100
~165/95
}

УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ II СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ
РТ.СТ.) {
=170/105
~180/90
~180/95
~160/110
}

УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ
РТ.СТ.) {
=180/115
~175/105
~165/95
~170/100
}

УРОВНЕМ ТРИГЛИЦЕРИДОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ФАКТОРОМ РИСКА
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
(ММОЛЬ/Л) {
=1,7
~1,2

~1,0
~0,7
}

КРАТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОДНОМ ВИЗИТЕ К ВРАЧУ СОСТАВЛЯЕТ{

=2
~1
~3
~4
}

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ НАЛИЧИЕ И ТЯЖЕСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ{

=оценка состояния глазного дна
~суточная экскреция с мочой кортизола
~содержание альдостерона в крови
~суточная экскреция адреналина
}

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗУБЕЦ {

=RV5,V6>RV4
~RV4>RV5, V6
~S1>R1
~RIII>RI
}

БОЛЬНЫМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ СЧИТАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИНДРОМА{

=метаболического
~астено-вегетативного
~диспептического
~постхолецистэктомического
}

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ОБУСЛОВЛЕНА{

=повышением секреции катехоламинов
~повышением секреции ренина
~избыточной секрецией минералокортикоидов
~повышением образования ангиотензина
}

ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ {

- =активация ренин-ангиотензиновой системы
 - ~избыточная секреция минералокортикоидов
 - ~повышенная секреция катехоламинов
 - ~повышенное образование ангиотензина
- }

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С СИНДРОМОМ ИЦЕНКО-КУШИНГА НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {

- =17-оксикортикостероида
 - ~тиреотропина
 - ~ренина
 - ~креатинина
- }

ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ТАХИКАРДИЯ, ПОСЛЕ ПРИСТУПА - ПОЛИУРИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

- =феохромоцитомы
 - ~синдрома Кона
 - ~синдрома Иценко-Кушинга
 - ~климактерического синдрома
- }

ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСШИРЕНА ПРИ {

- =артериальной гипертонии
 - ~митральном стенозе
 - ~хроническом легочном сердце
 - ~тромбоэмболии легочной артерии
- }

АКЦЕНТ 2 ТОНА НАД АОРТОЙ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ {

- =артериальной гипертонии
 - ~митральном стенозе
 - ~хроническом легочном сердце
 - ~тромбоэмболии легочной артерии
- }

УСИЛЕНИЕ 1 ТОНА НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ {

- =митральном стенозе
- ~митральной недостаточности
- ~хроническом легочном сердце

~тромбоэмболии легочной артерии
}

ЛЕВАЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА
ОБРАЗОВАНА {

=левым желудочком
~левым предсердием
~правым предсердием
~правым желудочком
}

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ {

=акцент 2 тона над аортой
~усиление 1 тона у основания мечевидного отростка
~акцент 2 тона над легочной артерией
~ослабление 1 тона на верхушке
}

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ %
МАССЫ МИОКАРДА {

=40
~10
~20
~15
}

ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
ПУЛЬСОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение
~повышение
~сначала снижение, потом повышение
~сначала повышение, потом снижение
}

К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ЧАЩЕ ПРИВОДИТ {

=трансмуральный инфаркт миокарда
~пароксизмальная желудочковая тахикардия
~фибрилляция предсердий
~суправентрикулярная тахикардия
}

ДЛЯ ДОСТОВЕРНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАСТОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ СОСТАВЛЯЕТ (%) {

=20

~10
~15
~5
}

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ ХАРАКТЕРЕН ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ
{
=гематомный
~пятнисто-петехиальный
~васкулитно-пурпурный
~смешанный
}

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С ПРИ ОСТРЫХ
ЛЕЙКОЗАХ СВЯЗАНА С {
=массивной трансфузионной нагрузкой препаратами крови
~глубокой иммуносупрессией на фоне химиотерапии
~токсическим поражением гепатоцитов цитостатиками
~генетической предрасположенностью пациентов
}

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПРОГНОЗА ПРИ ОСТРОМ
ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ ОТНОСИТСЯ {
=исходный лейкоцитоз выше $100 \times 10^9/\text{л}$
~мужской пол пациента
~выраженная лимфаденопатия в дебюте заболевания
~отсутствие лейкоцитоза
}

ПОВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {
=эссенциальной тромбоцитемии
~гепарин-индуцированной тромбоцитопении
~тромботической тромбоцитопенической пурпуры
~апластической анемии
}

КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ($\times 10^9/\text{л}$) {
=150 - 400
~150 - 200
~150 - 250
~100 - 150
}

ДЛЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТИП
КРОВОТОЧИВОСТИ{

=пятнисто-петехиальный
~гематомный
~васкулитно-пурпурный
~ангиоматозный
}

ПРИ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ В КОСТНОМ МОЗГЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ {

=гиперплазия мегакариоцитарного ростка
~повышенный процент плазматических клеток
~угнетение мегакариоцитарного ростка
~бластоз
}

ТЕНЯМИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА НАЗЫВАЮТСЯ {

=разрушенные ядра лимфоцитов
~полуразрушенные ядра моноцитов
~злокачественные клетки
~плохо окрашенные клетки
}

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ{

=опухоловой природы
~увеличения эритропоэтина
~снижения эритропоэтина
~системной гипоксии
}

ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ {

=ярко-красным оттенком кожи и слизистых
~желтушным цветом кожи
~бледностью кожи и слизистых
~синюшным оттенком слизистых
}

ГЛАВНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В КОСТНОМ МОЗГЕ ЯВЛЯЮТСЯ {

=более 10% плазматических клеток с чертами атипии
~лимфоидные клетки с чертами атипии
~плазмобласты в большом количестве
~миелобласты
}

ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ {

- =плоских костей
 - ~длинных трубчатых костей
 - ~крупных суставов
 - ~межфаланговых суставов
- }

ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ «АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ», ЯВЛЯЕТСЯ {

- =жировой метаморфоз кроветворного костного мозга в трепанобиоптате подвздошной кости
 - ~панцитопения в периферической крови
 - ~малоклеточный костный мозг по данным миелограммы
 - ~повышение билирубина за счет не прямой фракции
- }

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ОКАЗЫВАЮТ
ДЕЙСТВИЕ {

- =противовоспалительное
 - ~бронходилатационное
 - ~адреномиметическое
 - ~антихолинергическое
- }

К АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ {

- =Ипратропия бромид
 - ~Сальбутамол
 - ~Беклометазон
 - ~Фенотерол
- }

ОСНОВНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =глюкокортикоиды
 - ~метилксантины
 - ~ингибиторы фосфодиэстеразы 4
 - ~нестероидные противовоспалительные средства
- }

БРОНХОСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ {

- =Пропранолол
 - ~Фенотерол
 - ~Беклометазон
 - ~Сальбутамол
- }

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ {

=ингаляционные глюкокортикостероиды и β_2 -агонисты

~антибактериальные и муколитические препараты

~системные глюкокортикостероиды и метилксантины

~кромоны и антигистаминные препараты

}

УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА, ПРИ КОТОРОМ ПРОВОДЯТ ГЕМОДИАЛИЗ, СОСТАВЛЯЕТ (МКМОЛЬ/Л) {

=700

~400

~500

~600

}

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=Метотрексат

~Гидроксихлорохин

~Лефлуномид

~Сульфасалазин

}

ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ В ДИЕТЕ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ {

=белки

~углеводы

~соль

~жидкость

}

У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК, ОСНОВНЫМИ В ЛЕЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=изменение образа жизни и немедленное начало лекарственной терапии

~отказ от курения и отсрочка начала антигипертензивной терапии

~диетотерапия и эпизодический прием антигипертензивных препаратов

~ограничение физической нагрузки и психоэмоционального напряжения

}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РЕКОМЕНДУЮТСЯ {

=бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
~антагонисты кальция дигидропиридинового ряда, тиазидные диуретики
~антагонисты рецепторов ангиотензина 2, антагонисты кальция
~антагонисты альдостерона, ганглиоблокаторы
}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ {

=беременность
~пожилой возраст
~фибрилляция предсердий
~гипокалиемия
}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ {

=подагра
~фибрилляция предсердий
~атриовентрикулярная блокада
~хроническая сердечная недостаточность
}

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ {

=фибрилляции желудочков
~фибрилляции предсердий
~полной атриовентрикулярной блокаде
~асистолии
}

В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ГЛАВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ {

=таблетированных препаратов железа
~мясной диеты
~гемотрансфузий
~парентеральных препаратов железа
}

ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ ПРОВОДЯТ ВВЕДЕНИЕМ ХИМИОПРЕПАРАТОВ {

=эндолюмбальным
~внутривенным
~пероральным
~внутримышечным

}

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ» ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ {

=спирометрии

~коронарографии

~эхокардиографии

~полисомнографии

}

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ И ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=спирометрия

~бронхоскопия

~иммунологическое исследование

~рентгенография легких

}

ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ {

=ожирение

~пол

~возраст

~семейный анамнез ИБС

}

ПИЩЕВОД БАРРЕТТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ {

=гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

~стриктур пищевода

~дивертикулеза пищевода

~рака пищевода

}

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТЕРАПИИ {

=антибиотиками

~глюкокортикостероидами

~нестероидными противовоспалительными препаратами

~ионизирующим излучением

}

БЕЗБОЛЕВАЯ МАКРОГЕМАТУРИЯ, ЛИХОРАДКА В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦЕВ, УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА 170 Г/Л ЛИБО АНЕМИЯ, СОЭ 60 ММ/Ч У БОЛЬНОГО СТАРШЕ 45 ЛЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ {

=рака почки

~хронического гломерулонефрита гематурического типа

~волчаночного гломерулонефрита

~уратного нефролитиаза

}

АНЕМИЕЙ, ДЛЯ КОТОРОЙ ХАРАКТЕРНЫ ГИПОХРОМИЯ, СНИЖЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО ЖЕЛЕЗА И ДЕСФЕРАЛОВОЙ ПРОБЫ, ПОВЫШЕННАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЫВОРОТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ{

=железодефицитная

~гемолитическая

~апластическая

~В12-дефицитная

}

ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ ГРУППЫ РИСКА ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=профилактический осмотр

~учет обращаемости

~учет случаев временной нетрудоспособности

~телефонный опрос

}

ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ АНГИНЫ У ПАЦИЕНТА 20 ЛЕТ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ{

=Амоксиклав

~Ципрофлоксацин

~Амикацин

~Тетрациклин

}

ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ{

=эндоскопия

~рентгеноскопия

~рН - метрия

~УЗИ брюшной полости

}

ГИГАНТСКИМИ СЧИТАЮТСЯ ЯЗВЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ (СМ) {
=3
~4
~5
~6
}

В МОЧЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КЛЕТКИ ШТЕРНГЕЙМЕРА-МАЛЬБИНА ПРИ {
=пиелонефрите
~гломерулонефрите
~амилоидозе почек
~миеломной болезни
}

ГОЛОДНЫЕ И/ИЛИ «НОЧНЫЕ БОЛИ», ВОЗНИКАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ 2,5-4 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ПИЩИ, ЗАСТАВЛЯЮТ ДУМАТЬ О ЯЗВЕ {
=12-перстной кишки
~малой кривизны желудка
~фундального отдела желудка
~нижнего отдела пищевода
}

ПОД ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОНИМАЮТ ГРУППУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ИЛИ СИМПТОМОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОДОЗРЕВАТЬ {
=инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию
~стабильную стенокардию напряжения или впервые возникшую стенокардию
~постинфарктный кардиосклероз или хроническую аневризму левого желудочка
~жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости
}

ПОД СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОНИМАЮТ {
=преходящую потерю сознания вследствие общей гипоперфузии мозга
~обратимую потерю сознания вследствие эпилептического припадка или психогенной причины
~преходящую потерю сознания вследствие травматического повреждения головного мозга
~глубокое угнетение функции ЦНС вследствие экзогенной интоксикации
}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ {

- =гломерулонефрита
 - ~мочекаменной болезни
 - ~хронического пиелонефрита
 - ~вторичного амилоидоза
- }

ВЕДУЩИМ (ГЛАВНЫМ) МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ {

- =коронароспазм
 - ~стенозирующий атеросклероз
 - ~атеротромбоз коронарных сосудов
 - ~артериальная гипертензия
- }

БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =мозговой натрийуретический пептид
 - ~белок связывающий жирные кислоты
 - ~высокочувствительный тропонин I
 - ~МВ-фракция креатинфосфокиназы
- }

К СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ОТНОСЯТ {

- =обмороки
 - ~комы I и II ст.
 - ~панические атаки
 - ~транзиторные ишемические атаки
- }

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =ишемическая болезнь сердца
 - ~дилатационная кардиомиопатия
 - ~острый вирусный миокардит
 - ~гипертрофическая кардиомиопатия
- }

КРОВОХАРКАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ {

- =инфарктной пневмонии
 - ~идиопатического фиброзирующего альвеолита
 - ~острого инфаркта миокарда
 - ~обострения хронического бронхита
- }

БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ БРОНХОДИЛАТАТОРА КОЭФФИЦИЕНТ БРОНХОДИЛАТАЦИИ (КБД) ДОСТИГАЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ (%) {

=15

~38

~20

~26

}

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА НЕ НАЗНАЧАЮТ{

=Аллопуринол

~Метилпреднизолон

~Ацеклоклофенак

~Канакинумаб

}

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ И СЕРЬЕЗНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ{

=кровотечения

~аллергические реакции

~разрывы миокарда

~инфекционные заболевания

}

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АМИОДАРОНА ЯВЛЯЕТСЯ{

=дисфункция щитовидной железы

~синдром Стивенса-Джонсона

~остановка синусового узла

~острый инфаркт миокарда

}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=расслаивающая аневризма аорты

~беременность и первая неделя после родов

~прием антагонистов витамина К

~травматическая и длительная сердечно-легочная реанимация

}

К НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ КОМБИНАЦИЯМ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ СОЧЕТАНИЕ{

=бета-адреноблокатора и недигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов

~дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и тиазидного диуретика
~ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов
~дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и блокатора рецепторов к ангиотензину II
}

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОФВ1/ФЖЕЛ <70% И {
=ОФВ1 =50-80%
~ОФВ1 > 80%
~ОФВ1 =30-50%
~ОФВ1 < 80%
}

ЗНАЧИМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ПО ДАННЫМ ЭХО-КГ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСТУПАЕТ {
=вегетация на клапанах
~высокое давление наполнения левого желудочка
~наличие диастолической дисфункции
~наличие систолической дисфункции
}

СПЕЦИФИЧЕСКИМ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ НАЛИЧИЕ У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ {
=Ig E
~Ig M
~Ig A
~Ig G
}

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ЗИМНИЦКОГО НЕОБХОДИМО {
=исключить избыточное потребление жидкости
~соблюдать строгую диету с исключением соли
~ограничить физическую активность
~ограничить употребление белковой пищи
}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=декомпенсированная сердечная недостаточность
~тяжелая форма неспецифического язвенного колита

~острый парапроктит
~кровотоочащий геморрой
}

ДИСПАНСЕРНОМУ БОЛЬНОМУ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА В
ДОЗЕ (МГ/СУТ) {
=75-150
~25-50
~325-500
~500-1500
}

К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ИНГИБИТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ОТНОСЯТ {
=сухой кашель
~покраснение лица
~сердцебиение
~кожную сыпь
}

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ {
=диета
~лекарственная терапия
~фитотерапия
~иглорефлексотерапия
}

К СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ОТНОСЯТ {
=физические упражнения и массаж
~занятия спортом
~аэробику
~сеансы релаксации
}

К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ПО СТЕПЕНИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ОТНОСЯТСЯ {
=активные и пассивные
~гимнастические
~идеомоторные
~дренажные
}

ПАССИВНЫМИ НАЗЫВАЮТ УПРАЖНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ {

=с помощью инструктора без волевого усилия больного
~на велотренажере
~с помощью инструктора при выраженном волевом усилии больного
~мысленно (идеомоторные)
}

СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ {
=дыхательные
~корректирующие
~рефлекторные
~симметричные
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ {
=плантография
~измерение длины стопы
~пальпация стоп
~сбор анамнеза
}

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСАНКИ ОБСЛЕДУЕМЫЙ ДОЛЖЕН
НАХОДИТЬСЯ В {
=привычной позе
~положении лежа
~положении «смирно»
~положении сидя
}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СТАНОВОЙ СИЛЫ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=беременность
~сколиоз I степени
~избыток массы тела
~слабое физическое развитие
}

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА
ПРОБУ С НАГРУЗКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ {
=нормотоническая
~гипертоническая
~дистоническая
~гипотоническая
}

К СПЕЦИАЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ ОТНОСЯТСЯ {

=корректирующие

~идеомоторные

~рефлекторные

~дыхательные

}

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПРОБУ {

=Штанге

~Летунова

~Мартине

~Томайера

}

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ {

=мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболеваний

~проведение прививок

~мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний

~выявление заболеваний

}

ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ {

=ограничение приема поваренной соли

~отказ от употребления рыбы

~отказ от употребления кисло-молочных продуктов

~избегать физических нагрузок

}

ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТ {

=семейный

~бытовой

~производственный

~профессиональный

}

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОБЫ МАНТУ С 2ТЕ ППД- Л ЯВЛЯЕТСЯ {

=уколочная реакция

~гиперемия

~папула 4 мм

~папула 5 мм
}

КЛИНИЧЕСКИ МАЛОСИМПТОМНО ПРОТЕКАЕТ {

=очаговый туберкулез легких
~диссеминированный туберкулез
~казеозная пневмония
~фиброзно-кавернозный туберкулез
}

ВЫРАЖЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ {

=милиарный
~цирротический
~кавернозный
~очаговый
}

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА,
ОТНОСИТСЯ {

=язвенная болезнь желудка и ДПК
~ишемическая болезнь сердца
~хронический пиелонефрит
~желчнокаменная болезнь
}

К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТ {

=больного туберкулезом легких, выделяющего МБТ
~продукты питания
~больное животное
~предметы окружающей среды
}

ПЕРВИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ {

=дети и подростки
~лица 20-30 лет
~лица 30-40 лет
~лица 40-60 лет
}

«ШТАМПОВАННЫЕ» КАВЕРНЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА {

=подострого диссеминированного
~очагового
~милиарного

~инфильтративного
}

У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ С 2ТЕ ППД-Л
ВОЗНИКАЕТ РЕАКЦИЯ{

=только местная
~только общая
~местная и общая
~местная и очаговая
}

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ {

=мужчины
~подростки
~дети
~женщины
}

ХАРАКТЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ВЫСТУПАЮТ{

=лимфоидные, эпителиоидные, гигантские клетки Пирогова-Лангханса,
казеозный некроз
~клетки Березовского-Штернберга
~эпителиоидные гранулемы с единичными клетками Пирогова-Лангханса
~моноцитарная инфильтрация, эпителиоидные клетки
}

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
ЯВЛЯЕТСЯ{

=сахарный диабет
~гипертоническая болезнь
~хронический вирусный гепатит
~микседема
}

НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ ПРИ НЕВРИТЕ СЛУХОВОГО НЕРВА{

=Стрептомицин
~Рифампицин
~Этамбутол
~Этионамид
}

ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ КАНАМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ {

=нефротоксичность
~гепатотоксичность

~нейротоксичность
~кардиотоксичность
}

ДЕПРЕССИЯ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ ТИПИЧНА ДЛЯ {
=приступа стенокардии напряжения
~приступа вариантной (вазоспастической) стенокардии
~перикардита
~аневризмы левого желудочка
}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО МИОКАРДИТА
ЯВЛЯЮТСЯ {
=вирусные инфекции
~бактериальные инфекции
~грибковые инфекции
~воздействия токсинов
}

ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ ЦЕЛЕВЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛПНП, СОСТАВЛЯЮЩИЙ (ММОЛЬ/Л) {
=1,8
~2,5
~3,0
~3,5
}

УВЕЛИЧЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА
НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО ПРИ {
=гепатоцеллюлярном раке
~карциноме толстой кишки
~раке поджелудочной железы
~карциноме желчного пузыря
}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ {
=Преднизолон
~Циклоспорин
~Триамцинолон
~Ламивудин
}

ПРИ КВАШИОРКОРЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ {
=отёк
~гиперальбуминемия

~гипергликемия
~эйфория
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ {
=Метронидазол
~Цефалексин
~Ацикловир
~Омепразол
}

НАЛИЧИЕ ТРИАДЫ СИМПТОМОВ - СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ЖКТ, ДИАРЕЯ -
УКАЗЫВАЕТ НА {
=синдром Золлингера-Эллисона
~язвенную болезнь с локализацией в желудке
~язвенный колит
~хронический панкреатит
}

ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ГЕПАТИТЕ ЭХОГЕННОСТЬ
ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ {
=пониженная
~повышенная
~средней интенсивности
~нормальная
}

ТИПИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭКГ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=элевация сегмента ST
~депрессия сегмента ST
~инверсия зубцов T
~развитие блокады левой ножки пучка Гиса
}

В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКАЯ
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ
НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ В КРОВИ {
=натрийуретических пептидов
~катехоламинов
~альдостерона
~ренина
}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ{

=двусторонний стеноз почечных артерий

~гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка

~аортальный стеноз

~констриктивный перикардит

}

К ВЕНОЗНЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ{

=нитраты

~дигидропиридины

~ингибиторы АПФ

~постсинаптические α-адреноблокаторы

}

ПОЖИЛЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ГОД){

=от 60 до 74

~от 70 до 80

~от 75 до 89

~от 80 до 94

}

СТАРЧЕСКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ГОД) {

=от 75 до 89

~от 70 до 80

~от 60 до 74

~от 80 до 94

}

ОСОБЕННОСТЬЮ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ{

=уменьшение всасывания лекарственных средств (ЛС) в пищеварительном тракте

~уменьшение объема распределения водорастворимых ЛС

~увеличение объема распределения водорастворимых ЛС

~уменьшение объема выделяемой мочи почками

}

ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО БРОНХИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ{

=очаговая пневмония

~хронический бронхит

~туберкулез

~рак легкого

}

К РАЗВИТИЮ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ {

=постельный режим

~физическое переутомление

~перегревание

~психоэмоциональный стресс

}

ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение порога болевой чувствительности

~снижение порога болевой чувствительности

~ослабление воспалительной реакции

~усиление воспалительной реакции

}

ПРИЗНАКОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ {

=усиление одышки и выделения мокроты

~появление ночной потливости и интоксикации

~полиурия на фоне гипертермии

~анурия на фоне гипертермии

}

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ {

=возможное нарушение всасывания лекарств

~ускоренное выведение лекарств почками

~вероятность повышенного метаболизма

~значительное усиление всасываемости лекарств

}

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВ У ПОЖИЛЫХ СВЯЗАНО С {

=снижением функции печени и почек

~снижением кровотока в зоне микроциркуляции

~нарушением всасывания лекарств в желудочно-кишечном тракте

~повышением всасывания лекарств в желудочно-кишечном тракте

}

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ КЛИНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ {

=общее улучшение самочувствия

~литическое снижение температуры
исчезновение кашля и мокроты
~нормализация ночного сна
}

АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ
{
=беременность
~хронический пиелонефрит
~внебольничная пневмония
~аутоиммунный тиреоидит
}

ДИАГНОЗ «НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ» НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО
МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ {
=болях в эпигастральной области до приема пищи
~учащении приступов стенокардии
~появлении ночных приступов стенокардии
~выявлении стенокардии в течение 1 месяца
}

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ {
=тетрада Фалло
~открытое овальное окно
~аневризма межпредсердной перегородки
~евстахиев клапан
}

ТОЧКА БОТКИНА-ЭРБА, РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ В IV МЕЖРЕБЕРЬЕ
СЛЕВА ОТ ГРУДИНЫ, СЛУЖИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫСЛУШИВАНИЯ КЛАПАНА {
=аортального
~митрального
~трикуспидального
~легочной артерии
}

ДЕФИЦИТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С
{
=фибрилляцией предсердий
~артериальной гипертензией
~полной блокадой левой ножки пучка Гиса
~недостаточностью аортального клапана
}

НЕСООТВЕТСТВИЕ КОРОНАРНОГО КРОВотоКА МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
НУЖДАМ МИОКАРДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

- =ишемической болезни сердца
 - ~гипертонической болезни
 - ~дилатационной кардиомиопатии
 - ~метаболического синдрома
- }

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ХОБЛ
ЯВЛЯЕТСЯ{

- =спирометрия
 - ~бронхоскопия
 - ~компьютерная томография
 - ~пикфлоуметрия
- }

ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ
КРОВИ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ{

- =эозинофилия
 - ~тромбоцитоз
 - ~лимфоцитоз
 - ~нейтрофилез
- }

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =нормализация температуры через 48-72 часа
 - ~полное рассасывание инфильтрата в легочной ткани
 - ~нормализация всех лабораторных показателей
 - ~нормализация температуры в утренние и дневные часы
- }

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ{

- =дисфония
 - ~остеопороз
 - ~гипергликемия
 - ~ожирение
- }

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ С
ОТСУТСТВИЕМ ЭФФЕКТА ОТ ВЫСОКИХ ДОЗ ИНГАЛЯЦИОННЫХ
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПОКАЗАНО ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ{

- =анти-IgE-антител

- ~стабилизаторов мембран тучных клеток
- ~антилейкотриенов
- ~М-холинолитиков

}

ПЕРИОДОМ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ($T_{1/2}$) ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ {

- =снижения концентрации в плазме крови на 50%
- ~снижения концентрации в моче на 50%
- ~достижения органа-мишени 50% введенной дозы
- ~достижения максимальной концентрации в плазме крови

}

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУСЛОВЛЕННЫ {

- =фармакологическими свойствами лекарственного средства
- ~аллергическими реакциями немедленного или замедленного типа
- ~относительной или абсолютной передозировкой препарата
- ~нарушением иммунобиологических свойств организма

}

НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =угнетение дыхания
- ~судороги конечностей
- ~эндогенная депрессия
- ~понижение температуры

}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =ингибиторы протонной помпы
- ~блокаторы H_2 -рецепторов гистамина
- ~блокаторы дофаминовых рецепторов
- ~алюминийсодержащие гастропротекторы

}

МЕХАНИЗМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В {

- =угнетении проводимости болевых стимулов в центральной нервной системе
- ~снижении активности циклооксигеназы с ингибированием синтеза простагландинов и брадикинина
- ~снижении чувствительности рецепторов к медиаторам боли - гистамину и брадикинину

~угнетении холинергической иннервации гладкомышечных органов и спазмолитическом действии
}

ТЕНДИНИТ И/ИЛИ РАЗРЫВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ{

=фторхинолонов
~цефалоспоринов
~аминогликозидов
~карбапенемов
}

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОБОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТ {

=нефротоксичность
~гепатотоксичность
~кардиотоксичность
~гематотоксичность
}

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ{

=Амиодарон
~Дизопирамид
~Сульпирид
~Метформин
}

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГИНЕКОМАСТИЮ И ГИРСУТИЗМ СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ ДИУРЕТИК{

=Спиронолактон
~Гидрохлортиазид
~Торасемид
~Фуросемид
}

СИНДРОМ ОТМЕНЫ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ {

=глюкокортикостероидов
~бисфосфонатов
~Триметазидина
~Ранолазина
}

ЭРИТРОПОЭЗСТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ НА БЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ {

=эритропоэтины (альфа, бета, дельта, омега)

~ингибиторы пролилгидроксилазы

~ЭПО-миметики

~ингибиторы транскриптазы

}

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ИСПОЛЬЗУЮТ {

=стимуляторы эритропоэза

~стимуляторы лейкопоэза

~аналоги нуклеозидов

~иммунодепрессанты

}

ПРИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ: СТИМУЛЯТОРЫ ЭРИТРОПОЭЗА С ПРЕПАРАТАМИ {

=железа

~кальция

~калия

~магния

}

ПОДБОР ДОЗЫ НЕФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГЕПАРИНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ {

=активированного частичного тромбопластинового времени

~международного нормализованного отношения

~растворимых фибрин-мономерных комплексов с фибриногеном

~активированного времени рекальцификации белка фибрина

}

К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ С АЛЛЕРГИЕЙ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА НА ПЕНИЦИЛЛИН В АНАМНЕЗЕ ОТНОСЯТСЯ {

=макролиды

~антрациклины

~аминопенициллины

~фторхинолоны

}

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ РЕКОМЕНДОВАНО {

=делать перерыв в приеме нитратов 8-12 часов

~принимать нитраты с ментолсодержащим препаратом
~комбинировать нитраты с бета-адреноблокаторами
~принимать нитраты регулярно каждые 4-6 часов
}

ИЗ-ЗА ТЕРАТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧАТЬ {
=Варфарин
~Метилдопу
~Ранитидин
~Фенолфталеин
}

КАНЦЕРОГЕНЕЗ ОТНОСЯТ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОБОЧНЫМ
РЕАКЦИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТИПА {
=D (отсроченные)
~B (непредсказуемые)
~A (предсказуемые)
~C («химические»)
}

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ {
=фармаконадзором
~комплаенсом
~фармакоинспекцией
~фармакоэкономикой
}

УСИЛЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПРИ СОЧЕТАНИИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С {
=бета-адреноблокаторами
~ингибиторами протонной помпы
~блокаторами рецепторов к ангиотензину II
~ингибиторами ксантиноксидазы
}

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА
(ПЕРВОЙ СТАДИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ) ЯВЛЯЕТСЯ {
=Урсодезоксихолевая кислота
~Аминометилбензойная кислота
~Аминодигидрофалазиндион натрия
~Протеинсукциниллат железа

}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕКИШЕЧНОЙ ФОРМЫ АМЕБИАЗА (АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ) ЯВЛЯЮТСЯ {

- =Метронидазол, Орнидазол, Тинидазол
 - ~Паромомицин, Ципрофлоксацин, Меропенем
 - ~Тетрациклин, Метациклин, Доксициклин
 - ~Доксорубицин, Карминомицин, Рубомицин
- }

К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА (УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ) ОТНОСЯТ {

- =Амиодарон, Соталол, Дронедарон
 - ~Метопролол, Бетаксалол, Бисопролол
 - ~Аллапинин, Пропафенон, Этакизин
 - ~Хинидин, Новокаиномид, Дизопирамид
- }

ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ (ГИДРОКОРТИЗОНОМ, КОРТИЗОНОМ) ПРОВОДЯТ ПРИ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДОЗАХ {

- =физиологических, 2/3 дозы утром и 1/3 дозы вечером
 - ~фармакологических, 1/3 дозы утром и 2/3 дозы вечером
 - ~супрафизиологических, равными дозами 3 раза в день
 - ~супрафизиологических, один раз в день утром
- }

ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШКАЛУ {

- =CRB-65
 - ~HAS-BLED
 - ~SOFA
 - ~MRC
- }

ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС){

- =48-72
 - ~12-24
 - ~72-96
 - ~96-120
- }

ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ {

- =Бициллин
- ~Ампициллин
- ~Цефтриаксон
- ~Супрастин
- }

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ
ВАРФАРИНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ {

- =международного нормализованного отношения (МНО)
- ~активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
- ~активированного времени рекальцификации (АВР)
- ~растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)

}

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ {

- =Нитроглицерина
- ~Эналаприла
- ~Метопролола
- ~Фуросемида

}

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМА
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ{

- =Амиодарон
- ~Новокаинамид
- ~Лидокаин
- ~Метопролол

}

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЯВЛЯЕТСЯ{

- =проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в течение 90-120 минут от первого контакта с медицинским персоналом
- ~проведение системной тромболитической терапии на догоспитальном этапе с последующим проведением ЧКВ
- ~проведение системной тромболитической терапии
- ~проведение ЧКВ в течение 24 часов после начала симптомов

}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =геморрагический инсульт в анамнезе
- ~язвенная болезнь желудка в анамнезе

~геморрагический васкулит
~артериальная гипертензия
}

ИМПЛАНТАЦИЯ КАВА-ФИЛЬТРА ДОЛЖНА БЫТЬ РАССМОТРЕНА ПРИ
{
=рецидивирующей ТЭЛА на фоне приема антикоагулянтов
~массивной ТЭЛА
~тромбозе глубоких вен
~планируемом оперативном вмешательстве высокого риска
}

ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГИБИТОРОВ АПФ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=кашель
~головная боль
~запоры
~мышечная слабость
}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=беременность
~гипокалиемия
~обструктивное заболевание легких
~гипергликемия
}

У МУЖЧИНЫ 78 ЛЕТ С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ АГ С НАЗНАЧЕНИЯ {
=Доксазозина
~Карведилола
~Кандесартана
~Гидрохлортиазида
}

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С {
=ИБС (стенокардией и постинфарктным кардиосклерозом)
~нефропатией
~перенесенным инсультом
~подагрой
}

У БОЛЬНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА,
ЦЕЛЕВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ АД МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.) {
=140/90
~130/80
~125/80
~130/85
}

ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО {
=постепенное развитие
~острое начало
~кризовое течение
~выявление наследственности
}

ИСТОНЧЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН, СУХОСТЬ И
ЛОМКОСТЬ ВОЛОС, СГЛАЖЕННОСТЬ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА,
НАРУШЕНИЕ ГЛОТАНИЯ СУХОЙ ПИЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ
{
=сидеропенического синдрома
~общееанемического синдрома
~фуникулярного миелоза
~гемолитического криза
}

ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО {
=снижение ферритина и повышение ОЖСС
~повышение ферритина и снижение ОЖСС
~снижение ферритина и снижение ОЖСС
~повышение ферритина и повышение ОЖСС
}

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ РАЗМЕР ЭРИТРОЦИТА, В ОБЩЕМ
АНАЛИЗЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=MCV
~MCH
~MCHC
~RDW
}

К ГРУППЕ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ {
=сидероахрестическая
~апластическая
~B12-дефицитная
~микросфероцитарная

}

ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ
МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ СКЛОННОСТЬ К{

=панцитопении
~лейкоцитозу
~тромбоцитозу
~появлению миелоцитов
}

ФУНИКУЛЯРНЫЙ МИЕЛОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ {

=В12-дефицитной
~апластической
~железодефицитной
~гемолитической
}

ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, БОЛИ В
ЖИВОТЕ, УМЕРЕННАЯ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ ХАРАКТЕРНЫ
ДЛЯ АНЕМИИ {

=гемолитической
~фолиеводефицитной
~железодефицитной
~В12-дефицитной
}

РЕТИКУЛОЦИТОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ {

=гемолитической
~фолиеводефицитной
~железодефицитной
~В12-дефицитной
}

К ГРУППЕ ГЕМОГЛОБИНОПАТИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ {

=серповидно-клеточная
~микросфероцитарная
~железодефицитная
~В12-дефицитная
}

ГЕПАТО- И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА {

=гиперпластического
~геморрагического
~анемического

~инфекционно-токсического
}

ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ, ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ,
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=полицитемии

~острого лейкоза

~хронического лейкоза

~миелофиброза

}

ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЩЕГО УРОВНЯ БЕЛКА ЗА СЧЕТ {

=парапротеина

~гамма-глобулина

~альбумина

~альфа-глобулина

}

ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ
АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ
{

=выработка аутоантитромбоцитарных антител

~образование патологических иммунных комплексов

~дефицит плазменных факторов свертывания

~активация тканевого тромбопластина

}

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ, ОБШИРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ,
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

{

=ДВС-синдрома

~геморрагического васкулита

~гемолитической анемии

~болезни Рандю-Ослера

}

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРВЫЕ
ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение уровня ретикулоцитов

~уменьшение числа микроцитов

~повышение уровня сывороточного железа

~нормализация уровня билирубина

}

ВО ВРЕМЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО {

=назначение стероидов

~переливание свежзамороженной плазмы

~проведение плазмафереза

~назначение антибиотиков

}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ{

=язвенная болезнь желудка в стадии обострения

~язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии

~повторная беременность

~планируемое оперативное лечение миомы матки

}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЕКЦИЯ {

=тонкой кишки

~толстой кишки

~поджелудочной железы

~правого легкого

}

ПРИ СИДЕРОАХРЕСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ПРОТИВОПОКАЗАН {

=Феррум Лек

~Витамин В6

~Десферал

~Витамин С

}

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРОДОЛЖЕНИИ ФЕРРОТЕРАПИИ ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ {

=ферритина

~сывороточного железа

~общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

~трансферина

}

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ {

=Эритропоэтина

~Преднизолона

~Витамина В12

~Фолиевой кислоты
}

БЕРЕМЕННЫМ, ПОДРОСТКАМ, ЛИЦАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНО ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ АЛКОГОЛЕМ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ {
=фолиевую кислоту
~витамин В12
~микроэлементы
~витамин С
}

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРОВОДИТСЯ {
=ежемесячно по 500 мкг витамина В12
~ежедневно по 500 мкг витамина В12
~1000 мкг витамина В12 1 раз в год
~1000 мкг витамина В12 1 раз в полгода
}

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ {
=кальцинатов в головке поджелудочной железы
~повышенной активности эластазы в кале
~пониженной активности диастазы мочи
~большого количества жира в кале
}

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ УРОВЕНЬ {
=глюкозы и инсулина натощак
~липазы и амилазы после пробного завтрака
~холестерола и триглицеридов натощак
~железа и витамина В12 после пробного завтрака
}

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ «СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ» МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ПОЛНОГО КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И {
=исключения других заболеваний
~гистологического подтверждения
~иммуногистохимического подтверждения
~ирригоскопического подтверждения
}

ПРИ ПОВЫШЕНИИ БИЛИРУБИНА, ТИПИЧНОМ ДЛЯ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА, НАДО ИСКЛЮЧИТЬ {

- =гемолитическую анемию
 - ~инфекционный мононуклеоз
 - ~острый вирусный гепатит А
 - ~хроническую алкогольную интоксикацию
- }

ДИАГНОЗ «ГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ (ЦЕЛИАКИЯ)» ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕМ {

- =антител к тканевой трансглутаминазе в крови
 - ~непереваренного глиадина и ретикулина в кале
 - ~свободных дезаминированных пептидов глютена в моче
 - ~альфа-амилазы (птиалина) в виде L-изомера в слюне
- }

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЛЮТЕНОВУЮ ЭНТЕРОПАТИЮ (ЦЕЛИАКИЮ) ПОКАЗАНО БОЛЬНЫМ {

- =сахарным диабетом 1 типа
 - ~алиментарным ожирением
 - ~наследственной гиперхолестеринемией
 - ~первичным наследственным гемохроматозом
- }

СТАДИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В БЕЗ БИОПСИИ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ПРИ ПОМОЩИ {

- =транзиентной эластометрии
 - ~компьютерной томографии с контрастированием
 - ~магнитно-резонансной томографии
 - ~дуплексного ультразвукового сканирования
- }

ПРИ ГЕПАТОКАРЦИНОМЕ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ {

- =альфафетопротеина
 - ~прокальцитонина
 - ~гамма-глобулина
 - ~бетафитостерина
- }

ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА В КРОВИ СНИЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ {

- =церулоплазмина
- ~гамма-глобулина
- ~альфафетопротеина

~альфа1 -антитрипсина
}

ЛЕЧЕНИЕ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ
СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ПРИМЕНЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА {
=внутри
~внутривенно
~внутри и внутривенно
~в свечах и в виде ректальной пены
}

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ {
=миалгию
~кашель
~ишиалгию
~брадипное
}

ПРЕПАРАТЫ ЛАКТУЛОЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ОСНОВАНИИ ИХ
СПОСОБНОСТИ {
=подавлять образование аммиака в кишечнике
~подавлять образование аммиака в мышцах
~усиливать связывание аммиака в печени
~усиливать выведение аммиака почками
}

СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ {
=pica chlorotica
~кожным зудом
~прогрессированием онихомикоза
~изменением дистальных фаланг пальцев по типу барабанных палочек
}

ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ
{ =повышение ОЖСС
~наличие мишеневидных эритроцитов
~микросфероцитоз
~снижение ОЖСС
}

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОЗА «ПРОК
СЕРДЦА» НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {
=эхокардиография

~ЭКГ

~рентгенография грудной клетки

~исследование крови на титры антистрептококковых антител

}

«БОЛЬШИМИ» КРИТЕРИЯМИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=ревмокардит, полиартрит, малая хорея, кольцевидная эритема

~вальвулит, артралгии, гематурия, лихорадка

~миокардит, полиартрит, узловатая эритема, тофусы

~лихорадка, узелки Ослера, острая клапанная регургитация

}

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ХАРАКТЕРНЫ {

=сердцебиение, ослабление I тона на верхушке, систолический шум, проводящийся в левую аксиллярную область

~перебои в работе сердца, трехчленный ритм на верхушке, синкопальные состояния

~кровохарканье, усиленный I тон на верхушке, диастолический шум на верхушке

~сердцебиение, ослабление I тона на верхушке, систолический шум в точке Боткина-Эрба

}

К ТИПИЧНЫМ ЖАЛОБАМ БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ОТНОСЯТ {

=синкопальные состояния

~тяжесть в правом подреберье

~опоясывающие боли в животе

~боли за грудиной постоянного характера

}

ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМОМ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ {

=систолический шум на верхушке

~хлопающий I тон

~мезодиастолический шум

~систолический шум у основания сердца

}

УСИЛЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

=аортальной недостаточности

~аортального стеноза

~трикуспидальной недостаточности

~митральной недостаточности
}

У БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА {
=систолическое АД повышается, а диастолическое АД снижается
~систолическое АД снижается, а диастолическое АД повышается
~систолическое АД не изменяется, а диастолическое АД повышается
~систолическое и диастолическое АД не изменяются
}

ПРИ ОПРОСЕ БОЛЬНОГО С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ МОЖНО
ВЫЯВИТЬ {
=жжение на языке, парестезии
~рвоту «кофейной гущей» и дегтеобразный стул
~отрыжку горьким, боль в правом подреберье
~извращение вкуса и обоняния
}

ЖАЛОБЫ НА СЛАБОСТЬ, ОБМОРОКИ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И
ОБОНЯНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО УКАЗЫВАЮТ НА АНЕМИЮ {
=железодефицитную
~гипопластическую
~гемолитическую
~В12 - дефицитную
}

НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=определение уровня ферритина
~расчет цветового показателя
~определение количества эритроцитов
~определение уровня гемоглобина
}

РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ВЫЗЫВАЕТСЯ {
=Р-гемолитическим стрептококком группы А
~стафилококком
~пневмококком
~Р-гемолитическим стрептококком группы В
}

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА, ЯВЛЯЕТСЯ {
=«пляска каротид»
~ундуляция шейных вен

~систолический шум во II межреберье слева
~диастолический шум во II межреберье слева
}

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТЕОАРТРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ {

=сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, остеофиты, кистовидные просветления в эпифизах
~сужение суставной щели, субхондральный остеопороз, эрозии, узурь~кисты в эпифизах
~сужение суставной щели, хондрокальциноз
}

СЕМЕЙНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ {

= α 1-антитрипсина
~глюкозо-6-фосфатазы
~глюкоцеребролидазы
~стероидов
}

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА, СОСТАВЛЯЮЩИЙ {
(Г/Л)

=70-89
~90-120
~менее 70
~90-130
}

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО {

=определить уровень глюкозы в крови натощак
~назначить препараты сульфонилмочевины
~ограничить употребление углеводов
~определить уровень базального инсулина
}

НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ КРИТЕРИЕМ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ {

=гликолизированный гемоглобин
~С-пептид
~средняя суточная гликемия
~уровень контринсулярных гормонов в крови
}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ {

=бактериурии

~антител к базальной мембране клубочков

~гематурии

~протеинурии

}

МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ», ЯВЛЯЕТСЯ {

=биопсия

~УЗИ органов брюшной полости

~биохимическое исследование крови

~компьютерная томография брюшной полости

}

К ПРИЧИНАМ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА ОТНОСЯТ {

=функциональную перегрузку с микротравматизацией

~эндокринные нарушения

~повторные кровоизлияния в сустав

~асептический некроз

}

РЕВМАТОИДНЫЕ УЗЕЛКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЛОКАЛИЗУЮТСЯ {

=в области локтевого сустава

~на пальцах кисти

~в области затылка

~на стопе

}

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АРТРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ {

=появление механических болей

~повышение кожной температуры над суставами

~появление припухлости суставов

~гиперпигментация кожи над пораженными суставами.

}

ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ {

=пальцы в виде «шеи лебедя»

~узелки Бушара

~хруст в суставах

~покраснение в области суставов
}

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХСН I СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при физической нагрузке
~наличие признаков недостаточности кровообращения по малому кругу в покое
~наличие признаков недостаточности кровообращения по большому кругу в покое
~наличие признаков застоя в малом и большом кругах кровообращения в покое
}

САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=артериальная гипертензия
~ишемическая болезнь сердца
~миокардит
~фибрилляция предсердий
}

ВОЛЬТАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (ИНДЕКСОМ СОКОЛОВА-ЛЯЙОНА) СЧИТАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММАРНОЙ АМПЛИТУДЫ ЗУБЦОВ R (В ОТВЕДЕНИИ V5 ИЛИ V6) И S (В ОТВЕДЕНИИ V1 ИЛИ V2) БОЛЕЕ (ММ) {
=35
~25
~40
~30
}

ЭКГ-КРИТЕРИЙ БЛОКАДЫ ПЕРЕДНЕЙ ВЕТВИ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА {
=резкое отклонение электрической оси влево
~деформация комплекса QRS
~расширение комплекса QRS $> 0,10$ с
~изменение конечной части желудочкового комплекса
}

СИСТОЛИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ {
=фактором риска развития мозгового инсульта
~признаком доброкачественного течения артериальной гипертонии

~причиной развития хронической сердечной недостаточности
~вариантом нормы
}

ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЁГКИХ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ {
=ОФВ 1
~ЖЕЛ
~МВЛ
~ОФВ 1/ФЖЕЛ
}

ДОСТОВЕРНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ
{
=индекс Тиффно
~остаточный объем легких
~ОФВ1
~жизненная емкость легких
}

СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ
ВЫСЛУШИВАЮТСЯ ПРИ {
=нарушении бронхиальной проходимости
~наличии жидкости в полости плевры
~повышении воздушности легких
~уплотнении легочной ткани
}

ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ {
=наличие свистящих хрипов на выдохе, усиливающихся при форсированном
дыхании~теплый цианоз
~ослабленное везикулярное дыхание
~«лающий» кашель
}

ДЕЙСТВИЕМ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ
СУЛЬФАНИЛАМИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ {
=усиление секреции инсулина поджелудочной железой
~восстановление физиологической чувствительности в-клеток к глюкозе
~повышение утилизации глюкозы в печени и мышцах
~замедление всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте
}

ДЛЯ БОЛЬНОГО С ДИАГНОЗОМ «ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ»
ХАРАКТЕРНА {

=раздражительность

~сонливость

~вялость

~заторможенность

}

СОЧЕТАНИЕ ТАХИКАРДИИ, ЭКЗОФТАЛЬМА И ТРЕМОРА
ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=диффузного токсического зоба

~сахарного диабета

~эндемического зоба

~гипотиреоза

}

ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ, ЖЖЕНИЯ, ОНЕМЕНИЯ, «ПОЛЗАНИЯ
МУРАШЕК» В ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ,
НЕРЕДКО В ПАЛЬЦАХ, СНИЖЕНИЕ АХИЛЛОВА И КОЛЕННОГО
РЕФЛЕКСОВ, ОСЛАБЛЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ И БОЛЕВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О {

=периферической полинейропатии

~микроангиопатии

~поражении ЦНС

~«перемежающейся хромоте»

}

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ {

=жирового гепатоза

~цирроза

~сердечной недостаточности

~диабетической нефропатии

}

СУХОСТЬ КОЖИ, КОЖНЫЙ ЗУД, ЖАЖДА И ПОЛИУРИЯ
НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ {

=сахарном диабете

~диффузном токсическом зобе

~гипотиреозе

~эндемическом зобе

}

СНИЖЕНИЕ ПАМЯТИ, ЗАПОР, БРАДИКАРДИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ {

=гипотиреоза

~диффузного токсического зоба

~сахарного диабета

~феохромоцитомы

}

СОЧЕТАНИЕ АНЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=хронической почечной недостаточности

~гипертонической болезни

~синдрома Иценко-Кушинга

~акромегалии

}

АБСОЛЮТНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=наличие признаков опухоли надпочечника и гиперпродукции катехоламинов

~увеличение концентрации в плазме крови альдостерона

~высокий уровень в моче 5-оксииндолуксусной кислоты

~низкий уровень катехоламинов в крови, оттекающей по почечным венам, и их концентрация в моче

}

ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У РАННИМ СИМПТОМОМ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ {

=немотивированная потеря аппетита

~нарушение функции кишечника

~метеоризм

~анемия

}

АСТМА ФИЗИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ВОЗНИКАЕТ {

=после физической нагрузки

~во время физической нагрузки

~на фоне длительного приема НПВП

~с сезонной периодичностью

}

ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ {

=кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет и более

~кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 1 месяца в году в течение 3 лет и более факторов риска: курения, поллютантов

~кашля, не проходящего в течение двух лет

}

ДЛЯ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНЫ {

=симптом «барабанных палочек», кашель с гнойной мокротой, кровохарканье

~кашель с гнойной мокротой, сухой кашель, кровохарканье

~кашель с гнойной мокротой, кровохарканье

~артралгии, кашель с гнойной мокротой, кровохарканье

}

АНТИМИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=первичного билиарного цирроза

~алкогольного цирроза

~болезни Вильсона-Коновалова

~острого гепатита В

}

ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ СНИЖЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=гипопротромбинемия

~гипертриглицеридемия

~гаптоглобулинемия

~гипоферментемия

}

ЛАБОРАТОРНЫЙ СИМПТОМ «КРЕАТОРЕЯ» ХАРАКТЕРИЗУЕТ {

=повышенное содержание в кале мышечных волокон

~повышенное содержание в кале нейтрального жира

~повышение содержания в кале липазы

~наличие остатков непереваренной пищи в кале

}

К ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ {

=наличие гиперхромной анемии в общем анализе крови

~выраженный болевой синдром в эпигастральной области, возникающий в ночное время

~изжогу, рвоту кислым содержимым

~появление прожилок крови в кале

}

ПОЗДНИЕ, «ГОЛОДНЫЕ», НОЧНЫЕ БОЛИ, ЛОКАЛИЗУЮЩИЕСЯ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=язвенной болезни 12-перстной кишки

~хронического гастрита

~язвенной болезни желудка

~цирроза печени

}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ {

=УЗИ органов брюшной полости

~дуоденальное зондирование

~обзорную рентгенографию органов брюшной полости

~ЭГДС

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ТЕРАПИИ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=желудочно-кишечные

~гепатотоксические

~нефротоксические

~кожные

}

АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НАПРАВЛЕНА НА {

=снижение частоты рецидивов язвенной болезни

~снижение секреции соляной кислоты

~уменьшение выраженности болевого синдрома

~ускорение рубцевания язвы

}

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПРАНОЛОЛА ЯВЛЯЕТСЯ {

=бронхиальная астма

~инфаркт миокарда

~хроническая сердечная недостаточность I ФК

~глаукома

}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ОБЫЧНЫХ ДОЗАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ {

=кандидоза ротоглотки, дисфонии
~язвы желудочно-кишечного тракта, стероидного диабета
~кандидоза ротоглотки, язвы желудочно-кишечного тракта
~частых инфекций носоглотки, синдрома Кушинга
}

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ I ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ {

=инсулином на фоне диетотерапии
~сульфаниламидными препаратами
~Акарбозой
~ограничением углеводов
}

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО {

=напоить пациента сладким чаем
~сделать инъекцию в/в инсулина
~сделать инъекцию в/в дибазола
~напоить пациента отваром шиповника
}

К ПРЕПАРАТАМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ {

=ингаляционные глюкокортикостероиды
~симпатомиметики короткого действия
~седативные препараты
~продолгированные холинолитики
}

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ {

=Амиодарона~Хинидина
~Пропранолола
~Этацизина
}

КАПТОПРИЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ {

=ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
~бета-адреноблокаторов
~антагонистов кальция
~альфа-адреноблокаторов
}

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ ОБУСЛОВЛЕНО {

=снижением чувствительности рецепторов сосудистой стенки

- ~активацией системы ренин-ангиотензин
- ~активацией симпатoadреналовой системы
- ~активацией лизосомальных ферментов печени

}

БОЛЬНЫМ С ХСН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ {

- =поваренной соли
- ~калорийной пищи
- ~солей калия
- ~солей магния

}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ВВОДИТЬ {

- =внутри перорально
- ~внутривенно
- ~внутримышечно
- ~подкожно

}

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ {

ЧЕРЕЗ

- =2-3 дня
- ~12 часов
- ~24 часа
- ~5-6 дней

}

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ С ПРОТЕИНУРИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ {

- =ингибиторы АПФ
- ~диуретики
- ~бета-адреноблокаторы
- ~блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда

}

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ {

- =МНО
- ~время кровотечения
- ~тромбиновое время
- ~уровень ретикулоцитов

}

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- {
- =протеинурия
- ~лейкоцитурия
- ~гематурия
- ~цилиндрурия
- }

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОБУ {

- =Реберга-Тареева
- ~по Нечипоренко
- ~Зимницкого
- ~Алдиса-Каковского
- }

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ {

- =Бета-адреноблокаторы
- ~антибиотики
- ~метилксантины
- ~симпатомиметики
- }

ПРЕПАРАТОМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППЕ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ЦОГ-2, ЯВЛЯЕТСЯ {

- =Целекоксиб
- ~Кетопрофен
- ~Ибупрофен
- ~Ацетилсалициловая кислота
- }

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ОТНОСЯТ {

- =полипы кишечника
- ~геморрой
- ~дивертикулярную болезнь кишечника
- ~язву кишечника
- }

К ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ {

- =здоровый образ жизни
- ~генетический фактор
- ~состояние окружающей среды
- ~медицинской обеспечение
- }

К УРОВНЯМ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ {

=общественное, групповое, индивидуальное

~общественное, групповое, общемировое

~групповое, индивидуальное, собственное

~групповое, индивидуальное, общемировое

}

НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ БЕЗ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЬШЕ (ММОЛЬ/Л) {

=1,7

~2,8

~1,1

~3,0

}

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ НАПРАВЛЯЮТ ПАЦИЕНТОВ {

=у которых выявлен повышенный уровень общего холестерина крови

~у которых выявлено ожирение

~подлежащих диспансеризации в текущем году

~старше 45 лет

}

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПРОВОДИТ {

=врач-терапевт

~врач-инфекционист

~врач-онколог

~врач-хирург

}

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ГРИППА ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННЫХ {

=микоплазмой

~кишечной палочкой

~пневмоцистой

~клебсиеллой

}

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ {

=проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л

~проба Пирке

~проба Коха
~градуированная кожная проба
}

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК {
=здоровье населения страны
~здоровье группы людей
~личное здоровье
~здоровье людей определенной этнической группы
}

МАММОГРАФИЯ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ (ГОД)
{
=40
~18
~30
~50
}

К ИСТОЧНИКАМ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ОТНОСЯТ {
=оливковое масло
~мясо
~молочные продукты
~зеленые овощи
}

НАЛИЧИЕ ЗОБА У ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА ЛИЦ, ЖИВУЩИХ В
ОДНОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ЗОБ {
=эндемический
~эпидемический
~спорадический
~диффузный токсический
}

ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ)
ОРГАНИЗУЕТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ/ГРУПП
ЗДОРОВЬЯ {
=II и III~I
~I и II
~I, II и III
}

ПРОГРАММА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ {

=спирометрию

~рентгенографию легких

~цитологическое исследование мокроты

~определение газового состава крови

}

К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ГЕМОВОГО ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ОТНОСЯТ {

=мясо

~молоко и молочные продукты

~гречневую крупу

~яблоки

}

К ПРИЧИНАМ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ {

=недостаточное употребление мясной пищи

~высокую физическую активность

~недостаточное употребление свежих овощей и фруктов

~недостаточное употребление фруктов и овощей, содержащих железо

}

ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В РОДДОМЕ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ {

=гепатита В и туберкулеза

~дифтерии

~кори

~коклюша

}

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ КАЖДОМУ ВЗРОСЛОМУ ГРАЖДАНИНУ 1 РАЗ В (ГОД) {

=3

~2

~1

~4

}

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ {

=всем подлежащим диспансеризации

~всем мужчинам в возрасте 21 -99 лет

~всем женщинам в возрасте 21 -99 лет
~по показаниям
}

ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ {

=в соответствии с показаниями, определенными на 1 этапе
~всем мужчинам в возрасте 45-66 лет
~всем женщинам в возрасте 45-66 лет
~всем подлежащим диспансеризации
}

ПОД АНТРОПОМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ {

=измерение роста и массы тела
~измерение роста
~анкетирование
~измерение силы рук
}

АНТРОПОМЕТРИЯ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ {

=всех, подлежащих диспансеризации
~всех желающих
~всех старше 40 лет
~пациентов с повышенным уровнем общего холестерина крови
}

БОЛЬНОЙ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ СО СТАБИЛЬНЫМ АД 220/120 ММ РТ.СТ. ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ У {

=врача-кардиолога
~врача-терапевта участкового
~заведующего терапевтическим отделением
~врача-нефролога
}

ПОЛИКЛИНИКА МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ {

=не более 10 месяцев
~до 1 месяца
~до 4 месяцев
~без ограничения срока
}

НОРМА НАГРУЗКИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ПОЛИКЛИНИКИ
СОСТАВЛЯЕТ ПОСЕЩЕНИЙ В ЧАС {

=4

~7

~6

~5

}

В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В РОССИИ ПЕРВОЕ РАНГОВОЕ
МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ {

=болезням системы кровообращения

~злокачественным новообразованиям

~болезням органов дыхания

~травмам и отравлениям

}

ЕДИНОЛИЧНО ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ МОЖЕТ ВЫДАТЬ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МАКСИМАЛЬНО НА (ДЕНЬ) {

=15

~7

=10

~30

}

ДАТОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=дата регистрации документов в бюро

~дата непосредственного освидетельствования

~дата открытия больно́го листа

~следующий день после регистрации документов в бюро

}

СРОКИ ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ
ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЮТ С __НЕДЕЛИ
БЕРЕМЕННОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДНЕЙ {

=30 140

~28 140

~28 180

~30 180

}

ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ПОВЫШЕН {

=адренокортикотропный гормон

~тиреотропный гормон

~соматотропный гормон

~альдостерон

}

ПРИЧИНОЙ ОДНОСТОРОННЕГО СМОРЩИВАНИЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

{

=пиелонефрит

~гломерулонефрит

~амилоидоз

~нефроптоз

}

ПРИЧИНОЙ МАССИВНОГО ОТЕЧНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНОЙ С АГ И СД, ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЕЙ И

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ СКОРЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ {

=нефротического синдрома

~сердечной недостаточности

~нарушений водно-электролитного баланса

~гипотиреоза

}

ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ, НА КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЕТИТЬ НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=вероятность наличия ИБС

~верификация ИБС

~наличие перенесенного в прошлом инфаркта миокарда

~наличие клапанной патологии

}

ОЖИРЕНИЕ 2 СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА (КГ/М2) {

=35,0-39,9

~18,5-24,9

~25,0-29,9

~30,0-34,9

}

К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ {

=курение

~пол

~возраст

~неблагоприятный семейный анамнез

}

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ {

=абдоминальный тип ожирения
~низкий уровень липопротеидов низкой плотности
~женский пол
~высокий уровень липопротеидов высокой плотности
}

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ {

=повышение уровня тропонина в крови
~элевация сегмента ST в двух и более отведениях на ЭКГ
~повышение уровня ЛДГ
~боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
}

БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ТОШНОТА, РВОТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=локализации инфаркта миокарда в области нижней стенки ЛЖ
~расслаивающей аневризмы грудного отдела аорты
~локализации инфаркта миокарда в области передней стенки ЛЖ
~тромбоэмболии легочной артерии
}

ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НИЖНЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРНА {

=элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF
~элевация сегмента ST в отведениях I, aVL, V1-V4
~остро возникшая блокада левой ножки пучка Гиса
~остро возникшая блокада правой ножки пучка Гиса
}

ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА БОКОВОЙ СТЕНКИ ЛЖ ХАРАКТЕРЕН ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST В ОТВЕДЕНИЯХ {

=I, aVL, V5-V6
~I, aVL, V1-V4
~VR3, VR4
~II, III, aVF
}

НАРУШЕНИЯ А-V ПРОВОДИМОСТИ ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНЫ С {

=нарушением кровотока по артерии АВ узла
~нарушением кровотока по артерии синусового узла
~обширностью повреждения боковой стенки ЛЖ
~повреждением межжелудочковой перегородки
}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ {

=боль за грудиной продолжительностью более 20 минут

~боль за грудиной, купирующаяся нитроглицерином

~коллапс

~внезапно развившаяся одышка

}

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИНЯТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССИФИКАЦИЮ {

=Killip

~NYHA

~Стражеско-Василенко

~GOLD

}

В ВЕРИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА БОЛЕЙ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА НАИБОЛЬШЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ {

=нагрузочный тест

~12-канальное суточное мониторирование ЭКГ

~холодовая проба

~одновременное суточное мониторирование ЭКГ и АД

}

ВЫСОКО-НОРМАЛЬНОЕ АД ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ АД (ММ РТ.СТ.) {

=139/89

~130/80

~140/90

~130/79

}

АД 160/90 ММ РТ.СТ. СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ {

=2

~1

~3

~4

}

ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=почечная ангиография

~УЗИ почек

~сцинтиграфия почек
~компьютерная томография почек
}

У ПАЦИЕНТКИ С АГ ПРИ РАЗНИЦЕ АД НА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РУКАХ
В 20 ММ РТ.СТ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ {

=болезнь Такаясу
~болезнь Кушинга
~атеросклеротическое поражение плечевой артерии
~болезнь Аддисона
}

КРИЗОВОЕ ТЕЧЕНИЕ АГ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=феохромоцитомы
~синдрома Кона
~синдрома Иценко-Кушинга
~акромегалии
}

ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА В
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШКАЛА {

=SCORE
~CHA2DS2-VASc
~HAS-BLED
~GRACE
~высокий уровень ЛПВП (>1,2 ммоль/л)
}

ПО ШКАЛЕ SCORE РАССЧИТЫВАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ В
БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ {

=фатальных осложнений
~инсульта
~инфаркта миокарда
~сердечной недостаточности
}

У ПАЦИЕНТКИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ, НАЛИЧИЕМ В
АНАМНЕЗЕ РЕЗЕКЦИИ ТОЩЕЙ И ЧАСТИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ
НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ БУДЕТ НАЗНАЧЕНИЕ {

=Феррум Лек внутримышечно
~Феррум Лек перорально
~Витамина В12 внутримышечно
~Фолиевой кислоты перорально
}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=синдром мальдигестии

~язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии

~повторная беременность

~планируемое оперативное лечение миомы матки

}

ДЛЯ ХОБЛ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%) {

=80

~50-80

~30-50

~< 30

}

ДЛЯ ХОБЛ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%) {

=30-50

~50-80

~80

~< 30

}

ДЛЯ ХОБЛ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%) {

=< 30

~50-80

~30-50

~> 80

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=стафилококк

~гемофильная палочка

~синегнойная палочка

~пневмококк

}

САМЫМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ У 60- ТИ ЛЕТНЕГО БОЛЬНОГО С АТЕЛЕКТАЗОМ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, ОДЫШКОЙ И НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=бронхоскопия

~спирометрическое исследование

~определение титра антител к ДНК
~перфузионная сцинтиграфия легких
}

В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА ПРЕОБЛАДАЕТ {

=прогрессирующая одышка
~гнойная мокрота в большом количестве
~длительная и рецидивирующая лихорадка
~бледно-розовая сыпь в области суставов
}

ДЛЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА ПРИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ТИПИЧНЫ {

=изменения по типу «матового стекла»
~диссеминированные инфильтративные изменения
~инфильтративные изменения в одном легком
~множественные полости в обоих легких
}

ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, СЛЕДУЕТ
НАЗНАЧАТЬ {

=макролиды
~пенициллины
~цефалоспорины
~тетрациклины
}

АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ {

=при гнойной мокроте
~при усилении кашля
~при появлении кровохарканья
~при нарастании одышки
}

ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО
СОЧЕТАНИЕ {

=отечного синдрома, протеинурии, диспротеинемии
~артериальной гипертонии, отечного синдрома, гематурии
~лихорадочного синдрома, диспротеинемии, лейкоцитурии
~артериальной гипертонии, протеинурии, лейкоцитурии
}

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НЕФРИТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ {

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

=интерстициальной ткани
~канальцевого аппарата
~ клубочкового аппарата
~мезангиальной ткани
}

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ
ЯВЛЯЕТСЯ {

=альбуминурия
~лейкоцитурия
~макрогематурия
~микрогематурия
}

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПИЕЛОНЕФРИТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ {

=энтеробактерия
~золотистый стафилококк
~синегнойная палочка
~смешанная флора
}

ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СЧИТАЕТСЯ {

=стрептококк
~стафилококк
~клебсиелла
~синегнойная палочка
}

РАННИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ АМИЛОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=протеинурия
~бактериурия
~лейкоцитурия
~цилиндрурия
}

ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНО
ПОЯВЛЕНИЕ {

=протеинурии
~макрогематурии
~лейкоцитурии
~гиперстенурии

}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СЧИТАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ В АНАЛИЗАХ МОЧИ {

- =протеинурии
 - ~лейкоцитурии
 - ~гипостенурии
 - ~бактериурии
- }

ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ {

- =гипопротеинемия и гиперлипидемия
 - ~гиперлипидемия и гипербилирубинемия
 - ~гиперпротеинемия и диспротеинемия
 - ~гиперфибриногенемия и гиперферментемия
- }

ПОЯВЛЕНИЕ В МОЧЕ БЕЛКА БЕНС-ДЖОНСА СЧИТАЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ИНФОРМАТИВНЫМ ДЛЯ {

- =миеломной нефропатии
 - ~анальгетической нефропатии
 - ~хронического гломерулонефрита
 - ~хронического пиелонефрита
- }

ПРЕПАРАТАМИ, СНИЖАЮЩИМИ ВНУТРИКЛУБОЧКОВУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ {

- =ингибиторы АПФ
 - ~тиазидные диуретики
 - ~антагонисты кальция
 - ~антикоагулянты непрямого действия
- }

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =снижение внутриклубочковой гипертензии
 - ~повышение реабсорбции натрия и воды в канальцах
 - ~снижение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон
 - ~повышение активности депрессорной системы почек
- }

В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЭФФЕКТИВНЫ {

- =глюкокортикоиды
- ~петлевые диуретики
- ~белковозамещающие препараты

~анаболические гормоны
}

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРОВИ НЕОБХОДИМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ {

=цитостатиками
~антибиотиками
~глюкокортикостероидами
~тиазидными диуретиками
}

НОРМАЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ СТОРОК {

=трех
~двух
~четырёх
~пяти
}

НОРМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ МИТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ СОСТАВЛЯЕТ (CM²) {

=4-6
~2-4
~6-8
~3-5
}

ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВЫ В ТАКТ СЕРДЦЕБИЕНИЮ (СИМПТОМ МЮССЕ) ТИПИЧНО ДЛЯ {

=недостаточности аортального клапана
~стеноза устья аорты
~недостаточности митрального клапана
~стеноза митрального клапана
}

ТЯЖЕЛЫМ СИСТЕМНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРОТЕКАЮЩИМ С РАЗРУШЕНИЕМ КЛАПАНОВ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ {

=инфекционный эндокардит
~токсическая кардиомиопатия
~острый перикардит
~миксоматозная дегенерация
}

ПЯТНА РОТА (БЕЛЫЕ ПЯТНА НА ГЛАЗНОМ ДНЕ) ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {
=инфекционного эндокардита
~артериальной гипертензии
~синдрома Марфана
~ревмокардита
}

К ПОЗДНЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ {
=аневризма левого желудочка
~разрыв стенки левого желудочка
~кардиогенный шок
~фибрилляция желудочков
}

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ {
=Капотена
~Допегита
~Лабетолола
~Нифедипина
}

ПАЦИЕНТАМ С АГ И ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ {
=Спиронолактон
~Триамтерен
~Диакارب
~Гидрохлортиазид
}

К ПЕТЛЕВЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ {
=торасемид
~хлорталидон
~амилорид
~спиронолактон
}

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ КАШЛЯ ПРИ ПРИЕМЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ СВЯЗАН С {
=увеличением продукции брадикинина в легких
~снижением содержания ангиотензина II
~снижением активности ренина плазмы
~увеличением продукции натрийуретических пептидов
}

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =а-агонисты центрального действия
 - ~тиазидные диуретики
 - ~ингибиторы АПФ
 - ~блокаторы рецепторов ангиотензина II
- }

ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ АГ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =ингибиторы АПФ
 - ~а-адреноблокаторы
 - ~неселективные Р-адреноблокаторы
 - ~диуретики
- }

К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ АГ ОТНОСЯТ {

- =блокаторы рецепторов ангиотензина II
 - ~а-адреноблокаторы
 - ~неселективные Р-адреноблокаторы
 - ~диуретики
- }

РАССЛОЕНИЕ АОРТЫ ТРЕБУЕТ НЕОТЛОЖНОГО {

- =хирургического вмешательства
 - ~тромболизиса
 - ~МРТ-исследования
 - ~антибактериального лечения
- }

ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИКОАГУЛЯНТОВ КУМАРИНОВОЙ ГРУППЫ ОПТИМАЛЬНА ПРИ
ПОДДЕРЖАНИИ МНО В ПРЕДЕЛАХ {

- =2,0-3,0
 - ~1,0-2,0
 - ~0-1,0
 - ~5,0-6,0
- }

ПРЕПАРАТАМИ, К КОТОРЫМ ВОЗНИКАЕТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ {

- =нитраты
- ~ингибиторы АПФ

~антагонисты кальция
~антикоагулянты
}

КОНТРОЛЬ АДЕКВАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ
НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ {
=МНО
~уровня фибриногена
~протромбинового индекса
~С-реактивного белка
}

В НОРМАЛЬНОМ ЛИМФОУЗЛЕ ПРИСУТСТВУЮТ {
=В- и Т-лимфоциты
~клетки миелоидного ряда
~эпителиоидные клетки
~только Т-лимфоциты
}

КЛОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРОИСХОДИТ
В {
=тимусе
~лимфоузлах
~костном мозге
~селезенке
}

ПРИЗНАКОМ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=высокий ретикулоцитоз
~тромбоцитопения
~лейкоцитоз
~повышение трансаминазной активности
}

СТЕРНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ {
=В12-дефицитной анемии
~железодефицитной анемии
~гемофилии
~болезни Виллебранда
}

НАЛИЧИЕ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ХРОМОСОМЫ ПАТОГНОМОНИЧНО
ДЛЯ {
=хронического миелолейкоза

~хронического волосатоклеточного лейкоза
~сублейкемического лейкоза
~острого промиелоцитарного лейкоза
}

СТЕРНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ {
=остром лейкозе
~хроническом лимфолейкозе
~болезни Виллебранда
~гемолитической анемии
}

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭОЗИНОФИЛОВ В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ
ХАРАКТЕРНЫМ ПРИ {
=бронхиальной астме
~стенокардии напряжения
~циррозе печени
~ревматоидном артрите
}

ЛЕЙКОЦИТОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ОТРАЖЕНИЕМ {
=пневмонии
~бронхиальной астмы
~вирусного гепатита
~стенокардии напряжения
}

СДВИГ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЛЕВО ЯВЛЯЕТСЯ
СЛЕДСТВИЕМ {
=бактериальной инфекции
~вирусной инфекции
~глистной инвазии
~физического перенапряжения
}

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ {
=ДВС-синдроме
~железодефицитной анемии
~гемолитической анемии
~эссенциальной тромбоцитемии
}

ТРОМБОЦИТОЗ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ {
=эссенциальной тромбоцитемии

~острого лейкоза
~железодефицитной анемии
~гемолитической анемии
}

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ {
=острой тромбоцитопенической пурпуре
~железодефицитной анемии
~гемолитической анемии
~эритремии
}

АНЕМИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ {
=хронической почечной
~острой печеночной
~острой сердечной
~хронической дыхательной
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ В12 - ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {
=исследование морфологии костного мозга
~оценка уровня витамина В12 в крови
~расчет лейкоцитарного индекса в крови
~оценка насыщения гемоглобином эритроцитов
}

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ {
=лихорадочный синдром
~тромбозы
~кровотечения
~тромбоцитоз
}

ЭРИТРОПОЭТИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ {
=анемии при хронической болезни почек
~анемии при острой почечной недостаточности
~анемии, аутоиммунном гемолизе
~лейкопении при воздействии цитостатиков
}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ
НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ {
=международное нормализованное отношение
~протромбиновый индекс по Квику

~уровень антитромбина III
~активированное парциальное тромбиновое время
}

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОЗАХ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ {
=наличие геморрагических осложнений
~хронометрические показатели гемостаза
~уровень агрегации тромбоцитов
~уровень фибринолитической активности крови
}

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПО ПАНЧЕНКОВУ РАВНОЕ 2 ММ В ЧАС ЯВЛЯЕТСЯ {
=нормальным для мужчин и женщин
~повышенным для мужчин и женщин
~нормальным для женщин
~пониженным для мужчин
}

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ {
=является частой причиной невынашивания беременности
~встречается исключительно у больных с гепатитом
~диагностируется с помощью исключительно иммунологических методов
~является редкой болезнью, не встречающейся в практике врача-терапевта
}

ПРИ ВЫБОРЕ ДИЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА БОЛЬНЫМ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ {
=мясные продукты
~яблоки
~гречневую крупу
~зелень
}

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ {
=полиартрит
~олигоартрит
~артралгия
~моноартрит
}

МОНОАРТРИТ, КАК ПРАВИЛО, ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ {
=подагре
~ревматоидном артрите

~анкилозирующем спондилоартрите
~системной красной волчанке
}

КРИТЕРИЕМ ДИАГНОЗА «ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА» ЯВЛЯЕТСЯ {

=полиартрит
~гломерулонефрит
~геморрагический васкулит
~пневмонит
}

СИНДРОМ РЕЙНО ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ {

=системной склеродермии
~ревматоидного артрита
~дерматомиозита
~узелкового полиартериита
}

К СИСТЕМНЫМ ВАСКУЛИТАМ, ПОВРЕЖДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КРУПНЫЕ СОСУДЫ, ОТНОСЯТ {

=артериит Такаясу
~узелковый полиартериит
~гранулематоз с полиангиитом
~пурпуру Шенлейн-Геноха
}

К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗИСНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ {

=Метотрексат
~соли золота
~аминохинолиновые производные
~Инфликсимаб
}

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СИНТЕЗА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПОДАГРЕ ИСПОЛЬЗУЮТ {

=Аллопуринол
~Диклофенак
~Гидрохлортиазид
~Цистон
}

ПРИЧИНОЙ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=бронхиальная обструкция
~трахеобронхит
~легочная рестрикция
~пневмония
}

ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ {

=набуханием шейных вен, уменьшающимся в вертикальном положении
~застоем крови в венозном русле большого круга кровообращения
~положительным венным пульсом
~акроцианозом, отёками стоп и голеней, усиливающимися к вечеру
}

ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ БРОНХИТОМ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО ВЫСЛУШАТЬ {

=сухие хрипы
~влажные хрипы
~шум трения плевры
~крепитацию
}

ПРИ ОСТРОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ {

=серозная
~геморрагическая
~гнойная
~хилезная
}

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ТИФФНО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ СОСТАВЛЯЕТ <(\%) {

=70
~50
~60
~80
}

ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ {

=одышка
~головная боль
~лихорадка
~слабость
}

К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ДАННЫМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ {

- =сухие свистящие хрипы
 - ~крепитацию
 - ~влажные разнокалиберные хрипы
 - ~шум трения плевры
- }

БОЛЬНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ {

- =бронхоэктатической болезни
 - ~бронхиальной астме
 - ~крупозной пневмонии
 - ~экссудативном плеврите
- }

ПРОКОЛ ПРИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- {
- =по верхнему краю ребра
 - ~по нижнему краю ребра
 - ~на середине расстояния между ребрами
 - ~между ребрами
- }

ДЛИТЕЛЬНОЕ КРОВОХАРКАНИЕ ПРИ СУХОМ КАШЛЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ О {

- =раке бронха
 - ~пневмонии
 - ~бронхоэктатической болезни
 - ~хроническом бронхите
- }

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ С {

- =хроническим синуситом, аденоидами
 - ~язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
 - ~сахарным диабетом
 - ~хроническим тонзиллитом
- }

РАК ЛЁГКОГО ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С {

- =хроническим неспецифическим заболеванием лёгких
 - ~язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
 - ~сахарным диабетом
 - ~бронхиальной астмой
- }

К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ {

=сухие хрипы на выдохе

~сухие хрипы на вдохе

~влажные хрипы

~крепитацию

}

ДЫХАНИЕ ЧЕЙН—СТОКСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=апноэ, сменяющимся гиперпноэ

~продолжительным вдохом и коротким выдохом

~коротким вдохом и продолжительным выдохом

~апноэ

}

ДЫХАНИЕ БИОТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=частым глубоким дыханием, чередующимся с дыхательными паузами

~плавно меняющейся амплитудой дыхательного объема

~коротким вдохом и продолжительным выдохом

~продолжительным вдохом и коротким выдохом

}

ПИКФЛОУМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ {

=пиковой скорости выдоха

~объема форсированного выдоха за 1 секунду

~жизненной емкости легких

~максимальной вентиляции легких

}

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА ЯВЛЯЕТСЯ {

=глаукома

~язва желудка

~хронический пиелонефрит

~катаракта

}

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=снижение частоты рецидивов язвенной болезни

~снижение секреции соляной кислоты

~уменьшение выраженности болевого синдрома

~уменьшение риска прободения язвы

}

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЦИРРОЗА,
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС STILD-PUGH НЕ ВКЛЮЧАЕТ
КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ {

- =количества тромбоцитов
 - ~наличия асцита
 - ~стадии печеночной энцефалопатии
 - ~протромбинового времени/индекс
- }

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕВОЗМОЖНО
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ИЗУЧАЕМЫХ ОРГАНОВ И СТРУКТУР {

- =микроструктуру (морфологическое строение)
 - ~макроструктуру
 - ~топографо-анатомические взаимоотношения
 - ~макроструктуру и топографо-анатомические взаимоотношения
- }

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ {

- =аденокарциномы пищевода
 - ~кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода
 - ~плоскоклеточного рака пищевода
 - ~лейкоплакии пищевода
- }

ДЛЯ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА НЕ ХАРАКТЕРНО {

- =преимущественное поражение антрального отдела желудка
 - ~наличие антител к париетальным клеткам желудка
 - ~наличие гипогастринемии
 - ~наличие ахлоргидрии
- }

ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ДЛЯ
НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНГИБИТОР
АНГИОТЕНЗИН- ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА {

- =Каптоприл
 - ~Периндоприл
 - ~Фозиноприл
 - ~Лизиноприл
- }

ДЛЯ СОСТОЯНИЯ ГИПОВОЛЕМИИ ХАРАКТЕРНО {

- =уменьшение объема циркулирующей крови
- ~улучшение реологических свойств крови

~повышение центрального венозного давления
~повышение ударного объема и сердечного выброса
}

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=возраст старше 65 лет
~бронхиальное дыхание
~кашель с гнойной мокротой
~субфебрильная лихорадка
}

ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ {

=сатурации кислорода
~сатурации углекислого газа
~пиковой скорости выдоха
~гемоглобина
}

ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ВО ВТОРОМ МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ И В ТОЧКЕ БОТКИНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КЛАПАНА {

=аорты
~митрального
~трёхстворчатого
~лёгочной артерии
}

К ПРИЧИНАМ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ ОТНОСЯТ {

=гиперпаратиреоз
~гиперфосфатемию
~жировую эмболию
~рабдомиолиз
}

ТРОЙНОЙ ПРИЕМ ПО САФАРУ ВКЛЮЧАЕТ {

=разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта
~поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову
~освобождение от стесняющей одежды области шеи
~прием Селика
}

К МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ОТНОСИТСЯ {

=динамическое наблюдение за меланомоопасными невусами

- ~хирургическое лечение всех выявленных невусов кожи
- ~проведение фотодинамического лечения меланомоопасных невусов
- ~ежегодное проведение термодифференциального теста в группе риска

}

К КАТЕГОРИИ СОБСТВЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ {

- =антракоз, вибрационную болезнь
- ~экзему, дерматит
- ~бронхиальную астму, ХОБЛ
- ~варикозное расширение вен нижних конечностей

}

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ С ДИФфуЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ (ПОСЛЕ ОТМЕНЫ МЕРКАЗОЛИЛА РАЗВИЛСЯ РЕЦИДИВ ДИФфуЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА) ВКЛЮЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ {

- =радиоактивным йодом или оперативное лечение
- ~тироксином
- ~бета-адреноблокаторами
- ~препаратами глюкокортикостероидов

}

\$CATEGORY: Раздел_ФТИЗИАТРИЯ

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЮТСЯ {

- =больные люди
- ~предметы окружающей среды
- ~больные животные
- ~кровососущие насекомые

}

РЕАКЦИИ НА ТУБЕРКУЛИН РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС) {

- =48-72
- ~6-12
- ~12-24
- ~24-48

}

ПРОБА МАНТУ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ РАЗМЕРАХ ПАПУЛЫ БОЛЕЕ (ММ) {

- =5
- ~1
- ~3

~12

}

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=аэрогенный

~внутриутробный

~алиментарный

~чрезкожный

}

РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОК ПРИ
НАЛИЧИИ КОНТАКТОВ {

=внутри семейных

~внутриквартирных

~производственных

~случайных

}

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПЛЕВРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ {

=клеток Пирогова - Лангханса

~эпителиоидных клеток

~лимфоцитов

~макрофагально-гистиоцитарных элементов

}

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА МОЖНО ВЫЯВИТЬ ПРИ
МИКРОСКОПИИ ОКРАШЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО {

=Цилю - Нельсену

~Романовскому - Гимзе

~Лейшману~Граму

}

К ПЕРВИЧНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ ЛЕГКИХ ОТНОСИТСЯ {

=туберкулёзная интоксикация у детей и подростков

~туберкулёма

~очаговая форма

~фиброзно-кавернозная форма

}

К ОСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ ТУБЕРКУЛЁЗУ ЛЁГКИХ
ОТНОСИТСЯ {

=милиарный

~очаговый

~туберкулёма
~кавернозный
}

ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ {
=флюорография
~бронхоскопия
~спирография
~сцинтиграфия
}

ДОСТОВЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ФИБРИНОЗНОГО ПЛЕВРИТА ЯВЛЯЕТСЯ {
=шум трения плевры
~наличие мелкопузырчатых влажных хрипов
~наличие рассеянных сухих хрипов
~отсутствие дыхания
}

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С {
=обзорной рентгенографии в прямой и боковой проекциях
~флюорографии в прямой и боковой проекциях
~рентгеноскопии в различных проекциях
~томографии легких в прямой и боковой проекциях
}

К ГРУППЕ НАСЕЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТНОСЯТСЯ {
=мужчины
~подростки
~женщины
~пожилые люди
}

НАИБОЛЬШУЮ РОЛЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧЕЛОВЕКА ИГРАЮТ {
=микобактерии человеческого типа
~микобактерии птичьего типа
~микобактерии бычьего типа
~атипичные микобактерии
}

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОТНОСЯТ {

=выявление больных туберкулезом среди населения

~диагностику туберкулеза у больных

~лечение и наблюдение больных туберкулезом

~проведение специфической профилактики туберкулеза

}

ОТЛИЧИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОТ ДРУГИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В {

=интерстициальном расположении очагов в легких

~преобладание казеозно-некротической тканевой реакции верхнедолевой локализации легочного процесса раннем формировании пневмосклероза в легких

}

МАССОВЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=флюорографическое обследование органов дыхания

~проведение туберкулинодиагностики по пробе Манту

~проведение рентгенографии органов грудной клетки

~исследование мокроты на микобактерии туберкулеза

}

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ОБНАРУЖЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД {

=культуральный

~бактериоскопический

~иммунно-генетический

~люминесцентной микроскопии

}

К МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ {

=сахарный диабет

~хронический тонзиллит

~тиреотоксикоз

~ревматоидный артрит

}

ОБНАРУЖЕНИЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ИНФИЛЬТРАТОМ В ЛЕГКОМ И НАЛИЧИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ В МОКРОТЕ СООТВЕТСТВУЕТ {

=несвоевременному выявлению туберкулеза

~своевременному выявлению туберкулеза
~раннему выявлению туберкулеза
~позднему выявлению туберкулеза
}

ГИПЕРЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л У
ВЗРОСЛЫХ СЧИТАЮТ РАЗМЕР ПАПУЛЫ ММ И БОЛЕЕ {
=21
~15
~12
~17
}

ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬНЫХ {
=язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки
~переболевших острым респираторным заболеванием
~рематOIDным артритом
~кишечной инфекцией
}

К ПОЗДНО ВЫЯВЛЕННОЙ ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ {
=фиброзно-кавернозный
~диссеминированный
~очаговый
~инфильтративный
}

ЭКССУДАТ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО {
=лимфоцитарным
~нейтрофильным
~эозинофильным
~хилезным
}

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С {
=рентгенографии органов грудной клетки
~томосинтеза органов грудной клетки
~флюорографии органов грудной клетки
~компьютерной томографии органов грудной клетки
}

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
ОБУСЛОВЛЕННЫ {

=гиперчувствительностью замедленного типа

~антителообразованием гиперчувствительностью немедленного типа
развитием толерантности
}

В СОСТАВЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ {

=эозинофилы

~лимфоциты

~гигантские клетки Пирогова-Лангханса

~эпителиоидные клетки
}

К ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМ АКТИВНОСТИ ОЧАГОВОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ {

=обнаружение микобактерий туберкулеза в мокроте

~получение положительной реакции по пробе Манту

~выявление кашля со скудной мокротой, слабости

~обнаружение атипичных микобактерий в мокроте
}

МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ АСПИРАЦИОННОЙ
КАТЕТЕРИЗАЦИОННОЙ БИОПСИИ, ПОДЛЕЖИТ ИССЛЕДОВАНИЮ {

=цитологическому и бактериологическому

~гистологическому и цитологическому

~цитологическому и биохимическому

~бактериологическому и биохимическому
}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ
БОЛЬНЫЕ С ЖАЛОБАМИ НА {

=кашель с мокротой, потливость, потерю массы тела

~слабость, одышку, тяжесть за грудиной, потливость

~потливость, одышку, головную боль, потерю массы тела

~учащенное сердцебиение, потливость, малый субфебрилитет
}

В ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ ПРЕОБЛАДАЮТ {

=лимфоциты

~нейтрофилы

~моноциты

~макрофаги
}

К ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ {

- =клеточный фактор иммунитета
 - ~гуморальный фактор иммунитета
 - ~клеточно-гуморальный фактор
 - ~неспецифический фактор защиты
- }

ЭКССУДАЦИЯ ЖИДКОСТИ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛЕВРОЙ {

- =висцеральной
 - ~диафрагмальной
 - ~медиастинальной
 - ~межреберной
- }

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ {

- =кровохарканье и легочное кровотечение
 - ~амилоидоз внутренних органов
 - ~инфекционно-токсический шок
 - ~хроническое легочное сердце
- }

ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИНАДЛЕЖИТ {

- =химиотерапии
 - ~диетотерапии
 - ~патогенетической терапии
 - ~хирургии
- }

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ХИМИОТЕРАПИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ {

- =степенью выраженности побочного свойства
 - ~патогенезом выявляемых побочных реакций
 - ~правильной идентификацией химиопрепарата, вызвавшего побочный эффект
 - ~своевременным проведением корректирующих мероприятий
- }

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ К {

- =Изониазиду и Рифампицину

~Рифампицину и Этионамиду
~Рифампицину и Канамицину
~Изониазиду и Пиразинамиду
}

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЮТСЯ {

=боли в груди, усиливающиеся при вдохе, с иррадиацией в шею, иногда в эпигастральную или поясничную область и одышка
~боли в груди колющего характера, затрудненное дыхание, кашель с мокротой и температура
~лихорадка, сухой надсадный кашель, боли в груди с иррадиацией в поясничную область
~лихорадка, кашель с мокротой, боли в груди и одышка непосредственно связанная с размером пневмоторакса
}

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ПРИМЕНЯЮТ {

=дренирование плевральной полости по Бюлау во II-III межреберье
~наложение искусственного пневмоторакса во II-III межреберье
~наложение давящей повязки на грудную клетку во II-III межреберье
~медикаментозное лечение химиопрепаратами резервного ряда
}

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧАЩЕ ОБНАРУЖИВАЮТ В {

=бронхоальвеолярной лаважной жидкости
~биоптате внутригрудных лимфатических узлов
~промывных водах желудка, мокроте
~мокроте, моче, промывных водах желудка
}

ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ РИФАМПИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ {

=нарушение функции печени
~сахарный диабет II типа
~язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки
~врожденная катаракта
}

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТУБЕРКУЛИН У БОЛЬНЫХ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ {

=проявлением вторичного иммунодефицита
~признаком хорошей переносимости препаратов
~хорошим прогностическим признаком

~плохим прогностическим признаком
}

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НА ТУБЕРКУЛЕЗ 1
РАЗ В ГОД ПРОХОДЯТ {

=больные, страдающие сахарным диабетом

~ВИЧ- инфицированные лица, состоящие на учете

~лица из бытового или профессионального контакта с туберкулезом

~военнослужащие, призываемые на военную службу
}

ПРОБУ МАНТУ С 2 ТЕ СЧИТАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ
МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПАПУЛЫ (ММ) {

=5

~4

~6

~7
}

ПРОБУ МАНТУ С 2 ТЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СЧИТАЮТ
ГИПЕРЕРГИЧЕСКОЙ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПАПУЛЫ (ММ) {

=17

~12

~15

~21
}

БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ
ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=культуральный

~иммунологический

~прямая бактериоскопия

~люминесцентная микроскопия
}

К МЕТОДАМ ВЕРИФИКАЦИИ ТУБЕРКУЛЁЗА ОТНОСЯТ {

=бактериологический и цито-гистологический

~биохимический и иммунологический

~рентгенологический и радиоизотопный

~пробное лечение и динамическое наблюдение
}

В ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ БОЛЬНОГО
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ПРЕОБЛАДАЮТ {

=лимфоциты

~нейтрофилы
~альвеолоциты
~эозинофилы
}

ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ ВНУТРИКОЖНОЙ ПРОБЫ С ПРЕПАРАТОМ
ДИАСКИНТЕСТ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАЮТ ЧЕРЕЗ (ЧАС) {
=72
~6
~12
~24
}

КЛИНИЧЕСКИ МАЛОСИМПТОМНО, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВЫЯВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОТЕКАЕТ ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ {
=очаговый
~инфильтративный
~фиброзно-кавернозный
~цирротический
}

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЕЖЕГОДНОЙ МАССОВОЙ
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=выявление первичного инфицирования
~выявление вторичного инфицирования
~отбор контингента для вакцинации БЦЖ
~отбор контингента для ревакцинации БЦЖ
}

ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ {
=рентгенография
~бронхография
~ангиография
~рентгеноскопия
}

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ БОЛЬНОГО
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПРИ АСПИРАЦИОННОЙ
КАТЕТЕРИЗАЦИОННОЙ БИОПСИИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЮ {
=цитологическому и бактериологическому
~цитологическому и биохимическому
~биохимическому и морфологическому

~бактериологическому и биохимическому
}

МАССОВУЮ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКУ СРЕДИ ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ
ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В {

=год
~полгода
~2 года
~3 года
}

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ БОЛЬНОГО
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПРИ БРАШ-БИОПСИИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЮ {

=цитологическому и гистологическому
~цитологическому и биохимическому
~биохимическому и морфологическому
~бактериологическому и биохимическому
}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ МАССОВОМ
ОБСЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=флюорография
~туберкулинодиагностика
~рентгеноскопия
~иммунодиагностика
}

ТРАНСБРОНХИАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ
НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНА ПРИ {

=саркоидозе
~гамартохондроме
~эхинококкозе
~периферическом раке лёгкого
}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЗЫ РАСПАДА ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ {

=компьютерная томография
~бронхоскопия
~сцинтиграфия
~магнитно-резонансная томография
}

ПРОБУ МАНТУ ОЦЕНИВАЮТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 2 ТЕ СПУСТЯ (ЧАС)

{
=72
~6
~12
~24
}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=воздушно-капельный
~алиментарный
~контактный
~внутриутробный
}

ВИД ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

{
=культурального исследования
~микроскопии
~цитологического исследования
~гистологии
}

БОЛЬНОМУ С ОКРУГЛЫМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ЛЁГКОМ НЕУТОЧНЁННОЙ ЭТИОЛОГИИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ {

=биопсию лёгкого
~гормональную терапию
~динамическое наблюдение
~противотуберкулезную терапию
}

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К {

=ультрафиолетовому солнечному излучению
~инфракрасному солнечному излучению
~постоянному и переменному магнитному полю
~радиоактивному излучению
}

ПЕРВИЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СЧИТАЮТ {

=заболевание ранее неинфицированного человека
~заболевание человека с положительной пробой Манту
~заболевание человека, имеющего контакт с больными туберкулезом
~впервые выявленные туберкулезные изменения в лёгких
}

ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ВНУТРИКОЖНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ С ПРЕПАРАТОМ ДИАСКИНТЕСТ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕХНИКИ ПОСТАНОВКИ {

=реакции Манту

~пробы Коха

~реакции Пирке

~пробы Гринчара - Карпиловского

}

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКЕ ОБЩЕПРИНЯТЫМ МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ {

=внутрикожный

~подкожный

~внутривенный

~внутримышечный

}

В КЛИНИЧЕСКОМ ДИАГНОЗЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПРОЦЕССА В ЛЁГКИХ ПРИНЯТО ПО {

=долям и сегментам

~лёгочным полям

~рёбрам

~межреберьям

}

К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСИТСЯ {

=вакцинация БЦЖ

~улучшение экологии

~применение дезсредств

~витаминотерапия

}

НА РЕНТГЕНОГРАММЕ РАСШИРЕНА ТЕНЬ КОРНЯ ЛЁГКОГО, НАРУШЕНА ЕГО ФОРМА И СТРУКТУРА ПРИ {

=туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов

~туберкулёзной интоксикации

~диссеминированном туберкулёзе

~конгломератной туберкулезе

}

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБО ВЫСОКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ {

=мягкой мозговой оболочки

~почек
~печени
~селезёнки
}

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ
НАРЯДУ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВЕН МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ {

=хирургический
~бальнеологический
~физиотерапевтический
~патогенетический
}

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПЕРВИЧНОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ {

=туберкулез, развившийся вследствие первичного инфицирования
~впервые выявленный случай активного туберкулеза
~туберкулез легких у больного, ранее не получавшего химиопрепараты или
принимавший химиопрепараты менее 1 месяца
~туберкулез, выявленный у лица с отрицательной пробой Манту
}

НАРАСТАНИЕ ОДЫШКИ, БОЛИ В ГРУДИ, ОДНОСТОРОННЕГО
ТИМПАНИТА ИЛИ КОРОБОЧНОГО ЗВУКА ПРИ ПЕРКУССИИ,
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ
ХАРАКТЕРИЗУЮТ {

=клапанный пневмоторакс
~закрытый пневмоторакс
~открытый пневмоторакс
~пневмоперитонеум
}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВТОРИЧНОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА В НАШЕЙ СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=флюорография
~иммунодиагностика
~ПЦР-диагностика
~микроскопия мазка по Цилю - Нильсену
}

ГЛАВНЫМ ОТЛИЧИЕМ ДИАСКИН-ТЕСТА ОТ ПРОБЫ МАНТУ
ЯВЛЯЕТСЯ {

=кожная реакция только при инфицировании вирулентными микобактериями
туберкулеза

~кожная реакция только при инфицировании авирулентными
микобактериями туберкулеза
~более низкая частота побочных реакций
~более простая методика проведения
}

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА К {

=Изониазиду и Рифампицину

~двум и более химиопрепаратам

~препаратам первого ряда

~Изониазиду, Рифампицину и фторхинолонам

}

ШИРОКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА К {

=Изониазиду, Рифампицину, фторхинолонам и аминогликозидам

~как минимум Изониазиду и Рифампицину

~двум и более химиопрепаратам

~препаратам первого ряда

}

К АНТИБИОТИКАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ,
КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННОЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И ОТНОСЯТСЯ К
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ, ОТНОСЯТ {

=фторхинолоны

~макролиды

~аминопенициллины

~цефалоспорины

}

ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ЛЕЧЕНИИ СПОНТАННОГО
ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЮТСЯ {

=плевральная пункция, активный дренаж и аспирация

~наблюдение и лечение основного заболевания

~кардиотропная терапия и аналептики

~наложение пневмоперитонеума и наблюдение

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЧЕЛОВЕКА
ЯВЛЯЕТСЯ {

=*M. tuberculosis humanus*

~*M. tuberculosis bovis*

~*M. tuberculosis africanum*

~М. kansasii
}

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ {

=все диагностические и лечебно-профилактические учреждения общей лечебной сети

~противотуберкулезные учреждения

~родильные дома

~учреждения Роспотребнадзора

}

ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ {

=аэрогенным

~алиментарным

~контактным

~внутриутробным

}

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЗАРАЖЕНИИ МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ФАГОЦИТОЗ НОСИТ ХАРАКТЕР {

=незавершенный

~завершенный

~индуцированный

~физический

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {

=лучевой (флюорография)

~микроскопия мокроты на микобактерии туберкулеза

~посев мокроты на микобактерии туберкулеза

~клинический анализ крови

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ {

=микроскопия мокроты по методу Циля - Нельсена

~клинический анализ крови и мочи

~объективное исследование больного

~рентгенография органов грудной клетки

}

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОБУСЛОВЛЕН {

=развитием повышенной чувствительности замедленного типа

~развитием повышенной чувствительности немедленного типа

~образованием иммунных комплексов

~развитием иммунологической толерантности

}

К ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ ГИДРАЗИДА ИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ГИНК) ОТНОСИТСЯ {

=Изониазид

~Пиразинамид

~Протионамид

~Этамбутол

}

НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА {

=лекарственно устойчивые к сочетанию основных и резервных противотуберкулезных препаратов

~чувствительные ко всем противотуберкулезным препаратам

~монорезистентные

~полирезистентные

}

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА СОСТАВЛЯЕТ (МЕС.) {

=3-6

~6-9

~1-2

~2-3

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=химиотерапия

~диетотерапия

~хирургический

~патогенетическая терапия

}

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ {

=туберкулёзом любой локализации с обострениями и рецидивами
~внелёгочным туберкулёзом
~с рецидивами
~туберкулёзом лёгких
}

НАЛИЧИЕ ОЧАГА ГОНА СООТВЕТСТВУЕТ ФАЗЕ {
=обызвествления первичного туберкулезного комплекса
~обсеменения туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
~обсеменения первичного туберкулезного комплекса
~инфильтрации очагового туберкулеза
}

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПРИ ПРОБЕ МАНТУ СОСТАВЛЯЕТ {
=2 ТЕ в 0,1 мл
~2 ТЕ в 1 мл
~5 ТЕ в 1 мл
~1 ТЕ в 0,1 мл
}

БАКТЕРИОВЫДЕЛИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ {
=у которого микобактерии туберкулеза были обнаружены хотя бы один раз любым методом
~выделявший микобактерии туберкулеза не менее 2 раз
~выделявший микобактерии туберкулеза многократно
~выделявший микобактерии периодически
}

ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИКВОРА ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С МЕНИНГИТОМ {
=серозно-вирусным
~пневмококковым
~нейротоксическим
~менингококковым
}

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЁЗНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ {
=фокуса в лёгком, связанного «дорожкой» с увеличенным корнем лёгкого
~ослабления лёгочного рисунка
~линзообразной очерченной тени
~бесструктурного корня, усиленного легочного рисунка
}

\$CATEGORY: Раздел_ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

НАЛИЧИЕ У БОЛЬНОГО СГРУППИРОВАННЫХ ПУЗЫРЬКОВ НА ЭРИТЕМАТОЗНОМ ФОНЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ХОДУ МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕРВОВ, И СИЛЬНЫХ БОЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЛИШАЕ {

=опоясывающем

~простом пузырьковом

~чешуйчатом

~разноцветном

}

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ {

=половым

~природно-очаговым

~воздушно-капельным

~трансмиссивным

}

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ПРОВОДИТСЯ {

=противовирусными мазями и кремами

~топическими кортикостероидами

~фунгицидными препаратами

~мазями с антибиотиками

}

ПРИ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕ ВОЗНИКАЕТ {

=Волдырь

~пузырек

~пятно

~пузырь

}

РАЗВИТИЕ КАНДИДОЗА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРИЁМОМ БОЛЬШИХ ДОЗ {

=кортикостероидов

~антигистаминных препаратов

~противомаларийных препаратов

~десенсибилизирующих препаратов

}

В КОЖЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ СИНТЕЗИРУЕТСЯ ВИТАМИН {

=D

~А
~С
~В2
}

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ
ДЛЯ ГЕРПЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ {
=пузырёк
~узел
~узелок
~волдырь
}

В ЛЕЧЕНИИ КРАПИВНИЦЫ ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ {
=антигистаминных препаратов
~противовирусных средств
~антибиотиков
~антимикотиков
}

ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ЯЗЫК СТАНОВИТСЯ {
=«фулигинозным»
~«географическим»
~«меловым»
~«малиновым»
}

МАРКЕРОМ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В
ЯВЛЯЕТСЯ {
=HBsAg
~anti-HBs IgG
~anti-HBcor IgG
~anti-HBe IgG
}

КАЛ ПРИ ХОЛЕРЕ ИМЕЕТ ВИД {
=«рисового отвара»
~«малинового желе»
~«болотной тины»
~«ректального плевка»
}

СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ КАРБУНКУЛ ИМЕЕТ ВИД {
=черного струпа, окруженного венчиком гиперемии, без болевой
чувствительности

- ~коричневого налета со звездчатыми краями и резкой болезненностью
- ~желто-коричневой корочки с умеренной болезненностью
- ~везикулы на участке гиперемии кожи с выраженной болезненностью

}

ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИМЕНЯЮТ {

- =Ацикловир
- ~Азитромицин
- ~Осельтамивир
- ~Ремантадин

}

ПОД ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОНИМАЮТ {

- =возникновение и распространение инфекционных болезней среди населения
- ~взаимодействие возбудителя и восприимчивого организма, проявляющееся болезнью или носительством возбудителя инфекции
- ~повышение уровня заболеваемости на ограниченной территории
- ~взаимодействие популяций паразитов и людей, объединенных общей территорией, бытовыми, природными и другими условиями и существования

}

В ДИНАМИКЕ ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

- =большинства инфекционных болезней
- ~всех неинфекционных болезней
- ~всех болезней, независимо от их происхождения
- ~всех инфекционных болезней

}

ТЕРМИН «СПОРАДИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ» ОЗНАЧАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ {

- =единичные
- ~групповые
- ~массовые
- ~характерные для данной местности

}

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ЗАВИСИТ ОТ {

- =локализации возбудителя
- ~вида возбудителя
- ~формы заболевания
- ~особенностей организма

}

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВСПЫШКА, ЭПИДЕМИЯ, ПАНДЕМИЯ ПО {

=количеству выявленных случаев

~тяжести течения болезни

~числу выявленных носителей

~скорости распространения инфекции

}

К ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ОТНОСЯТ {

=изоляцию больных

~соблюдение личной гигиены

~текущую дезинфекцию

~иммунопрофилактику

}

К ГРУППЕ РИСКА ОТНОСЯТ {

=факторы, способствующие развитию заболеваний

~мешающие факторы (конфаундеры, искажающие результаты исследований)

~систематические ошибки в исследованиях

~случайные ошибки в исследованиях

}

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, НАЗЫВАЮТ {

=иммунопрофилактику контактных

~дератизацию

~дезинфекцию

~изоляцию больных

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРАПИЯ {

=регидратационная

~дезинтоксикационная

~дегидратационная

~антибактериальная

}

ПРИ ВНЕКИШЕЧНОМ АМЁБИАЗЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЮТСЯ АБСЦЕССЫ {

=печени

~мозга

~лёгких

~почек

}

ОБРАЗОВАНИЕ АБСЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

=амёбиаза

~вирусного гепатита

~лептоспироза

~иерсиниоза

}

ПРИ МАЛЯРИИ ИЗ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ {

=эритроциты

~тромбоциты

~эозинофилы

~нейтрофилы

}

ПРИ ГРИППЕ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ {

=геморрагического отёка легких

~истинного крупа

~ателектазов лёгких

~острой печёночной недостаточности

}

ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ {

=трахеита

~фарингита

~ларингита

~бронхита

}

КЛИНИКА ЛАРИНГИТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ {

=парагриппа

~аденовирусной инфекции

~гриппа

~риновиральной инфекции

}

БРОНХИ, БРОНХИОЛЫ И ЛЕГКИЕ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ {

=респираторно-синцитиальной инфекции

~парагриппе

~аденовирусной инфекции

~риновиральной инфекции

}

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ {

- =гриппе
- ~аденовирусной инфекции
- ~парагриппе
- ~РС-вирусной инфекции
- }

К ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ МИНДАЛИН ПРИ ДИФТЕРИИ ОТНОСЯТ {

- =налеты серого цвета, трудно удаляемые шпателем
- ~налеты белого цвета, легко удаляемые шпателем
- ~гнойные фолликулы
- ~глубокий некроз тканей
- }

НАЛИЧИЕ МОНОНУКЛЕАРОВ В ГЕМОГРАММЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ {

- =инфекционного мононуклеоза
- ~ангины Симановского-Венсана
- ~дифтерии
- ~острого лейкоза
- }

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА «ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ» С НАЛЁТОМ НА МИНДАЛИНАХ ОБЯЗАН НАЗНАЧИТЬ {

- =мазок из миндалин на дифтерию
- ~анализ крови на вирус иммунодефицита человека
- ~анализ крови на реакцию Вассермана
- ~анализ крови на реакцию Видаля
- }

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ДИФТЕРИИ ОТНОСИТСЯ {

- =миокардит
- ~эндокардит
- ~пиелонефрит
- ~цистит
- }

У ПАЦИЕНТА С ЛИХОРАДКОЙ, ГИПЕРЕМИЕЙ РОТОГЛОТКИ, ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ, СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ, ЛИМФОЦИТОЗОМ И АТИПИЧНЫМИ МОНОНУКЛЕАРАМИ СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ {

- =инфекционный мононуклеоз
- ~грипп
- ~парагрипп
- ~дифтерию

}

ПРИ НАЛИЧИИ ОСТРОЙ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ СЛЕДУЕТ
ИСКЛЮЧИТЬ {

=дифтерию

~грипп

~парагрипп

~паратонзиллярный абсцесс

}

ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

=пневмония

~пневмоторакс

~панкреатит

~пиелонефрит

}

К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ОТНОСИТСЯ {

=сочетание ринофарингита и конъюнктивита с лимфаденопатией

~ангина

~стоматит

~отит

}

ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО, ОЗНОБ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ВОЗБУЖДЕНИЕ,
РИГИДНОСТЬ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ, СУДОРОГИ, ЛЕЙКОЦИТОЗ
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=менингита

~гриппа

~парагриппа

~острого гломерулонефрита

}

ТИПИЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ФАРИНГИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ {

=вирусы

~стафилококки

~гемофильная палочка

~клебсиелла

}

СРЕДИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА
ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=Бетта-гемолитический стрептококк группы А

~стафилококк

~пневмококк
~синегнойная палочка
}

К АТИПИЧНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ {
=микоплазму
~риновирусы
~аденовирусы
~коронавирусы
}

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРУЦЕЛЛЁЗЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ {
=опорно-двигательный аппарат
~система органов дыхания
~пищеварительная система
~эндокринная система
}

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЛЁЗА ПРИМЕНЯЮТ {
=реакции Райта и Хеддльсона
~иммунный блоттинг
~реакцию Вассермана
~микроскопию мазка и толстой капли крови
}

ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ {
=нейтрофильный плеоцитоз
~ксантохромия
~высокий уровень глюкозы
~опалесценция
}

К ХАРАКТЕРНОМУ СИМПТОМУ БРЮШНОГО ТИФА ОТНОСИТСЯ {
=розеолёзная сыпь
~ларинготрахеит
~зуд кожи
~одышка
}

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ ВЫЗЫВАЕТСЯ {
=герпесвирусом
~энтеровирусом
~пикорнавирусом
~ортомиксовирусом

}

К ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМАМ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРИОДА КОРИ ОТНОСЯТ {

=пятна Филатова-Коплика

~выраженные катаральные симптомы

~одутловатость и гиперемию лица~энантему на твёрдом нёбе

}

СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ В СОЧЕТАНИИ С ДВУХСТОРОННЕЙ ПРИПУХЛОСТЬЮ В ОКОЛОУШНЫХ ОБЛАСТЯХ УКАЗЫВАЕТ НА {

=паротитную инфекцию

~туберкулёз

~лептоспироз

~инфекционный мононуклеоз

}

К ХАРАКТЕРНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ СКАРЛАТИНЫ ОТНОСЯТ {

=гломерулонефрит

~стоматит

~круп

~менингит

}

ОСНОВОЙ ЛЕЧЕНИЯ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=антибактериальная терапия

~вакциноterapia

~десенсибилизирующая терапия

~дезинтоксикационная терапия

}

ПРИ ГЕПАТИТЕ А В КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ {

=anti- HAV IgM

~anti-HBcor IgM

~anti-HEV IgM

~anti-HCV

}

«СОСУДИСТЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ», «ПАЛЬМАРНАЯ ЭРИТЕМА» ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ {

=хронического гепатита

~острой печёночной энцефалопатии

~синдрома холестаза

~синдрома Жильбера

}

СКАРЛАТИНОПОДОБНАЯ СЫПЬ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ {

=псевдотуберкулёзе

~брюшном тифе

~краснухе

~менингококцемии

}

ДИАГНОЗ «МАЛЯРИЯ» ПОДТВЕРЖДАЕТ {

=исследование толстой капли крови и мазка крови на наличие паразита

~исследование ликвора

~бактериологическое исследование крови

~РСК, РНГА, РТГА

}

ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ВЫЯВЛЯЮТСЯ {

=лейкопения, лимфоцитоз, нормальная или замедленная СОЭ

~лейкопения, лимфоцитоз, увеличенная СОЭ лейкоцитоз, нейтрофилез,
увеличенная СОЭ

~лейкоцитоз, лимфоцитоз, нормальная или замедленная СОЭ

}

ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ИНФИЦИРОВАННЫЕ {

=животные, птицы, человек

~предметы

~грызуны, насекомые

~крысы, гуси, свиньи

}

ЗАРАЗНЫЙ ПЕРИОД ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ДЛИТСЯ С КОНЦА
ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДО {

=пятого дня с момента появления последних элементов сыпи

~исчезновения корочек

~момента появления последних элементов сыпи

~третьего дня с момента появления сыпи

}

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТ {

=вне зависимости от наличия случаев инфекционных болезней

~при единичных случаях инфекционных заболеваний

~при множественных случаях инфекционных заболеваний

~в зависимости от эпидемической ситуации в регионе

}

БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ {

=дезинсекцией

~дератизацией

~дезинфекцией

~дезактивацией

}

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ БРЮШНОГО ТИФА БЫВАЕТ {

=фекально-оральный

~контактный

~водный

~вертикальный

}

МАССОВЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А МОГУТ
ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ {

=воду

~кровь

~воздух

~предметы быта

}

НЕОТЛОЖНОЙ МЕРОЙ ПРИ ОЖОГЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ
КИСЛОТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=смыв водой и нейтрализация щелочью

~обработка спиртовыми растворами

~наложение масляной повязки

~наложение сухой окклюзионной повязки

}

«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТ ВРАЧ {

=заподозривший инфекционное заболевание

~подтвердивший диагноз инфекционного заболевания

~эпидемиолог

~дезинфектор

}

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВОЗМОЖЕН ПРИ {

=ВИЧ-инфекции

~шигеллезе

~вирусном гепатите А

~коклюше

}

«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ БОЛЬНОМ
НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ {

=подозрения на инфекционное заболевание

~консультации с врачом-инфекционистом

~лабораторного подтверждения диагноза

~выписки из стационара

}

ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА {

=А

~В

~С

~D

}

ДОСТОВЕРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ А ЯВЛЯЕТСЯ {

=наличие антител вирусного гепатита А IgM

~наличие антител вирусного гепатита А IgG

~повышение уровня билирубина

~повышение уровня трансаминаз

}

ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫМ СУБСТРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=кровь

~моча

~пот

~слюна

}

К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ
ОТНОСЯТ {

=лихорадку больше месяца

~катаральные явления

~увеличение одного лимфатического узла

~неспецифический язвенный колит

}

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЙ БОЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ИНФЕКЦИИ {

=весь период болезни

~в инкубационном периоде

~в острой стадии
~на стадии вторичных заболеваний
}

К ИСТОЧНИКАМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ ОТНОСЯТ {
=больного человека в первые пять дней болезни
~вирусоносителя
~домашних животных
~птиц
}

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК ПРИ ПЛАНОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ УЧАСТВУЕТ {
=врач-терапевт (врач-педиатр)
~врач-лаборант
~врач-эпидемиолог
~врач-бактериолог
}

ПРИ УГРОЗЕ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ {
=проводят вакцинацию
~проводят бактериофагирование
~вводят иммуноглобулин
~вводят сыворотку
}

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ {
=вакцину АКДС
~живую противодифтерийную вакцину
~дифтерийную сыворотку
~дифтерийный бактериофаг
}

ЭКСТРЕННУЮ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА
ПРОВОДЯТ {
=столбнячным анатоксином
~столбнячной вакциной
~антибиотиками
~бактериофагом
}

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ БОТУЛИЗМЕ ОТНОСЯТ {
=офтальмоплегию
~гиперрефлексию

~патологические рефлексы
~судорожный синдром
}

СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ КАРБУНКУЛ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {
=выраженной отёчностью тканей и безболезненностью
~выраженной отёчностью тканей и резкой болезненностью
~отсутствием отёка тканей и резкой болезненностью
~отёком тканей и зудом
}

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=коринобактерия
~стафилококк
~листерия
~стрептококк
}

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО СТРАДАЕТ ОТ ДИФТЕРИЙНОГО ЭКЗОТОКСИНА СИСТЕМА {
=сердечно-сосудистая
~органов пищеварения
~органов дыхания
~органов мочевыделения
}

ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ {
=бактериологическое
~серологическое
~бактериоскопическое
~аллергологическое
}

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСЫПАНИЙ НА КОЖЕ ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ {
=геморрагическая сыпь звёздчатой формы
~розеолёзно-папулёзные высыпания
~элементы в виде пузырей с геморрагическим содержимым
~элементы, сходные с узловатой эритемой
}

ИЗМЕНЕНИЕМ В ЛИКВОРЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА, ЯВЛЯЕТСЯ {
=нейтрофилёз (до 80-90%)

- ~большое количество эритроцитов
- ~лимфоцитоз (до 80%)
- ~примерно одинаковое количество нейтрофилов и лимфоцитов

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =острая пневмония
- ~отит
- ~острый пиелонефрит
- ~острый серозный менингит

}

ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЁЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =эпи-мезогастральная область
- ~левая подвздошная область
- ~правое подреберье
- ~левое подреберье

}

К СИМПТОМАМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ, ОТНОСЯТ {

- =гепатоспленомегалию
- ~разлитые боли в животе
- ~выраженное обезвоживание
- ~жидкий стул более 10 раз в сутки

}

ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЁЗЕ ХАРАКТЕРЕН СТУЛ {

- =обильный, водянистый, пенистый, зеленоватого цвета
- ~обильный, водянистый, типа «рисового отвара» с хлопьями слизи
- ~жидкий, скудный, со слизью и прожилками крови
- ~кашицеобразный, глинистый, светлого цвета (обесцвеченный).

}

ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ И ПАРАТИФАМИ ПРИМЕНЯЕТСЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ {

- =крови
- ~ликвора
- ~мочи
- ~кала

}

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ
РИККЕТСИЯ {

=Провачека

~Музера

~Акари

~Бернета

}

ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ {

=обнаружением антител к вирусу гепатита А класса **Ig M**

~повышением активности АЛТ

~повышением уровня билирубина сыворотки крови

~обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig G

}

ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ 3 СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА
СОСТАВЛЯЕТ (%) {

=7-9

~4-6

~1-3

~свыше 10

}

ОСЛОЖНЕНИЕМ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ {

=гиповолемический шок

~перфорация язвы кишечника

~кишечное кровотечение

~мезаденит

}

К СОЧЕТАНИЮ СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ХОЛЕРЫ,
ОТНОСЯТ {

=обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе,
отсутствие тошноты~тошноту, рвоту

~жидкий, зелёный стул, боли вокруг пупка

~водянистый зловонный стул

}

ЧУМНОЙ БУБОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

=резкой болезненностью, спаянностью с окружающими тканями

~четкостью контуров

~отсутствием изменений кожи над лимфатическими узлами

~отсутствием склонности к нагноению

}

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КОЖНО-БУБОННОЙ ЧУМЫ ОТНОСЯТ {

=резкую болезненность первичного аффекта, наличие регионарного бубона

~полиаденопатию

~безболезненную язву

~быстрое рубцевание язвы

}

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БУБОНА ПРИ ТУЛЯРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

{

=незначительная болезненность и чёткие контуры

~спаянность с окружающими тканями

~нагноение лимфоузлов в ранние сроки

~синюшность и блеск кожи над бубоном

}

ПРИ БОТУЛИЗМЕ ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ {

=паралитический

~интоксикационный

~дегидратационный

~болевым

}

ОСНОВНЫМ В ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=противодифтерийная сыворотка

~антибиотики

~плазмоферез

~глюкокортикоиды

}

ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ АМЕБОЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ (ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВСЕХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ АМЕБИАЗА И НОСИТЕЛЬСТВА), ЯВЛЯЕТСЯ {

=Метронидазол

~Левомецитин

~Тетрациклин

~Фуразолидон

}

К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ БОТУЛИЗМА ОТНОСЯТ {

=сыворотку

~антибиотики

~спазмолитики

~анальгетики

}

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ
НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ {

=3 месяцев

~7 лет

~16 лет

~1 месяца

}

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИОБРЕТЁННЫЙ
ВИД ИММУНИТЕТА {

=искусственный активный

~естественный активный

~естественный пассивный

~искусственный пассивный

}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТА ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ {

=экстренное извещение об инфекционном заболевании

~статистический талон для регистрации заключительных диагнозов

~журнал учёта инфекционных заболеваний

~листок ежедневного учёта работы врача

}

\$CATEGORY: Раздел_АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

К «ЗОЛОТОМУ СТАНДАРТУ» ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ НА
РАННИХ СРОКАХ ОТНОСЯТ {

=ультразвуковое исследование

~осмотр шейки матки в зеркалах

~бимануальное исследование

~влагалищное исследование

}

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ЖИВОТА ОТНОСЯТ К
ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=сомнительным объективным

~сомнительным субъективным

~вероятным

~достоверным

}

ПИГМЕНТАЦИЮ БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА ОТНОСЯТ К ПРИЗНАКАМ
БЕРЕМЕННОСТИ {

=сомнительным объективным
~сомнительным субъективным
~вероятным
~достоверным
}

ПИГМЕНТАЦИЮ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОТНОСЯТ К
ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=сомнительным объективным
~сомнительным субъективным
~вероятным
~достоверным
}

ПИГМЕНТАЦИЮ СОСКОВ И ОКОЛОСОСКОВЫХ АРЕОЛ ОТНОСЯТ
К ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=сомнительным объективным
~сомнительным субъективным
~вероятным
~достоверным
}

ЗАДЕРЖКА МЕНСТРУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ОЩУЩЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ ОТНОСЯТ К ПРИЗНАКАМ
БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным

~сомнительным объективным
}

ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ИЗ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НА СОСКЕ
МОЛОЧНЫХ ХОДОВ ПРИ НАДАВЛИВАНИИ НА МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
ОТНОСЯТ К ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ЦИАНОЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ МАТКИ
ОТНОСЯТ К ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ (УВЕЛИЧЕНИЕ) МАТКИ ОТНОСЯТ К
ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ МАТКИ ОТНОСЯТ К
ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ (ХГТ В
КРОВИ И МОЧЕ) ОТНОСЯТ К ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным
~достоверным
~сомнительным субъективным
~сомнительным объективным
}

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА В-СУБЪЕДИНИЦУ ХГТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=вероятным

~достоверным

~сомнительным субъективным

~сомнительным объективным

}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПЛОДА ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА ЖЕНЩИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=достоверным

~вероятным

=сомнительным субъективным

~сомнительным объективным

}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕВЕЛЕНИЙ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ ПАЛЬПАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ {

=достоверным

~вероятным

~сомнительным субъективным

~сомнительным объективным

}

К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСИТСЯ {

=регистрация сердцебиения плода

~изменение обоняния

~цианоз слизистой влагалища, шейки матки

~повышение уровня ХГЧ

}

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ В НЕДЕЛЬ {

=30

~32

~28

~26

}

ТВОРОЖИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ {

=кандидоза

~хламидиоза

~гонореи

~трихомониаза

}

ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =выявление врожденных пороков развития плода
 - ~определение пола плода
 - ~выявление предлежания плода
 - ~определение положения плода
- }

ЭКГ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ВЫПОЛНЯЮТ В _ТРИМЕСТРЕ {

- =I, II, III
 - ~I
 - ~II
 - ~III
- }

СКРИНИНГ-МЕТОДОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =цитологическое исследование мазков
 - ~визуальный осмотр
 - ~кольпоскопия
 - ~бактериологическое исследование мазков
- }

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ {

- =препараты железа
 - ~поливитамины
 - ~Магния сульфат
 - ~Прогестерон
- }

ПЕРВОЕ СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ (НЕДЕЛЯ) {

- =11-14
 - ~10-11
 - ~7-8
 - ~7-10
- }

ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

- =полным раскрытием маточного зева и рождением ребенка
- ~раскрытием маточного зева до 6 см
- ~рождением последа

~началом регулярной родовой деятельности
}

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {
=отделением плаценты и рождением последа
~рождением плода
~раскрытием маточного зева
~регулярной родовой деятельностью
}

КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В (ММ РТ.СТ.) {
=140/90
~130/80
~120/80
~135/85
}

АНТИРЕЗУСНЫЕ АНТИТЕЛА У ПЛОДА РАЗРУШАЮТ {
=эритроциты
~лимфоциты
~тромбоциты
~лейкоциты
}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПОПАДАЕТ К ПЛОДУ ПУТЕМ {
=трансплацентарным
~восходящим
~аспирационным
~лимфогенным
}

ПЕРИОДОМ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА СЧИТАЕТСЯ {
=возраст от 40-45 лет до наступления менопаузы
~стойкое прекращение менструации в течение 12 месяцев
~возраст от 45 лет и последующие 5 лет менопаузы
~время после наступления менопаузы
}

СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЭНДОМЕТРИОЗ ЯВЛЯЕТСЯ {
=ультразвуковая диагностика
~магнитно-резонансная томография

- ~колоноскопия
- ~определение уровня онкомаркеров

}

ПРИЧИНОЙ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =вирус папилломы человека
- ~вирус Эпштейна-Барра
- ~стафилококк
- ~хламидия трахоматис

}

ОСНОВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =цитологическое исследование мазков по Папаниколау
- ~бимануальное исследование
- ~кольпоскопия
- ~ультразвуковое исследование органов малого таза

}

К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТ {

- =пальпацию частей плода
- ~отсутствие менструации
- ~увеличение размеров матки
- ~тошноту, рвоту

}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ {

- =нарушение менструальной функции
- ~боль внизу живота
- ~нарушение функции соседних органов
- ~нарушение детородной функции

}

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛОДА СЧИТАЕТСЯ {

- =продольное
- ~косое
- ~поперечное с головкой плода, обращенной влево
- ~поперечное с головкой плода, обращенной вправо

}

НАЧАЛО РОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ {

- =появлением регулярных схваток
- ~отхождением околоплодных вод
- ~отхождением слизистой пробки

~появлением схваток Брекстона-Гикса
}

КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ {

=приливы жара, повышенная потливость
~полидипсия и полиурия различные нарушения походки
~полиартрит и мышечная слабость
}

ИЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У
ДЕВОЧЕК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО БЫВАЕТ {

=вульвовагинит
~сальпингоофорит
~эндометрит
~бартолинит
}

ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ПЛОДА
ПРОВОДИТСЯ {

=глюкокортикоидами
~утеротониками
~антагонистами простагландинов
~антагонистами кальция
}

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА В АСФИКСИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
НЕОБХОДИМО {

=освободить дыхательные пути и желудок от содержимого
~срочно провести первичный туалет новорожденного
~начать ИВЛ
~ввести сердечные средства
}

ГАРДАСИЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНОЙ ПРОТИВ {

=вируса папилломы человека
~цитомегаловируса
~краснухи
~кори
}

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ
НЕ МЕНЕЕ (РАЗ) {

=2

~1
~7
~3
}

\$CATEGORY: Раздел_ХИРУРГИЯ

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МАЛИГНИЗАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=эндоскопический с биопсией
~рентгенологический
~ультразвуковой
~исследование кала на скрытую кровь
}

НАИБОЛЕЕ РАННИМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=механическая желтуха
~боль в эпигастрии и спине
~частая рвота
~потеря веса
}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=морфологический метод
~маммография
~УЗИ молочной железы
~пальпация молочной железы
}

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПИЩЕВОДА ПРИМЕНЯЕТСЯ {

=хирургическое лечение
~химиотерапевтическое лечение
~лучевая терапия
~комбинированное лечение
}

РАДИКАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=хирургическое вмешательство
~лучевая терапия
~химиотерапия
~иммунотерапия

}

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=хирургический

~химио-гормональный

~лучевой

~иммунотерапия

}

РЕАБИЛИТАЦИЮ БОЛЬНОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛЬЮ
СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ {

=с момента постановки диагноза

~в процессе проведения специальной терапии после окончания специальной
терапии

~спустя 2 года после окончания специального лечения

}

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ И РАКОМ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ {

=эндоскопическое исследование с биопсией

~рентгенологическое исследование

~исследование желудочной секреции с гистамином

~исследование кала на скрытую кровь

}

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА И КАРДИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ {

=циррозе печени

~вирусном гепатите

~метастатическом поражении печени

~болезни Кароли

}

ПИЩЕВОД БАРРЕТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МЕТАПЛАЗИЕЙ {

=многослойного плоского неороговевающего эпителия пищевода с развитием
цилиндрического эпителия кишечного типа

~многослойного плоского неороговевающего эпителия пищевода с развитием
цилиндрического эпителия с железами кардиального типа

~многослойного плоского неороговевающего эпителия пищевода с развитием
цилиндрического эпителия с железами фундального

(желудочного) типов

~эпителия желудка по кишечному типу

}

ДИВЕРТИКУЛОМ ЦЕНКЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ДИВЕРТИКУЛ {

=глоточно-пищеводный

~эпибронхиальный

~бифуркационный

~эпифрениальный

}

К СКРИНИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ {

=маммографию

~ультразвуковое исследование молочных желез

~самообследование

~осмотр маммологом

}

ПРИ КРОВЯНИСТЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ ИЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕДЕНИЕ {

=цитологического исследования отделяемого

~маммографии

~дуктографии

~ультразвукового исследования молочных желез

}

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=фиброколоноскопия

~ирригоскопия

~магнитно-резонансная томография

~исследование кала на скрытую кровь

}

СКРИНИНГОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ {

=кал на скрытую кровь

~фиброколоноскопия

~ирригоскопия

~ультразвуковое исследование толстой кишки

}

ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКОМ ДЛЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ {

=диффузный семейный полипоз

~одиночный полип

~неспецифический язвенный колит

~хронический колит

}

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С {

=ректального пальцевого исследования

~фиброколоноскопии

~ирригографии

~ректороманоскопии

}

НАИБОЛЕЕ РАННИМ СИМПТОМОМ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАКА В КАРДИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ {

=дисфагия

~боль в эпигастральной области

~боль за грудиной

~тошнота и рвота

}

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛЬ ПОЧКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ {

=ультразвуковое исследование

~компьютерную томографию

~объективный осмотр

~экскреторную рентгенографию

}

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РАК ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ {

=компьютерная томография органов грудной клетки

~рентгенография органов грудной клетки

~флюорография

~фибробронхоскопия

}

РЕШАЮЩИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ {

=фибробронхоскопия с биопсией

~рентгенография

~компьютерная томография

~бронхография

}

ПОД ТЕРМИНОМ «АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ» ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ОТНЯТИЕ КОНЕЧНОСТИ {

=на любом участке пораженного сегмента

~на протяжении той или иной кости (костей)
~между суставами
~на уровне суставов
}

ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО
СДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ {
=острая почечная недостаточность
~прогрессирующий травматический отек конечности
~некроз кожи и мышц конечности
~острая печеночная недостаточность
}

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНА В {
=старческом возрасте
~раннем возрасте
~юности
~среднем возрасте
}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СДАВЛЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ
ПРИ {
=землетрясении
~подводных работах на глубине
~пожарах
~автомобильных авариях
}

\$CATEGORY: Раздел_ОЗЗ

ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ)
ОРГАНИЗУЕТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ {
=II - III групп здоровья
~I группы здоровья
~I - II групп здоровья
~всех трех групп здоровья
}

НА ВЫДАЧУ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЕТ ПРАВО {
=частнопрактикующий врач при наличии соответствующей лицензии
~врач, не состоящий в штате медицинской организации (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность)
~врач станции переливания крови
~врач «скорой медицинской помощи»

}

УЧЕТНАЯ ФОРМА N 025/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» {

=заполняется на каждого впервые обратившегося за медицинской помощью в амбулаторных условиях пациента(ку)

~ведется на пациентов(ок), обращающихся за медицинской помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские организации или их структурные подразделения

~заводится отдельно каждым из врачей, проводящим лечение

~заполняется только при первом и завершающем посещении пациента

}

ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ В ПУНКТЕ 19 УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 025-1/У «ТАЛОН ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ПУНКТ {

=первичная врачебная медико-санитарная помощь

~первичная доврачебная медико-санитарная помощь

~первичная специализированная медико-санитарная помощь

~паллиативная медицинская помощь

}

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 030/У «КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ» НОМЕР КАРТЫ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НОМЕРУ {

=медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у)

~страхового медицинского полиса пациента

~СНИЛС пациента

~талона пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025-1/у)

}

УЧЕТНАЯ ФОРМА N 039-1/У-06 «ДНЕВНИК УЧЕТА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ УЧАСТКОВОЙ {

=ежедневно

~раз в неделю

~раз в месяц

~раз в квартал

}

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТРАВМ), ОТРАВЛЕНИЙ И ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО ВЫДАЕТ ГРАЖДАНАМ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ {

=сроком не более 15 дней

~сроком не более 5 дней

~сроком не более 10 дней

~на весь срок лечения

}

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ {

=врачебной комиссией

~лечащим врачом

~главным врачом

~заместителем главного врача по клинико-экспертной работе

}

ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ БЕЗ СРОКА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ {

=инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами

~инвалидам I группы

~детям-инвалидам

~инвалидам по профессиональному заболеванию

}

УЧАСТКОВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПМСП ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП ОБСЛУЖИВАЕМОГО КОНТИНГЕНТА {

=по признаку проживания (пребывания) на определенной территории

~по работе на предприятиях, находящихся на данной территории

~по признаку регистрации

~по желанию пациента

}

ОТБОР БОЛЬНЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ НА ДОМУ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ {

=врачей-терапевтов участковых и специалистов поликлиники

~заведующих отделениями поликлиники

~врачей дневного стационара поликлиники

~врачебной комиссии поликлиники

}

ОБЪЕКТОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ {

=все жители территории
~реконвалесценты острых заболеваний
~больные хроническими заболеваниями
~жители в трудоспособном возрасте
}

ПАЦИЕНТАМИ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА МОГУТ БЫТЬ {

=все возрастно-половые группы населения
~все взрослые
~взрослые, кроме беременных
~взрослые и подростки
}

К ВИДАМ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСЯТ {

=федеральную, территориальную
~муниципальную, территориальную
~внутриучрежденческую, муниципальную
~хозрасчетную, государственную
}

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОМС {

=является частью программы государственных гарантий
~включает программу государственных гарантий
~является частью территориальной программы государственных гарантий
~включает территориальную программу государственных гарантий
}

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ФОРМИРУЮТ {

=3 группы
~1 группу
~2 группы
~4 группы
}

КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТ {

=врач-терапевт участковый
~врач отделения медицинской профилактики
~врач дневного стационара
~врач-кардиолог поликлиники
}

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ {

=федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
~учреждениями медико-социальной экспертизы субъекта РФ

~городскими учреждениями медико-социальной экспертизы
~фондами ОМС
}

ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА {
=2 года
~1 год
~3 года
~бессрочно
}

ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА {
=1 год
~3 года
~Бессрочно
~2 года
}

СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В {
=процентах
~долях от целого
~десятичных долей
~субъективных характеристиках
}

ПОД ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ЧАСТОТА {
=новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном календарном году
выявленных среди населения заболеваний
~частота всех заболеваний, зарегистрированных за календарный год среди
населения
~частота острых заболеваний за календарный год, зарегистрированных среди
населения при проведении профилактических осмотров
~частота всех заболеваний и синдромов, зарегистрированных за календарный
год среди населения
}

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТ {
=при наступлении клинической ремиссии
~по просьбе больного
~по требованию администрации с места работы больного
~по просьбе родственников
}

ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ВРАЧ {

=сельской амбулатории

~станции переливания крови

~бальнеологической лечебницы

~судебно-медицинской экспертизы

}

ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА УДОСТОВЕРЯЕТ
СПРАВКА {

=Ф.095-у

~Ф.058-у

~Ф.030-у

~Ф.025-у

}

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ИМЕЮТ {

=ветераны боевых действий

~реабилитированные и репрессированные

~ветераны труда

~лица с системными заболеваниями соединительной ткани

}

ПО ХАРАКТЕРУ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ {

=частичной и полной

~временной и стойкой

~по общему заболеванию и по травме

~частичной и стойкой

}

СОГЛАСНО НОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ЭТАП/ЭТАПА {

=два

~три

~один

~четыре

}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В КРОВИ
ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ (ГОД) {

=старше 50

~старше 35

~до 45

~до 30

}

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ 1
РАЗ В {

=2 года

~3 года

~полгода

~год

}

В ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИБС ВХОДИТ {
=лечебная физкультура, дозированная ходьба, специальные физические
тренировки

~лечебная физкультура, дозированная ходьба, занятия в фитнес-центрах

~только лечебная физкультура и дозированная ходьба

~только лечебная физкультура и занятия в фитнес-центрах

}

АКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ ЛИЦ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРОФЕССИЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ,
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОТНОСИТСЯ К
ДИСПАНСЕРНЫМ ОСМОТРАМ {

=периодическим

~предварительным

~целевым

~профилактическим

}

ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ (ДЕНЬ) {

=15

~20

~10

~30

}

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН {

=если он является *работником российского предприятия*

~после оперативного вмешательства

~во всех случаях нетрудоспособности

~при заболевании туберкулезом

}

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ МОЖНО ВЫДАТЬ, ЕСЛИ {

=подтвержден факт нетрудоспособности накануне

~сохраняются признаки нетрудоспособности

~предшествующий день - выходной

~пациент находится в отпуске

}

ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАРУШЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ТРУДУ {

=носят временный, обратимый характер

~приняли стойкий необратимый характер

~приняли частично обратимый характер

~требуют смены трудовой деятельности

}

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН {

=обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если выявлены признаки временной нетрудоспособности

~проходящим медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов

~находящимся под административным арестом

~находящимся под стражей

}

ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ И РАБОТАЮЩИМ НА УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ {

=выдается на общих основаниях

~не выдается

~выдается на 10 дней

~выдается на 15 дней

}

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, НА КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, СОСТАВЛЯЕТ {

=15

~10

~20

~30

}

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВАЛИДОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ {

=неблагоприятный трудовой прогноз

~возраст пациента

~допущенные дефекты в лечении

~ходатайство предприятия, на котором работает больной

}

ФАКТОРОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ {

=«средиземноморская» диета

~курсовое голодание

~плазмаферез

~занятия «большим» спортом

}

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДОКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПОСРЕДСТВОМ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ПАЦИЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ {

=скрининг

~мониторинг

~первичная профилактика

~диспансеризация

}

ОТНОШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ДАННОМ ГОДУ, К СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННОЕ В ПРОМИЛЛЕ, НАЗЫВАЕТСЯ {

=общая заболеваемость

~первичная заболеваемость

~патологическая поражённость

~исчерпанная заболеваемость

}

К КАТЕГОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ «СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕТУ, ОТНОСИТСЯ {

=наркомания

~гипотиреоз

~описторхоз

~муковисцидоз

}

ПОД ДЕЛЕГИРОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПОНИМАЮТ {

=наделение правами и обязанностями какого-либо лица в сфере его компетенции
~предоставление полной свободы действий какому-либо лицу
~передачу части своей заработной платы подчиненным
~полное подчинение
}

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПОЛАГАЕТ {

=лицензирование и аккредитацию ресурсной базы учреждений здравоохранения
~оценку качества медицинской помощи по конечным результатам
~оценку соблюдения технологий лечебно-диагностического процесса
~расчет интегрального коэффициента эффективности
}

\$CATEGORY: Раздел_COVID-19

Наиболее эффективное профилактическое мероприятие при коронавирусной инфекции:

{
=Личная гигиена и средства индивидуальной защиты
~Наблюдение за контактными лицами
~Прием противовирусных препаратов с прямым действием
~Лабораторное обследование коллективов учреждений и предприятий, продолжающих работать в условиях пандемии
}

Какие клеточные структуры не являются входными воротами для возбудителя SARS-COV-2:{

~Эпителий верхних дыхательных путей
~Эпителиоциты желудка
~Эпителиоциты кишечника
=Клетки кожного эпителия
}

Окончательный диагноз инфекции, вызванной SARS-COV-2, устанавливается на основании:{

~Данных эпидемиологического анамнеза
~Клинического обследования и эпидемиологического анамнеза
=Молекулярно-генетического исследования (ПЦР)
~Магнитно-резонансной томографии органов грудной клетки
}

Определение подтвержденного случая заболевания COVID-19 включает:

{

~Обнаружение РНК SARS-COV-2 в сочетании с сухим кашлем и одышкой

=Обнаружение РНК SARS-COV-2 вне зависимости от наличия/отсутствия симптомов ОРЗ

~Обнаружение РНК SARS-COV-2 дважды в динамике обследования

~Обнаружение РНК SARS-COV-2 в лихорадочном периоде заболевания с симптомами ОРЗ

}

В патогенезе острого респираторного дистресс-синдрома, обусловленного SARS-COV-2, основную роль играет:{

=Избыточный ответ иммунной системы с синдромом высвобождения цитокинов

~Диарея

~Аспирация

~Бактериальная суперинфекция

}

По данным компьютерной томографии легких при инфекции, вызванной SARS-COV-2, у больных на ранних стадиях заболевания чаще выявляют:{

=Двусторонние субплевральные очаги по типу "матового стекла"

~Формирование очагов фиброза

~Односторонние инфильтративные изменения

~Односторонние очаги деструкции легочной ткани

}

Какова длительность наблюдения за контактировавшими с больным, инфицированным SARS-COV-2:{

=14 дней

~5-12 дней в зависимости от близости и длительности контакта

~21 день, если пациент вернулся из зарубежной поездки

~10 дней, если контакт был с больным родственником, проживающим в одной квартире с наблюдаемым

}

Какой вирус из семейства известных коронавирусов в настоящее время не циркулирует среди населения?{

~HCoV-229EВ

~HCoV-OC43

=SARS CoV

~HCoV-NKUI

}

Новую коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, необходимо дифференцировать: {

=С гриппом, ОРВИ, вирусными гастроэнтеритами, бактериальными респираторными инфекциями
~Бронхиальной астмой, ХОБЛ
~MERS-CoV, SARS-CoV
~Туберкулезом, MERS-CoV
}

Вirus SARS-CoV-2 относится к роду: {

~Alphacoronavirus
+Betacoronavirus
~Gammacoronavirus
~Deltacoronavirus
}

Ведущий путь передачи SARS-CoV-2: {

~Водный
~Парентеральный
=Воздушно-капельный
~Половой
}

Основная мишень SARS-CoV-2 в организме: {

=Альвеолярные клетки II типа
~Клетки эпидермиса
~Олигодендроциты
~Клетки мозгового вещества надпочечников
}

"Цитокиновый шторм" при COVID-19 приводит к развитию: {

~Гиповолемического шока
=Острого респираторного дистресс-синдрома
~Отека мозга
~Гепатоцеллюлярной карциномы
}

Клиническими проявлениями COVID-19 являются: {

~Частое мочеиспускание
=Аносмия
~Бессонница
~Боль в животе
}

Важным диагностическим симптомом COVID-19 является: {

~Дизартрия.
=Гипоксемия.
~Желтуха.
~Диплопия.
}

Пациентам с подозрением на COVID-19-пневмонию в обязательном порядке проводят:{

~Эзофагогастродуоденоскопию.
~Эхокардиографию.
=Компьютерную томографию легких.
~Ультразвуковое внутренних органов.
}

Лабораторная диагностика COVID-19 включает: {

~Вирусологический метод.
=Выявление РНК вируса методом полимеразной цепной реакции.
~Кожно-аллергический метод.
~Бактериологический метод.
}

Патогенетическое лечение COVID-19 включает: {

~Антибиотикотерапию.
~Назначение противовирусных препаратов.
=Оксигенотерапию.
}

Специфическая профилактика COVID-19: {

=Вакцинопрофилактика.
~Введение плазмы реконвалесцентов COVID-19.
~Введение нормального иммуноглобулина человека.
~Назначение противовирусных препаратов.
}

На сколько родов подразделяются коронавирусы: {

=Вакцинопрофилактика.
~Введение плазмы реконвалесцентов COVID-19.
~Введение нормального иммуноглобулина человека.
~Назначение противовирусных препаратов.
}

К какой группе патогенности отнесен SARS-CoV-2: {

~I
=II
~III

~IV
}

Когда ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19: {

~20 февраля 2020г
~13 января 2020г
=11 марта 2020г
~13 марта 2020г
}

Какие организмы являются естественными хозяевами большинства коронавирусов: {

~Птицы
~Рептилии
~Насекомые
=Млекопитающие
}

Кто является природным резервуаром возбудителя ТОРС: {

~Лошади
~Верблюды
~Грызуны
=Летучие мыши
}

Основной природный резервуар MERS-COV-вируса: {

~Зеленые мартышки
=Верблюды
~Многососковые крысы
~Песчанки
}

При COVID-19 возможны все пути заражения, кроме: {

~Воздушно-капельного
~Воздушно-пылевого
=Трансмиссивного
~Контактного
}

Укажите максимальный инкубационный период при COVID-19-инфекции: {

~1,5 месяца
~7 дней
~21 день
=14 дней

}

Назовите эпидемиологические данные, позволяющие квалифицировать клинический случай как подозрительный на COVID-19: {

- =Возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов
 - ~Употребление в пищу импортных морепродуктов за 14 дней до появления симптомов
 - ~Возраст старше 70 лет
 - ~Тесный контакт с больным ОРЗ, пневмонией
- }

Назовите эпидемиологические данные, позволяющие квалифицировать клинический случай как подозрительный на COVID-19: {

- ~Нахождение в хосписе, "домах престарелых" за последние 21 день
 - =Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз covid-19
 - ~Наличие тесных контактов с представителями определенных профессий (продавцы магазинов, работники аптек, медицинские работники и др.)
 - ~Возвращение из другого региона России за 14 дней до появления симптомов
- }

Основным методом лабораторного подтверждения COVID-19 является: {

- ~Бактериологическое исследование мокроты
 - ~РНИФ
 - =ПЦР респираторного образца
 - ~ИФА на IgM
- }

С целью дифференциальной диагностики обязательно проведение обследования на все инфекции, кроме: {

- ~Легионеллеза
 - ~Гриппа
 - ~Пневмококковой инфекции
 - =Менингококковой инфекции
- }

Какой вид материала является основным для исследования на коронавирусы: {

- ~Промывные воды бронхов
 - ~Цельная кровь
 - ~Сыворотка
 - =Материал мазка из носоглотки и/или ротоглотки
- }

Какой метод специфической лабораторной диагностики наиболее информативен в клинической практике при COVID-19: {

- ~Серологический (ИФА)
 - ~Бактериологический
 - ~Аллергологический (внутрикожная проба)
 - =Молекулярно-генетический (ПЦР)
- }

Порядок выписки пациентов с COVID-19: {

- ~Отсутствие клиники, контрольное лабораторное обследование не обязательно
 - ~Отсутствие клиники и однократный отрицательный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-COV-2 методом ПЦР
 - =Отсутствие клиники и двукратный (с интервалом не менее 1 дня) отрицательный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-COV-2 методом ПЦР
 - ~Достаточно клинического улучшения
- }

Каким препаратом возможно проведение медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых: {

- ~Эметином
 - ~Ремаксолом
 - ~Фенирамином
 - =Гидроксихлорохином
- }

Для медицинского персонала, занятого оказанием помощи больным COVID-19 обязательным СИЗ является: {

- ~Ватно-марлевая повязка
 - ~Хирургическая маска
 - =Респиратор со степенью защиты FFP2
 - ~Респиратор со степенью защиты FFP1
- }

Патологоанатомические вскрытия при COVID-19: {

- ~Не проводятся
 - ~Только судебно-медицинская экспертиза
 - =Обязательны, отмена не допускается
 - ~Труп подлежит немедленной кремации без вскрытия
- }

Устанавливается ли 14-дневное наблюдение за членами бригады, осуществляющей транспортировку больного COVID-19: {

- ~Только в случае транспортировки без транспортировочного изолирующего бокса
 - =Устанавливается в любом случае
 - ~Не устанавливается в любом случае
 - ~Только при отсутствии у членов бригады СИЗ
- }

Состав бригады медицинской эвакуации пациента с подозрением на COVID-19: {

- ~1 врач, 1 фельдшер
 - ~1 врач, 1 фельдшер, 1 санитар
 - =1 фельдшер, 1 санитар, 1 водитель
 - ~2 санитаря, 1 водитель
- }

Какое мероприятие не относится к средствам профилактики COVID-19 в отношении источника инфекции: {

- ~изоляция в боксированные помещения/палаты
 - ~назначение этиотропной терапии
 - =введение нормального иммуноглобулина
 - ~сбор сведений о контактных
- }

Какое мероприятие не относится к средствам профилактики COVID-19 в отношении механизма передачи инфекции: {

- ~соблюдение правил личной гигиены
 - ~использование одноразовых медицинских масок
 - ~проведение дезинфекционных мероприятий
 - =этиотропное лечение больного
- }

Какое мероприятие не относится к средствам профилактики COVID-19 в отношении механизма передачи инфекции: {

- ~использование СИЗ для медработников
 - ~соблюдение правил личной гигиены
 - ~проведение дезинфекционных мероприятий
 - =изоляция больного на 14 дней
- }

Какую группу препаратов применяют для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых: {

- ~аналоги нуклеозидов
- =интерфероны
- ~ингибиторы протеаз
- ~блокаторы сборки

}

Какой препарат применяют для постконтактной медикаментозной профилактики COVID-19 у медработников: {

- ~интерферон
 - ~иммуноглобулин
 - =гидроксихлорохин
 - ~рибавирин
- }

Кого в первую очередь извещает медицинский работник при выявлении пациента с COVID-19: {

- ~ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
 - =руководителя медицинской организации
 - ~Роспотребнадзор
 - ~Региональную противочумную станцию
- }

Какое первое мероприятие в порядке действий медицинского работника после медицинской эвакуации пациента с COVID-19: {

- =снятие СИЗ
 - ~обработка дез. раствором обуви и рук
 - ~обработка открытых участков тела
 - ~обработка рта, горла, носа и глаз
- }

Когда проводят заключительную дезинфекцию транспортного средства после эвакуации больного с COVID-19: {

- ~в конце рабочей смены
 - =немедленно после эвакуации больного
 - ~во время эвакуации больного
 - ~каждые полчаса рабочей смены
- }

Что не входит в перечень оснащения медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным и лицам с подозрением на COVID-19, согласно санитарным правилам: {

- ~неснижаемый запас СИЗ персонала
 - ~укладка для забора биологического материала
 - ~укладка со средствами экстренной профилактики медицинских работников;
 - =укладка со средствами специфической профилактики медицинских работников
- }

Нельзя повторно использовать респиратор FFP2 одним и тем же лицом в случае если респиратор: {

- ~обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая утечку воздуха под полумаску
 - ~не создаёт избыточного сопротивления дыханию из-за повышенной влажности
 - ~не имеет видимых следов контаминации биологическими жидкостями
 - =имеет следы физического повреждения
- }

После проведения вакцинации от COVID-19 пациент: {

- ~Должен находиться под наблюдением медицинского персонала 30 минут, вне зависимости от самочувствия
 - =Должен находиться под наблюдением медицинского персонала 10 минут, вне зависимости от самочувствия
 - ~Может сразу покинуть медицинское учреждение в случае хорошего самочувствия
 - ~Должен находиться под наблюдением медицинского персонала 20 минут, вне зависимости от самочувствия
- }

При снятии защитного костюма руки обрабатываются: {

- ~Только после полного снятия защитного костюма
 - ~После снятия каждой детали
 - =Снятие проводится в перчатках, поэтому не обрабатываются
- }

Средства индивидуальной защиты при работе с больными COVID-19 включают: {

- ~Медицинскую маску;
 - ~Халат
 - =Противочумный костюм 1 типа
- }

С какой целью производится гигиена рук после выноса судна пациента: {

- ~Защитить пациента, себя и окружающую среду
 - ~Защитить себя (медработника)
 - =Защитить себя (медработника), персонал и окружающую среду
- }

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции, вызванной SARS-CoV-2: {

- ~Отказ от использования общественного транспорта
- ~Использование СИЗ для медработников

=Использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 3 часа
}

Пациент с повышенной температурой или с признаками ОРВИ: {

~Не допускается в поликлинику
~Сопровождается в инфекционный бокс
=Сопровождается на прием к врачу вне очереди
}

Нормативный документ, обязательный к исполнению при работе с медицинскими отходами: {

~СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
=СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
~СанПиН 3.1.5. 2826-10 Профилактика ВИЧ- инфекции
}

После снятия комбинезона: {

~Его выворачивают наизнанку
=Его выворачивают лицевой стороной внутрь
~Не имеет значения
}

Абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 любой зарегистрированной вакциной являются: {

~Беременность
~Возраст старше 60 лет
=Острые инфекционные лихорадочные состояния
}

Условия хранения комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19: {

~При температуре не ниже минус 18 °С
~Хранение размороженного препарата допускается не более 30 минут;
=Хранение размороженного препарата допускается не более 15 минут
}

При входе в поликлинику пациента: {

~Осматривают на педикулез
~Осматривают слизистые
=Измеряют температуру тела
}

С источником инфекции COVID-19 поступают следующим образом: {

~Обеспечивают средствами индивидуальной защиты всех, кто контактировал с зараженным человеком

=Изолируют

~Обеззараживают личные вещи

}

Вакцину от COVID-19 «КовиВак» вводят: {

~двукратно с интервалом 30 дней

=двукратно с интервалом 14 дней

~однократно

}

При выявлении больного коронавирусной инфекцией: {

~Провести косметический ремонт палаты

~Провести внеочередной флюорографический осмотр медицинских работников

=Составить списки контактных лиц с указанием места жительства

}

Характерные клинические проявления COVID-19: {

~Боль в сердце

=Кашель, одышка

~Диарея

}

Для обработки слизистой глаз медперсонала при попадании биологического материала пациента, инфицированного COVID-19, используется: {

=Раствор борной кислоты

~Проточная вода

~Этиловый спирт

}

Правильная последовательность надевания средств индивидуальной защиты медперсоналом при работе с инфицированными COVID-19 включает: {

~1) перчатки; 2) халат; 3) маска или респиратор; 4) защитные очки

=1) халат; 2) маска или респиратор; 3) защитные очки; 4) перчатки

~1) защитные очки; 2) перчатки; 3) халат; 4) маска или респиратор

~1) маска или респиратор; 2) халат; 3) защитные очки; 4) перчатки

}

Длительность инкубационного периода при COVID-19: {

=до 14 дней

- ~6 месяцев
- ~1 день
- ~несколько часов

}

Основные симптомы бактериальной пневмонии: {

- ~высыпания на коже
- =инфильтративные изменения в легких
- ~сыпь
- ~диссеминированные изменения в легких

}

Основными критерием диагностики инфекции COVID-19 является: {

- ~рентгенологические изменения;
- ~повышенный уровень С-реактивного белка
- ~клинические проявления
- =ПЦР-диагностика в режиме реального времени

}

КТ-изменения, не характерные для COVID-19: {

- ~поражение периферических отделов
- =внутригрудная лимфаденопатия
- ~симптом «дерево-в почках»
- ~двусторонние изменения

}

Группы риска тяжелого течения заболевания, вызванного COVID-19: {

- =наличие сопутствующих хронических заболеваний (ХОБЛ, сахарный диабет, бронхиальная астма)
- ~лица с неопределенным местом жительства
- ~продавцы в магазинах
- ~работники здравоохранения

}

Основные рентгенологические изменения при пневмонии, вызванной COVID-19: {

- ~плевральный выпот
- ~симптом «дерева в почках»
- ~инфильтративные изменения в легких
- =распространённые участки «матового стекла»

}

Дифференциальный диагноз SARS-CoV-19 пневмонии не следует проводить с: {

- ~другими вирусными пневмониями

~организующейся пневмонией
=ХОБЛ
~бактериальной пневмонией
}

Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при COVID-19 является: {

~кровь
~бронхо-альвеолярный лаваж
=мазок из зева
~анализ кала
}

Основные лабораторные изменения, характерные при инфекции COVID-19: {

~протеинурия
=повышенный уровень С-реактивного белка
~тромбоцитоз
~лейкоцитоз
}

Подозрение на инфекцию COVID-19 может возникать при: {

~наличию укуса насекомого
~наличию односторонних изменений на рентгенограмме или КТ ОГК
=наличию клинических проявлений ОРВИ, бронхита, пневмонии;
~наличию контактов с зараженным животным
}

Основные лабораторные тесты, необходимые для оценки тяжести бактериальной пневмонии при COVID-19: {

~прокальцитонин
~общий анализ мочи
~клинический анализ крови
=С-реактивный белок
}

Основные клинические симптомы, не характерные для COVID-19: {

~лихорадка
=потливость
~сухой кашель
~одышка
}

Дифференциальную диагностику COVID-19 проводят с заболеваниями, протекающими с синдромом: {

~неврологическим
~обструктивным
~диспепсическим
=респираторным
}

Наиболее частым осложнением при COVID-19 является: {

~гайморит, ринит
~менингит, миокардит
~почечная недостаточность
=вирусная пневмония, ОРДС
}

Возможная этиотропная терапия COVID-19 включает: {

=хлорохин/гидроксихлорин
~ацикловир
~осельтамивир
~флуканозол
}

Вirus COVID-19 относится к роду: {

~альфа-герпесвирусам
~гамма-коронавирусы
~альфа-коронавируса
=бета-коронавирусы
}

Какой материал подходит для лабораторного исследования при COVID-19: {

~Сыворотка крови
~Кал
=Содержимое носоглотки
~Моча
}

Препарат, рекомендованный к применению при COVID-19 для купирования температуры: {

=Парацетамол
~Арбидол
~Анальгин
}

Источником инфекции при COVID-19 являются: {

=Люди
~Животные

~Насекомые
}

Оценить изменения в легких при COVID-19 помогают следующие методы: {

~УЗИ
~Биопсия
=Рентгенография
}

Инкубационный период при COVID-19 составляет: {

=До 2-х недель
~3 дня;
~1 месяц
}

В случае получения положительного или сомнительного результата на COVID-19 руководитель лаборатории организации обязан передать исследуемый материал в: {

=центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации
~ближайший территориальный орган Роспотребнадзора
~медицинскую организацию, предоставившую образец для лабораторного исследования
}

Каким пациентам с COVID-19 рекомендуется проведение компьютерной томографии: {

~пациентам с лабораторно подтвержденным наличием SARS-CoV-2
=пациентам с подозрением на пневмонию
~пациентам с легким течением COVID-19
~пациентам с подозрением на COVID-19
}

Кто осуществляет сбор клинического материала больных с COVID-19 и его упаковку: {

~медицинская сестра
~лечащий врач
=работник медицинской организации, обученный требованиям и правилам биологической безопасности при работе и сборе материала
~врач скорой помощи
}

Наиболее тяжелое течение COVID-19 наблюдается у: {

=пациентов старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями
~детей

- ~лиц моложе 40 лет
- ~беременных женщин
- }

Начальным этапом патогенеза COVID-19 является: {

- ~проникновение вируса в ликвор
- =проникновение вируса в клетки — мишени различных внутренних органов
- ~проникновение вируса в кровь
- ~проникновение вируса на слизистые носовой полости
- }

При развитии первых признаков острой дыхательной недостаточности необходимо: {

- ~протезировать респираторную функцию пациента
- ~интубировать трахею жестким бронхоскопом
- =начать оксигенотерапию через маску или носовые катетеры
- ~произвести трахеостомию
- }

Клинические особенности течение COVID - 19 у детей {

- =более легкое течение
- ~тяжелое течение с пневмонией
- ~клиника кишечной инфекцией
- ~ОРВИ с экзантемой
- }

Лица, прибывшие из стран, эндемичных по COVID - 19 получают лист нетрудоспособности: {

- =без посещения медицинской организации
- ~вне очереди
- ~после обязательных карантинных мероприятий
- ~на общих основаниях
- }

На какие бактериальные инфекции не обязательно проведение ПЦР-диагностики: {

- ~гемофильная палочка
- ~легионелла
- ~золотистый стафилококк
- =пневмококк
- }

Пациент с тяжелой формой COVID - 19, осложнённой вирусной пневмонией и ОРДС должен быть госпитализирован в: {

- ~инфекционную больницу под наблюдение врача-инфекциониста

~оставлен на амбулаторном лечении с ежедневным наблюдением участкового терапевта и консультацией инфекциониста
~палату интенсивной терапии под наблюдение врача-реаниматолога и терапевта
=инфекционную больницу в изолированный бокс отделения реанимации и интенсивной терапии под наблюдение врача-инфекциониста и врача-реаниматолога
}

При COVID-19 возможны все пути заражения, кроме: {

~Воздушно-капельного
~Воздушно-пылевого
=Трансмиссивного
~Контактного
}

Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при COVID-19 является: {

~кровь
~бронхо-альвеолярный лаваж
=мазок из зева
~анализ кала
}

Основным методом лабораторного подтверждения COVID-19 является: {

~Бактериологическое исследование мокроты
~Общий анализ крови
=ПЦР респираторного образца
~Реакция агглютинации
}